UNIVERSIDAD DE ORIENTE

CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS “MANUEL F. GRAN”

TITULO: FORMACIÓN ÉTICO-PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE DE MEDICINA DESDE HISTORIAS DE VIDA DE FIGURAS TRASCENDENTES

TESIS PRESENTADA EN OPCIÓN AL GRADO CIENTÍFICO DE

DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Autora: MSc. Yaité Zaldívar Rosales

Santiago de Cuba

2023

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS “MANUEL F. GRAN”

TITULO: FORMACIÓN ÉTICO-PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE DE MEDICINA DESDE HISTORIAS DE VIDA DE FIGURAS TRASCENDENTES

TESIS PRESENTADA EN OPCIÓN AL GRADO CIENTÍFICO DE

DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

AUTORA: MSc. Yaité Zaldívar Rosales

TUTORES: Prof. Titular. Homero Fuentes González (Dr. Cs.)

Prof. Titular. Lizette de la Concepción Pérez Martínez (Dr. C.)

Prof. Titular. María Eugenia García Céspedes (Dr. C.)

Santiago de Cuba

2023

Pensamiento

"En cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales, la Medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida, aún siendo un profesional ilustrado, porque un profesional de la Medicina sin humanismo solo será un brutal estudioso, sin la capacidad de comprender el dolor ajeno ni la espiritualidad humana".

René Favaloro

Dedicatoria

- Al amor de mi vida, mi hijo Cristhian Rafael Suárez Zaldívar por ser la luz de mi vida y mi fuerza para continuar, que esta tesis le ofrezca un modelo para su formación futura, que favorezca en su hacer y ser un mejor hombre.
- A mi madre Gertrudis Rosales Veras, por su ternura y dedicación familiar, sostén inigualable.
- A Juan Antonio Leyva Sánchez (JALS) por enseñarme siempre el camino de abordar la vida de manera diferente, por cultivar la posibilidad de hacer algo por un universo mejor, por brindarme siempre su ternura, cariño y estar al tanto de mis problemas, crecimiento personal y profesional.
- A mi esposo por su apoyo en cada circunstancia de la vida, por vivir a mi lado cada momento como si fuese el último.
- A mis hermanos que siempre han estado a mi lado y que han soportado mi luz encendida.
- A la vida, que me puso en el camino de Pepín, por su humildad, humanismo, compromiso, incondicionalidad y su consagración con la nueva y vieja generación, por saber conducirme acertadamente en cada entrevista, testimonios, por guiarme por el camino de las investigaciones históricas.
- A mi hermosa familia a quienes debo la vida.

Agradecimientos

Consciente de las bendiciones que Dios y la Vida me han dado, me complace enunciar mi más eterno agradecimiento a tantas personas que contribuyeron en este proceso de formación.

- Agradezco a mis tutores el Dr. Cs. Homero Calixto Fuente González y a la Dr. C. María Eugenia García Céspedes, a la Dr. C. Lizette de la Concepción Pérez Martínez por su valiosa asesoría y orientación para esta investigación.
- A mis compañeros del diplomado de Formación Científica como antecedente a esta formación doctoral, que tan gentilmente han contribuido a la construcción de nuevos conocimientos, emprendiendo otra etapa de formación en mi vida profesional, en particular a la Dr. C. Tatiana Marañón Cardonne, al Dr. C. Félix Lázaro Huepp Ramos, al Dr. C. Pedro Oropesa Roblejo, a la Dr. C. Zoila Luisa Cedeño Díaz, Al Dr. C. Ventura Puente Saní por sus consejos y su impulso en mi actuación profesional.
- A los brillantes profesores e investigadores del CEPED que tan gentilmente han contribuido a la realización de esta investigación.
- A la Dra. Mayelín Rodríguez Estinger, por su contribución tan oportuna.
- A los profesores y estudiantes del Hospital General Docente "Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso", sin cuya concurrencia no habría sido viable realizar esta investigación.
- A todas las personas, compañeros y amigos que confiaron y que me han apoyado durante estos años.
- A mi familia, razón de mi existir.

Muchas gracias a todos

Síntesis

SÍNTESIS

Esta investigación responde a la necesidad de transformar las insuficiencias en los comportamientos éticos del estudiante de Medicina, lo que limita su proyección en los escenarios profesionales, donde interactúa con el paciente y sus familiares. El objeto queda enmarcado en el proceso de formación del estudiante de Medicina y el campo en la dinámica de esta formación. Se aporta un modelo de la dinámica ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida, que se concreta en una metodología de Sistematización Generalizadora desde Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina. Lo anterior, contribuye a perfeccionar la formación ético-profesional del estudiante de Medicina, para una práctica clínico interventiva en la atención integral a pacientes desde los ejemplos Historias de Vida. La novedad científica consiste en revelar la esencia del humanismo médico en la dinámica de la formación ético-profesional del estudiante de Medicina, desde un enfoque socio-humanista, a través del empleo del método de Historias de Vida en coherente articulación con el método clínico-epidemiológico, al favorecer la apropiación de valores compromiso, consagración y humanismo desde lo académico y asistencial.

Índice

ÍNDICE

	Pág.
INTRODUCCIÓN	**1**
CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DEL PROCESO DE FORMACIÓN ÉTICO-PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE DE MEDICINA	**13**
1.1. Fundamentación epistemológica del proceso de formación ético-profesional del estudiante de Medicina	**13**
1.2. Tendencias históricas del proceso de formación ético-profesional del estudiante de Medicina	**28**
1.3. Caracterización del estado actual del proceso de la formación ético-profesional del estudiante de Medicina, en el Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso	**36**
Conclusiones parciales	**46**
CAPÍTULO 2 FORMACIÓN ÉTICO-PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE DE MEDICINA DESDE LOS EJEMPLOS DE HISTORIAS DE VIDA DE FIGURAS TRASCENDENTES DE LA MEDICINA	**47**
2.1. Fundamentación teórica del modelo de la dinámica ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida	**47**
2.2. Modelo de la dinámica ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida	**52**
2.3. Metodología de Sistematización Generalizadora desde Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina	**75**
Conclusiones parciales	**86**

CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA Y LA FACTIBILIDAD DEL MODELO DE LA DINÁMICA ÉTICO-PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE DE MEDICINA DESDE LOS EJEMPLOS DE HISTORIAS DE VIDA Y LA METODOLOGÍA PROPUESTA **88**

3.1 Valoración científico-metodológica de los aportes fundamentales de la investigación a partir de la realización de talleres de socialización con especialistas**.** **88**

3.2. Ejemplificación de la aplicación de la metodología para la formación ético-profesional del estudiante de Medicina y valoración de los resultados obtenidos en la práctica **93**

Conclusiones parciales **117**

CONCLUSIONES GENERALES **118**

RECOMENDACIONES **120**

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

Introducción

INTRODUCCIÓN

En la formación del médico se debe lograr desde su formación inicial sólidos conocimientos de lo relacionado con el comportamiento humano en su entorno social; habilidades específicas para aplicar el método clínico con enfoque epidemiológico y profundos valores morales esenciales, que tienen una connotación específica, pues coexisten los valores éticos o personológicos y los bioéticos o típicos de la profesión médica como par dialéctico, criterio que se comparte con Hodelín (2011); aúnque son morales devienen en profesionales desde el inicio de la carrera.

La exigencia de la formación ético-profesional del estudiante de Medicina, ante los dilemas actuales de la ciencia, constituye una las tareas priorizadas de las universidades cubanas y del país, debido a que ellos son los artífices y portavoces del Sistema de Salud Cubano y están llamados a interpretarlo, reconocerlo y perfeccionarlo en interés de toda la sociedad, así como dotar a los futuros profesionales de cualidades de alto significado humano y prepararlos para asumirsu autoeducación durante toda la vida.

Donde se desempeñen han de convertirse en un vehículo de transferencia y educación, lo que significa que tienen el compromiso de cumplir con el objeto social de su profesión siendo competentes, a consideración de esta autora, la competencia se expresa en las acciones del sujeto que da cuentas de su excelencia en su quehacer en contexto, al interactuar con eficiencia en los escenarios profesionales.

La educación médica cubana atraviesa una etapa importante de transformaciones. En la actualidad, el reto lo constituye la formación de profesionales con una adecuada y actualizada competencia científico-técnica, constituyen insumos imprescindibles para avanzar en el proceso de desarrollo, sobre todo, si se trata de un modelo de desarrollo como el que se formula en la Visión de la Nación, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista que la define como soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible.

Con futuros profesionales con cualidades humanas que favorezcan la relación médico-paciente-familia (Zaldívar, Fuentes y García, 2021); en aras de lograr eficazmente su encargo social. El proceso de formación del médico ha sido

analizado por varios investigadores, tales como: Ilizástigui y Douglas (1993b), Fernández (1999), Barber y Barber (2000), Pérez (2001), Izaguirre (2007), Lahera (2009), Ilizástigui (2010), Vidal (2011), Reyes (2012), Téllez (2012), Vallejo (2012), Brizuela (2012), Quertz (2013), Columbié y Columbié (2016), Puente (2018), Cedeño (2020), Mariscal (2022) entre otros.

Pero se requiere de una mayor atención en el orden práctico y epistemológico; pues si bien, se adentran en el continuo perfeccionamiento del proceso formativo del médico general, aún se requiere de una dirección pedagógica en correspondencia con la urgencia que impone el proceso formativo ético-profesional del estudiante de Medicina, no solo significa conocer los aspectos teóricos sino que hay que potenciar el enfoque valorativo del reconocimiento de su historia profesional, de sus figuras trascendentes de la Medicina, de sus valores revelado en su devenir profesional como ejemplo en este proceso de formación.

Dentro de las Ciencias Médicas, se adolece de conductas que expresen la verdadera realización de esta intensión, por lo que contribuir a la construcción de un proceso formativo de este profesional, desde una mirada más holístico, donde el estudiante sea capaz de reconocerse en su propio quehacer a partir de los ejemplos de figuras trascendentes de esta ciencia, nos permitirá favorecer el proceso formativo del estudiante de Medicina, así como en las carencias y limitaciones respecto al estudio de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, que son capaces de impulsar las masas sociales, reconocidos por su quehacer profesional y social en cada etapa vivida, desde un acercamiento empático a los problemas profesionales y sociales.

Ciertamente el estudio de figuras trascendentes de la Medicina, en relación con la **sistematización y generalización** de los aportes y su trascendencia en la formación profesional, se encuentra sesgado ante la insuficiente intencionalidad investigativa de carácter teórico, epistemológico y práctico. Estos argumentos dan cuenta de la necesidad de revelar nuevas formas y métodos que favorezcan el proceso formativo a partir de los ejemplos de figuras trascendentes, como modelo de profesional, reconociendo los valores compromiso, consagración y humanismo, por adquirir un significado profesional social e individual, que favorezcan los comportamientos éticos, con una implicación que permita trasformaciones innegables en el proceso formativo de este profesional.

Se considera que persiste una demanda intransigente de la sociedad, que se expresa en reclamos sociales en torno a los comportamientos éticos del estudiante de Medicina. Ello se debe a que su encargo social y modelo de profesional, los diferencia de otros profesionales en formación, según Cedeño (2020), se distinguen por los intereses sociales que existen sobre el rol que desempeñarán; al entenderse que la sociedad espera poder contar con un médico capacitado, que además sepa escuchar, sea un comunicador sensible, comprensivo, discreto y respetuoso en su accionar, lo cual en diversas ocasiones deja un contiguo de opiniones negativas debido a las expresiones que en realidad, denotan lo contrario.

Lo anterior, refleja las dificultades económicas, culturales, conflictos familiares y actitudes tradicionales de la sociedad en general, y la santiaguera en particular, registrado en los estudios realizados por la Comisión Permanente de Educación, Salud, Deporte, Cultura, Medio Ambiente y Ciencias de la Asamblea Provincial del Poder Popular, que atesora entre sus prioridades hasta el 2030.

En correspondencia con ello, en Cuba, las bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación hasta el 2030: Visión de la Nación, ejes y sectores estratégicos; aprobado en el 7mo Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC, 2017) plantea como uno de los ejes estratégicos el referido al Desarrollo Humano, equidad y justicia social, el cual contempla como primer objetivo general, promover el desarrollo integral y pleno de los seres humanos y considera la necesidad de preservar la educación que como política pública se orienta a "promover y reafirmar la formación de valores, prácticas, actitudes y modos que distinguen a nuestra sociedad: solidaridad, laboriosidad, altruismo, humanismo, justicia, compromiso, patriotismo, antimperialismo e internacionalismo; creando las condiciones para que sean reproducidos de manera natural y consciente por la propia dinámica social y se consolide su asimilación a escala social de valores colectivos" (PNDES, p. 21).

Por su parte, en la praxis del proceso de formación del estudiante de Medicina, en el Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso, en el periodo comprendido entre el 2016-2017 se realiza un diagnóstico fáctico, a través de la aplicación

de métodos y técnicas de investigación empíricos, que incluyeron: encuestas a estudiantes, a profesores a especialistas-docentes de diferentes escenarios formativos y a expertos responsabilizados con el trabajo educativo, todas ellas con el carácter de anonimato que permitió la veracidad de la información; por otra parte, se realizaron entrevistas a funcionarios del Ministerio de Salud Pública (Minsap) y de la Universidad de Ciencias Médicas.

Las observaciones sistemáticas en la formación ético-profesional del estudiante de Medicina en los escenarios profesionales (Anexo No. 1) acompañan el análisis de documentos y las encuestas a pacientes y familiares (Anexo No. 2), lo que nos permitió constatar una serie de manifestaciones externas que se revelan como insuficiencias, las cuales se expresan en:

- Irresponsabilidad e incumplimiento en la realización de las tareas designadas durante las actividades de educación en el trabajo.
- Actitudes interpersonales que reflejan apatía e indolencia en los espacios de interacción hospitalaria.
- Escaso compromiso en su quehacer profesional, expresión de endeble vocación de servicio al relacionarse con los pacientes y familiares.

Estas limitaciones conllevan a una revisión epistemológica en la presente investigación, desde un proceso de abstracción científica para reconocer como **problema de la investigación: Insuficiencias en los comportamientos éticos del estudiante de Medicina, lo que limita su proyección en los escenarios profesionales, donde interactúa con el paciente y sus familiares.** Esto expresa científicamente una contradicción epistémica entre la concreción asistencial de la formación ético-profesional y la práctica clínico-interventiva del estudiante de Medicina. Esta contradicción esta mediada por la intencionalidad de la valoración humanista en la atención integral a pacientes, durante la educación en el trabajo, como expresión más genuina del modelo pedagógico, concebido para la educación médica.

Autores como González (2002 y 2005) y Borges (2014), Puente (2018), entre otros, refieren que la formación en la educación médica tiene que ser invariable, como continuidad en la práctica ético-humanista en la profesión, que

aseveran su virtud en la actualización profesional ininterrumpida, lo que permite reconocer la importancia de una formación continua, permanente que sea un espacio de interacción significativa para el estudiante de Medicina, a la vez que desarrollen comportamientos éticos en los escenarios profesionales.

Desde estas consideraciones epistémicas, que marcan la impronta de una relación dialéctica, se llega a determinar en la lógica de la investigación científica una **valoración causal** dada en:

- Insuficiencias en la formación profesional del estudiante de Medicina, en relación con las exigencias de una auténtica vocación médica.
- Deficiente comprensión del perfil ético-profesional declarado en los planes de estudio para la carrera de Medicina.
- Mayor énfasis en las acciones y contenidos afines con el perfil ocupacional relacionados con la especialización, en desmedro de los contenidos relacionados con el perfil ético-profesional.
- Escasa presencia en el proceso formativo del estudio de las Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina y su ejemplo, en la labor educativa del profesional médico.

En correspondencia con ello, se ha precisado como **objeto de la investigación** el proceso de formación del estudiante de Medicina.

Es notable desarrollar en el proceso formativo la orientación hacia un enfoque integral para la labor educativa en la Educación Superior, se hace imprescindible la formación de un profesional que contribuya a la dirección del proceso, sustentada en una ética profesional médica. Autores como García (2002), Ferrero y Andrade (2007), y otros coinciden en que la formación ética médica debe sustentarse en la implicación humana del rol profesional.

Desde esta perspectiva, en la formación de pregrado, aún no se profundiza en las relaciones de la formación ético-profesional, con una mirada más concluida desde lo formativo-asistencial, que favorezcan en la formación del estudiante de Medicina. Las ciencias sociales y la Medicina como tal, requieren buscar en lo teórico, nuevos nexos y

sustentos, que contribuyan a una formación ético-profesional en consonancia con los cambios constante de la humanidad y de la sociedad cubana actual.

El estudiante de Medicina, necesita un tratamiento diferenciado, que le permita sentirse más seguro, acompañado, que le brinde espacios que le accedan apropiarse de comportamientos éticos en relación con su quehacer profesional, significando el humanismo médico, que debe distinguirlo dentro de otros profesionales, de ese compromiso y esa consagración con la profesión de la que tiene que estar dotado toda su vida.

Lo anterior, conduce a valorar la necesidad de articular una lógica formativa, a partir de los valores emergidos de Historias de Vida de figuras trascedentes de la Medicina, como ejemplo. Pues de alguna manera los estudiantes ponen su ilusión, su confianza y su inteligencia a disposición de la educación del profesor, el educador como ejemplo articula un pensamiento auténtico y su vida no solo es un ejemplo vital para sus estudiantes, sino que además les hace pensar en el hacer y ser de su comportamiento.

La credibilidad de un profesor va unida siempre a la conexión que muestra en su quehacer diario entre pensamiento y vida. Los estudiantes quieren profesores legítimos: solo en estos realmente confían y tienden a seguir su ejemplo. A su vez, la confianza de los estudiantes exige al profesor un programa de vida coherente, es decir, exige al profesor que viva lo que enseña o al menos procure vivirlo. En este sentido, el ejemplo del profesor es decisivo en su misión formadora: un profesor debe hacer de su ejercicio científico que ofrezca una valía reveladora y de su práctica docente un componente de servicio a los demás, todo lo cual permita favorecer la formación ético-profesional genuina en el proceso formativo.

Estas aspiraciones se favorecen a partir de formar profesionales integrales, convirtiéndose en el instrumento fundamental, dado su carácter desarrollador y sistemático, para satisfacer ese encargo social que le atribuye la sociedad y la profesión. El reconocimiento e integración de figuras trascedentes de la Medicina**,** que sirvan de paradigma en el proceso de formación ético-profesional, por medio de sus valores, de su comportamiento ético desde lo profesional y social, es decir, la resignificación de su condición humana, de cómo se comportó esa figura en cada

etapa de su vida profesional, aún no es suficientemente intencionada.

Es indiscutible que para tener una noción epistémica concreta de lo anteriormente planteado se requiere atender a la categoría **formación ético-profesional**, la cual tiene su connotación desde la Filosofía y otras ciencias como la Psicología y la Pedagogía. En esta última existen diversos criterios que han considerado a la formación como un proceso que ha adquirido gradualmente fuerza, máxime si las miradas trascienden por considerarla como la categoría que es propia de las Ciencias Pedagógicas y se encamina a significar la creación de un tipo de hombre de acuerdo con determinados ideales, objetivos y fines sociales.

Desde una perspectiva más totalizadora, la autora de esta investigación asevera, que es desde los comportamientos éticos, donde el profesional de la Medicina va dando significados y sentidos al modo de actuación, formando estos partes integrales del actuar de estos profesionales, respecto a las acciones realizadas en la atención integral a pacientes, como un proceso permanente, social y humano, que promueve las capacidades trasformadora, y determinan los comportamientos éticos mediante valores comprometidos con el modelo profesional.

Lo que considera la responsabilidad del individuo con respecto a los demás y para consigo mismo. Teniendo así, las adecuadas consideraciones dentro las reglas y normas que involucran al profesional dentro de la sociedad, en correspondencia con la aplicación de valores recíprocamente.

En la actualidad, con el perfeccionamiento del actual Plan de estudios de la carrera de Medicina, se ha declarado como estrategia curricular: El trabajo educativo y la formación ético-profesional y se han realizado algunas adecuaciones a las asignaturas de corte humanístico en función del modelo del profesional, aúnque permanecen las carencias para concebir de manera integrada y contextualizada, las formas y métodos para la formación ético-profesional del estudiante de Medicina.

Es válido advertir que, en relación con lo anterior, diversos investigadores como Brizuela (2012), Hernández (2015), Ojalvo (2018), Cedeño (2020) se refieren a los comportamientos y diseñan acciones para superar la tradicional

dicotomía entre la formación técnica y la humanista del estudiante universitario en general.

Al tener en cuenta lo anterior, se debe destacar que aún no se advierte el fortalecimiento del proceso de formación ético-profesional en la educación médica a partir de intencionar acciones desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, que se constituyan en paradigmas para los comportamientos éticos del estudiante en cuestión, como consecuencia del insuficiente énfasis en el desarrollo de cualidades morales que distinguen a un profesional, sobre el cual la sociedad deposita un alto grado de confianza.

Los aspectos antes señalados, muestran la necesidad de erradicar las insuficiencias en la construcción epistemológica y metodológica que persisten en el proceso de formación ético-profesional en la educación médica; pues las investigaciones realizadas, aún no abordan de manera suficiente el significado y sentido de las relaciones entre lo epistemológico, lo profesional, lo social e individual Lo anterior, conduce a valorar la necesidad de articular una lógica formativa, a partir de la relevancia de los valores, que sostienen las Historias de Vida de figuras trascedentes de la Medicina, como ejemplos a seguir.

Así se convierte en el vacío epistémico de esta investigación y permite orientar el objetivo de la investigación hacia la elaboración de una metodología de Sistematización Generalizadora desde Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, sustentada en un Modelo de la dinámica ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida. Por tanto, resulta imprescindible adentrarse en la formación ético-profesional con una concepción más trasformadora.

Se precisan rasgos que singularicen este proceso, entendiéndose sus comportamientos éticos. En este sentido, el quehacer educativo, desde el reconocimiento de figuras que han sido ejemplo por su trascendencia en la formación profesional, de viejas y nuevas generaciones, subyace tanto en lo profesional, como en lo individual desde las relaciones sociales médico-paciente-familia.

De manera que el **campo de acción** de esta investigación es la dinámica de formación ético-profesional del estudiante de Medicina. Ello da cuenta de la necesidad de un supuesto argumentado que permita concretarse en la investigación, en tal sentido se plantea como **hipótesis**: Si se aplica una metodología de Sistematización Generalizadora desde Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, sustentada en un modelo de la dinámica ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida, que tome en cuenta la relación dialéctica que se expresa entre la dimensión socio-humanista y la dimensión clínico-transformadora durante la educación en el trabajo, se puede contribuir a perfeccionar su proyección social en los escenarios profesionales, para lograr el objetivo propuesto y en correspondencia con la hipótesis que se plantea, se realizaron las siguientes **tareas científicas** en las diferentes etapas de la investigación:

1. Fundamentar epistemológicamente el proceso de formación ético-profesional del estudiante de Medicina.
2. Determinar las tendencias históricas del proceso de formación ético-profesional del estudiante de Medicina y su dinámica.
3. Caracterizar el estado actual del proceso de la formación ético-profesional del estudiante de Medicina, en el Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso.
4. Diseñar el modelo de la dinámica ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida.
5. Elaborar la metodología de Sistematización Generalizadora desde Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina.
6. Valorar la pertinencia y relevancia del modelo de la dinámica ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida y de la metodología propuesta.
7. Aplicación de la metodología de Sistematización Generalizadora desde Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina.

Métodos Teóricos:

-**Histórico-Lógico:** para la caracterización de las etapas históricas del objeto y del campo de la investigación.

-**Análisis-Síntesis:** para alcanzar conocimientos cualitativamente superiores del objeto y del campo en todo el proceso de investigación.

-**Holístico-Dialéctico:** en la construcción de toda la investigación, para elaborar y argumentar el modelo de la dinámica ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida, al revelar el sistema de relaciones propias de este proceso de formación ético-profesional, además de ser expresión de la lógica seguida en la construcción del conocimiento científico.

-**Sistémico estructural funcional:** en la elaboración de la metodología de Sistematización Generalizadora desde Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, al revelar la estructura de sus procedimientos y su funcionamiento.

-**Inductivo-Deductivo**: en el establecimiento de la hipótesis que se defiende y en la determinación de las categorías que emergen del objeto y del campo que se investiga.

- **Modelación:** para descubrir y estudiar nuevas relaciones y cualidades del objeto analizado.

Métodos y técnicas empíricas utilizadas:

-**Observación:** en la determinación del problema de la investigación. Para la caracterización actual del campo y para la evaluación de los resultados.

-**Encuestas:** para la caracterización del estado actual de la dinámica de la formación ético-profesional del estudiante de Medicina en su práctica profesional.

-**Entrevistas:** para recoger estados de opiniones como parte de la caracterización del estado actual del campo.

-Testimonios: para la recogida de información sobre los saberes médico pedagógicos de las Historias de Vida de figuras trascendentes y de aquellas personas claves que favorecen la labor educativa, dilucidado por medio de la triangulación de los testimonios.

-Historias de Vida: para revelar las acciones pedagógicas que caracterizaron el estudio de la vida profesional de las figuras trascendentes.

- Análisis documental: para obtener información en la caracterización del estado actual del campo.

-Criterio de expertos: para determinar, a partir de la valoración de expertos aquellos aspectos que deben ser tenidos en cuenta para enriquecer y/o modificar el modelo que se propone y la metodología

-Triangulación de información[1]: Estas triangulaciones se refieren a los métodos y técnicas utilizadas en la investigación y la obtención de los aspectos significativos a considerar de distintas fuentes, todo lo cual permite integrar los resultados y los confluencia de información científica obtenidos en todo el trascurso investigativo.

-Técnicas de estadística descriptiva: para procesar los resultados de los instrumentos de recolección de información.

Se utilizó además **el enfoque hermenéutico dialéctico**: para la comprensión, explicación e interpretación del objeto de investigación y su campo de acción, el cual permitió dinamizar la lógica científica desarrollada.

Los resultados científicos que aporta esta investigación son: El **aporte teórico** de la investigación está dado en el modelo de la dinámica ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida.

Como **aporte práctico** la metodología de Sistematización Generalizadora desde Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, que sirvan de incentivo para transformar su proyección social en los escenarios profesionales, donde interactúan con el paciente y sus familiares.

La **novedad científica** está dada en que se logra revelar la lógica de la formación ético-profesional del estudiante de Medicina, configurada desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, que con carácter profesional, social e individual se expresan en la construcción formativa de nuevas proyecciones en los escenarios profesionales.

La **significación práctica de la investigación** radica en que contribuye a dimensionar el proceso formativo del

[1] Estas triangulaciones se refieren a los métodos y técnicas utilizadas en la investigación y la obtención de los aspectos significativos a considerar de distintas fuentes, ello permite integrar los resultados y las confluencias de información científica obtenidos (nota de la autora).

estudiante de Medicina, al constituirse en una vía para sistematizar contenidos de la formación ético-profesional, que respaldan el encargo social, desde sus comportamientos éticos desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina.

El tema posee **actualidad**, pues responde a un proyecto institucional y regional, aprobado por el Centro de Investigación de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, inscripto en el registro de proyectos en salud (REPIS), para dar respuesta a demandas identificadas por la Entidad de Ciencia Tecnología e Innovación (ECTI), representado por la autora de esta investigación.

La tesis se estructura en introducción y tres capítulos, acorde con los tres eslabones en la lógica de investigación: facto-perceptible, de construcción teórica y de aplicación. Acerca de estos tres momentos se hacen conclusiones particulares; además, se concluye de manera general y se emiten recomendaciones pertinentes para el perfeccionamiento y la futura generalización de la metodología de Sistematización Generalizadora desde Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina.

Capítulo 1

Marco teórico referencial del proceso de formación ético–profesional del estudiante de Medicina

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DEL PROCESO DE FORMACIÓN ÉTICO-PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE DE MEDICINA

Dentro de este capítulo se realiza un análisis de los aspectos más importantes del proceso de formación del estudiante de Medicina, en aras de poder esclarecer los posicionamientos científicos acerca del mismo; se revelan las tendencias históricas y se caracteriza la situación actual del campo de la investigación. Este capítulo está dirigido, a enmarcar la necesidad, la justificación, los fundamentos y los argumentos en torno al problema de la investigación que redunda acerca del proceso de formación ético-profesional del estudiante de Medicina.

1.1. Fundamentación epistemológica del proceso de formación ético-profesional del estudiante de Medicina

Comprender e interpretar el proceso de formación ético-profesional del estudiante de Medicina, constituye un aspecto de gran importancia en las Ciencias Médicas ya que en la contemporaneidad se demanda un alto nivel de desarrollo en la formación de este profesional, que favorezca una mejor atención a los problemas de salud.

Al realizar la fundamentación epistemológica del proceso de formación ético-profesional del estudiante de Medicina, se revela categorías y referentes teóricos significativos. Se destacan, dentro de estos: la formación profesional, la formación en educación médica, la formación ético-profesional en educación médica, la ética, los valores, valores éticos, dinámica del proceso formativo, educación en el trabajo, método clínico y epidemiológico, Historias de Vida sistematización, generalizadora. Para su esclarecimiento, se asumen la Concepción Científica de lo Holístico Configuracional en la Educación Superior (Fuentes, 2011).

Es válido advertir que la formación ético-profesional del estudiante de Medicina constituye un proceso complejo, que demanda de una revalorización, tanto teórica como práctica, aún no existen estrategias, ni acciones precisas que dimensionen lo ético-profesional como un proceso integral.

El proceso de **formación profesional** como categoría, se expresa como el objeto de estudio de la Pedagogía en el

contexto de la Educación Superior, por Suárez, Moncada y del Toro (1999); Álvarez (1999, 2001); Suárez y del Toro (2011); Fuentes (2011, 2019); Horruitiner (2007); Paz, Venent, Ramos, Márquez y Orozco (2011); Vidal (2011), entre otros. Los citados autores coinciden en que es un proceso complejo, consciente y dinámico que permanece a lo largo de la vida, determinado por necesidades humanas, sociales e individuales, que implica el desarrollo del hombre y se proporciona a través de relaciones dialécticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre el profesor y el estudiante.

La formación es concebida como un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y experiencias a través de la actividad creadora de los sujetos, en ello coinciden investigadores como: Rojas (2003); Mendoza (2003); Fuentes (2006); Baxter (2007); Horruitiner (2007); Fuentes, y Álvarez (2008); Paz, Venent, Ramos, Márquez y Orozco (2011); Fuentes y Pérez (2012); y otros.

Estos autores significan, de una manera u otra, la necesaria contextualización de la formación desde lo pedagógico como un proceso asociado a la actuación de docentes y estudiantes en el contexto docente, extra docente y en la praxis en que se desempeñará el estudiante de Medicina, donde interactúa todo el equipo multidisciplinario de salud visto como la preparación para desempeñarse en el campo de la salud.

Al respecto la nueva universidad médica deberá hacer un énfasis especial en los aspectos educativos del proceso de formación de sus recursos humanos; pues se trata de lograr el salto cualitativo necesario que de solución definitiva el acceso a los servicios de salud con equidad para toda la población (Nogueira, Rivera y Blanco, 2005).

Esta nueva concepción para la **formación del Médico** incluye un rediseño en los programas tradicionales de las ciencias básicas, de manera que su redimensionamiento permita una mayor coherencia con los cambios que se producen con la concepción general del plan de estudios en los escenarios profesionales, las formas organizativas docentes, así como los métodos[2] de enseñanza.

[2] En este sentido, el papel del profesor como ejemplo y conductor del proceso desde los escenarios de trabajo se potencializa y su contacto sistemático con el estudiante es determinante no sólo como trasmisor de conocimientos sino como orientador y modelo profesional a seguir;

Autores como González (2002, 2004 y 2005), Chávez (2006), entre otros, han considerado la formación: como un proceso y como la categoría que es propia de las Ciencias Pedagógicas y se encamina a resignificar la creación de un tipo de hombre nuevo de acuerdo a determinados ideales, objetivos y fines sociales.

La autora de la actual investigación, considera que la formación es un complejo proceso de construcción activa de significados y sentidos de la subjetividad en relación con las influencias externas; sobreviene como un sistema integral al disponer de una preparación científica y técnica, reforzada en la formación de valores éticos y profesionales en todo el proceso formativo.

Se expresan en los criterios anteriores aspectos asociados al proceso formativo en los profesionales de las Ciencias Médicas que pueden ser resumidos en:

- Desarrollo de la individualidad humana e integridad de la personalidad.
- Reconocimiento de comportamientos éticos, a partir de modo de actuación en los escenarios profesionales donde interactúan con el paciente y sus familiares.
- Dirección del desarrollo y formación como ser espiritual.
- Proceso y resultado, cuya función es preparar al hombre en todos los aspectos de su personalidad.
- Promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.
- Pone al sujeto en condiciones de asumir una actitud transformadora.
- Contiene actividades organizadas, coherentes y sistemáticas.

El proceso formativo en la educación médica, se fundamenta en la solución de problemas inherentes a la realidad social y profesional que el estudiante enfrentará en su praxis; como también, en el desarrollo de habilidades y valores. En tal sentido, responden al método empleado y a la asimilación de contenidos impartidos en la formación profesional,

---

de ahí la necesidad de comprender que la base de esas proyecciones estará en primer lugar el ejemplo personal del profesor, se revela en su profesionalidad en la práctica clínica asistencial, con una mirada interventiva, que favorezca la calidad integral de la atención médica, que brinda a la comunidad, aprovecha con inteligencia y de forma planificada, todas las oportunidades para enseñar y educar desde la educación en el trabajo (nota de la autora).

lo que exige nuevas concepciones teóricas y metodológicas que sinteticen los comportamientos éticos, del compromiso, la consagración y el espíritu humanista de esta profesión.

De igual forma, los servicios de salud constituyan un vehículo fundamental para la formación del profesional de Medicina y escenario idóneo donde instrumentar la integración de lo docente, lo asistencial y lo investigativo como bien se establece en los postulados de Fernández (1999 y 2008); Salas y Salas (2012 y 2015); entre otros.

Por la importancia que este proceso reviste, se reconoce el valor de los criterios emitidos por los citados investigadores, quienes aportan aspectos significativos, desde el punto de vista teórico-pedagógico, a la interpretación de esta categoría. Sin embargo, se asume esta categoría desde una perspectiva más específica, como lo concierta Fuentes (2011) desde la concepción científica de lo Holístico Configuracional, la que posibilita una mayor comprensión del objeto y campo de esta investigación. Tributa una visión científica de la relación dialéctica entre lo holístico, lo complejo y el autodesarrollo de los procesos, consecuente con las ciencias, con la cual se sustenta el proceso de formación en la Educación Superior.

Se asume este enfoque, para la investigación, porque aporta: las categorías y niveles relacionales, los principios que sustentan la Pedagogía, tales como el principio pedagógico de la sistematización formativa intencional, este principio expresa el carácter de continuidad y consecutividad que debe tener el proceso formativo y humano de los profesionales en la educación superior, en función de perpetuar el desarrollo de lo humano universal.

Así también, el principio del carácter formativo del ser humano en su contexto socio cultural, el cual se dirige hacia un proceso de autodesarrollo y sustentabilidad social, desde su propia realidad. Dentro de la Pedagogía de la educación superior, se destaca, la ley de la formación intencional de la capacidad transformadora humana profesionalizante. Esta última, marca la dirección causal a través de la cual se ha de propiciar y gestar el proceso de formación de profesionales, como proceso que contribuye a la transformación de la capacidad transformadora humana, en el tiempo y el espacio en que se desarrolla.

Así, se convierte en fundamento la concepción de la enseñanza-autoaprendizaje que propone Suárez y Del Toro

(2011), como perspectiva que permite dinamizar la autogestión del aprendizaje de los estudiantes, como base de la personalización de sus roles, funciones y tareas, para el desempeño profesional en su contexto. Además, plantea que la formación es un proceso que se desarrolla con carácter permanente e implica preparar a los estudiantes para la producción de conocimientos sobre bases éticas. Es vista como un proceso de carácter reflexivo, aspectos que se transfieren en la presente investigación.

De ahí la necesidad de considerar la formación ético-profesional como trascendente en este proceso formativo, la educación superior médica tiene entre sus objetivos fundamentales la formación de un profesional en correspondencia con las necesidades de la sociedad y su época.

Por tanto se debe tener en cuenta que desde este proceso de formación profesional, incluye no sólo la asimilación de conocimientos, habilidades y destrezas, sino además el logro de una personalidad que como nivel superior de lo psíquico regule su conducta, y que vislumbre desde un sentido más humanista, el compromiso, la consagración como valores éticos que desarrollan y complementan otros valores compartidos de la profesión, significando la sensibilidad humana, como virtud humana superior, que es lo que hace que un hombre se comporte como un ser inestimable en cualquier de los contexto en el que este se desarrolle.

Con frecuencia en la literatura sobre la temática que se aborda, se identifican los conceptos Bioética y Bioética médica y/o Ética médica, sin embargo, en esta investigación, se parte de considerar la existencia de diferencias entre estos campos del quehacer ético actual, aún cuando se reconocen sus puntos de contacto.

La **ética**, como una de las disciplinas teóricas más antiguas cuyo objeto de estudio es la moral, ha adquirido desde la segunda mitad del siglo XX un avance incuestionable. En respuesta a la crisis ambiental contemporánea y a los muchos problemas que enfrenta la sociedad hoy, se manifiesta una tendencia al retorno a la Filosofía como una herramienta para resolver problemas prácticos y, dentro de ella a la Ética como una reflexión necesaria sobre el ser y el hacer en el mundo.

En este contexto, surge un ámbito completamente nuevo de exigencia de juicio y compromiso por cuanto no basta con la ética tradicional con respecto a las relaciones interhumanas, sino, que se empiezan a descubrir también, en relación con la naturaleza no humana deberes, valores y bienes que respetar. Siendo así, la ética se debe ocupar entonces de la relación entre las sociedades humanas y la naturaleza, y procurar el bienestar de ambas.

Investigadores consultados como Payá, Buxarrais, Martínez y Palos (2010), reconocen el desarrollo de la ética en vínculo no solo a la educación institucionalizada, sino a partir del papel de la familia y la sociedad en general; al considerar la relación ética-moral-sociedad señalan que no solo implica la labor educativa del maestro en el área cognitiva, sino también en otras áreas específicas asociadas al entorno sociocultural, o al afirmar, como Fabelo (2003), la dimensión subjetiva de **los valores,** dada por la forma en que estos son reflejados en la conciencia individual o colectiva, en lo que se encuentran dinamizando el modelo del profesional de la educación médica, los valores éticos **compromiso, consagración y humanismo.** Todo lo cual constituyen el núcleo que posibilita la educación de otros valores compartidos en el proceso formativo.

Ello, conduce a abordar la dimensión ética en la formación profesional, y se concreta en lo ético-profesional que implica considerar los valores de la profesión que va a desempeñar, su apropiación de manera reflexiva y crítica comprometido con la sociedad. De acuerdo con lo anterior, se concibe que la ética no puede prescindir de la parte afectiva o emotiva del ser humano ya que tiene como tarea esencial poner orden, organizar, otorgar significados y sentidos a los afectos o a las emociones, por lo cual se encuentra asociada a la labor del estudiante de Medicina.

Se asume desde una perspectiva más sólida que la formación ético-profesional constituye el eje principal del vínculo de la relación entre el saber hacer y entre el ser como sentido profesional, social e individual, tomando arraigo en el comportamiento humano y la sensibilidad humana. Se valora que son un conjunto de conocimientos, habilidades, valores y valoraciones encaminados al compromiso social y profesional responsable, a la emancipación, la autonomía y empatía, que promueve las capacidades trasformadoras, que hacen y mejoran al desarrollo de las actividades profesionales, y determinan los comportamientos éticos mediante valores comprometidos con la profesión.

Estos valores comprometido permite conducir a una persona u otro actor social, convivir conforme a lo erigido y bien visto en la sociedad, acceder al sujeto el desarrollo de sus potencialidades, en estrecho vínculo con las necesidades humanas colectivas y deben a esta su surgimiento, existencia y desarrollo.

De igual manera, se puede decir que la formación ético-profesional del estudiante de Medicina es necesario por el bien común, lo que favorece los conflictos personales y sociales. Lo que condiciona a que se muestre desde la práctica moral, reconociendo la naturaleza obligatoria de un comportamiento comprometido, responsable, que sea expresión de valores humanos significativos en relación con el modo de actuación de este profesional.

De manera que, si se tiene en cuenta desde la formación profesión el ideal del modelo social, desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, que han sido modelo de profesional, motivados en su compromiso profesional y social, su consagración y humanismo, entonces se podrá contribuir al profesional a que se aspira y requiere la sociedad.

Al abordarse la formación ético-profesional se hace referencia a los comportamientos éticos, manifiestos desde el modo de actuación con la profesión del estudiante de Medicina, lo que se considera como base esencial para una adecuada convivencia entre los seres humanos, del desarrollo de una posición trasformadora en su proyección socio-humanista, revelado en su atención integral a pacientes, con calidad, desde su actividad profesional y la práctica clínica trasformadora con una vínculo de lo interventivo en la educación en el trabajo.

Siguiendo las ideas anteriores se puede aseverar que el desarrollo de los valores éticos compromiso, consagración y humanismo**,** permitió el desarrollo de un conjunto de afirmaciones morales, a partir de los ejemplos de figuras trascendentes de la Medicina, con la pretensión de que sean admirados y asumidos por el estudiante universitario, de tal forma que favorezca a evitar diferencias, aversiones y contenciones en la sociedad.

En este sentido el aspecto teleológico ético en la formación del futuro profesional médico dirige y orienta las relaciones dialécticas entre la profesión médica en su esencia **ético-profesional-humanista**, el carácter socio-antropológico de la condición humana Fuentes (2011) que a juicio de este y otros autores se ha de enriquecer y singularizarse en

determinados contextos socioculturales, aspectos que considera entre sus fundamentos la orientación de búsqueda, comprensión, generalización intencional de la sistematización metodológica sobre la problemática de la formación en condiciones que permitan el logro de dicha finalidad.

La formación ético-profesional del estudiante Medicina constituye un aspecto transcendental en la educación médica y en su proyección en el marco de esta labor, desempeña una función fundamental en la formación de valores, por su capacidad movilizadora y motivadora, por constituir elemento esencial de las convicciones, por su impacto en la calidad del desempeño futuro del profesional y sobre todo como expresa Vitier (1996) "por ser antídoto contra muchos venenos, fuerza para resistir adversidades, capacidad para generar nuevos espacios de creación, libertad y gusto por la limpieza de la vida y promotores en fin del mejoramiento humano" (p. 21).

Partiendo de lo anteriormente expresado, puede considerarse entonces que la observancia de estas normas está profundamente vinculada al desarrollo de la autoconciencia, de la autovaloración, de las emociones, de las convicciones, de la voluntad y de la configuración de una sucesión de valores que van signando comportamientos éticos sistematizado, que se refiere a la existencia y esencia de este profesional, de esa sensibilidad humana y a esa espiritualidad de la que tiene que estar dotado toda su vida.

Por tanto puede ser trasmitida desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, que han sido modelo de profesionalidad, estas cualidades, se reconocen como reglas básicas en el proceso de formación de un profesional de alta valía, regulado mediante mecanismos, principios y normas de la profesión.

La reflexión desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de esta ciencia y de la resignificación de su comportamiento en su etapa profesional, dan cuenta del papel importante que esto adquiere en el proceso de formación ético-profesional del estudiante de Medicina, de ahí su significado en el proceso formativo profesional, como el camino para promover el ideal de sociedad que se aspira alcanzar, ya que no basta con promover la autonomía de las personas, también es preciso respetar y defender la identidad médica y el desarrollo integral de los pueblos, para lo cual es significativo considerar la educación en valores éticos.

En el proceso de formación ético-profesional del estudiante de Medicina, a través de los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, como modelo de profesionalidad se puede dirigir los comportamientos éticos, y valores reveladores del humanismo médico, emergidos de la Vida de estas figuras, como nuevas acciones que pueden transformarse en experiencias en sí mismas, las cuales pueden ser sistematizadas y de esta forma continuar construyendo conocimientos en el estudiante a niveles cada vez más elevados. Desde la propuesta transformadora, como llevar a la práctica acciones concretas que favorezcan el logro de los propósitos planteados como problema científico de esta investigación.

En tal sentido, es válido considerar desde el punto de vista pedagógico el ejemplo, desde su **labor educativa,** el docente tiene la responsabilidad de la calidad educativa. En concordancia con esta idea la autora de esta investigación reconoce que la actuación del docente en la formacióndel estudiante es primordial, servir de ejemplo cobra alta importancia en un vínculo pedagógica apropiado. El ejemplo del docente es una vía eficiente para desarrollar valores en todo el proceso formativo, y procurar adecuados patrones de conducta, lo que permite armonizar las relaciones profesionales,sociales e individuales.

La formación del docente universitario representa un gran desafío ante un contexto social dominado por el discurso de la globalización; por tal razón, el docente debe obtener una formación integral, asumida desde la perspectiva ética, pedagógica, científica, humanista y tecnológica (Espinoza, Granda y Ramírez, 2020).

La función básica de los docentes, estará dirigida por consiguiente, a fortalecer la capacidad de comprensión teórico-práctica del estudiante de Medicina, desde lo que significa disponer de una sólida preparación científica y técnica desde la **educación en el trabajo** como modelo pedagógico que ubica el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde las actividades docentes tienen un enfoque esencialmente orientador, con el estudiante como protagonista principal del aprendizaje a través del estudio independiente y la educación sistemática en el trabajo, bajo el de aprender

haciendo; lo cual requiere de nuevas proyecciones en las relaciones psicopedagógicas entre estudiante y profesor. El modelo de formación del profesional médico aún no integran los valores emergidos desde las Historias de Vida de figuras trascendentes como ejemplo en la labor educativa, que permitan favorecer el desarrollo de sus comportamientos éticos y el modo de actuación con la profesión, resignificando en los estudiantes valores esenciales, dirigido a potencializar la personalidad del estudiante.

Se asume la idea de Cedeño (2020) quien refiere que, en el proceso de formación de la personalidad del estudiante de Medicina, en especial su esfera moral, sin que se pretenda dividir el proceso artificialmente, se debe tener en cuenta que el sujeto que se recibe en la institución médica, ya posee un nivel de desarrollo, ha recibido numerosas influencias positivas y negativas, posee un conjunto de propiedades psicológicas que autorregulan el comportamiento del mismo. Además, tiene un conjunto de motivos e intereses que pueden o no corresponder con los valores de la sociedad y del modelo de profesional que se quiere alcanzar, pero que están presentes en él, convirtiéndose en autorreferentes.

Esto tiene significación social, espiritual, lo que representa desarrollar formas, métodos, procedimientos, acciones educativas que se adapten a las exigencias de la formación del estudiante de Medicina, a fin de que satisfaga las necesidades de la sociedad; por lo que se requiere de una integración coherente desde su proceso formativo donde el ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina sea el paradigma, integrando el ejemplo de comportamientos éticos y modo de actuación en su accionar. Sin embargo, todavía se evidencia insuficiencias, al no quedar bien definido desde los fundamentos pedagógicos, las diferentes maneras de incorporar el ejemplo de figuras trascendentes de la Medicina como modelo en la labor educativa.

La sociedad requiere docentes que sean guías en el proceso de formación del estudiante de estos tiempos, que correspondan a la práctica educativa y que generen credibilidad en los estudiantes.

El docente tiene la responsabilidad de ir más allá de la simple transmisión del conocimiento y es responsable de enseñar fuera del aula de clases, las acciones propias para que estas sean ejemplo para el estudiante. Su ejemplo es decisivo en la misión formadora para hacer pensar al estudiante, un docente debe cuidar la vida no solo intelectual

sino también el actuar, ético-docente

Es precisamente en el proceso de aprendizaje del estudiante de Medicina donde el docente puede promover diariamente con responsabilidad, la búsqueda de instrumentos coherentes y significativos en los estudiantes que realce su madurez moral en la práctica formativa, al mostrar compromiso, consagración, humanismo, y el bien común, contribuyendo a solucionar los problemas que se presentan de manera integral , intereses de conflicto que puedan darse, de ahí la necesidad de convertirlo en cimiento de la educación del mismo, al ponderar la relación valor-conducta-conocimiento.

Resulta meritorio destacar que la formación ético-profesional del estudiante de Medicina constituye una exigencia actual de la sociedad. Integrar en la formación del estudiante el ejemplo de la labor educativa de figuras trascendentes que han mediado en la formación del hombre nuevo, tiene en su centro su pertinencia en lo profesional, social e individual, al ser el comportamiento ético, herramienta que desarrolle la actividad formativa, pero no solo ello, sino que a su vez los propios estudiantes han de estar estimulados por una formación en el reconocimiento de aquellos que son modelo de profesión, traducido en compromiso, consagración, humanismo.

Según la doctora Baxter (2007), en Cuba la educación y la formación de la ética y de los valores en general es el resultado de una tradición, de aquellos que en el pasado legaron su ejemplo personal, sus inquietudes revolucionarias y, sobre todo, el sentido de justicia, compromiso, humanidad, libertad.

De ahí, que la formación ético-profesional sea una prioridad con vistas a que sus resultados contribuyan a perfeccionar la asistencia médica en los escenarios profesionales, donde interactúa con los pacientes y sus familiares**,** en la cual la relación médico-paciente-familia adquiere una relación profesional, social e individual del estudiante, en cómo estos asumen consigo mismo y con los sujetos que interactúan en la sociedad, comportamientos éticos coherentes con su encargo social, en íntima interrelación con su compromiso, el humanismo médico, la consagración en su quehacer, siendo responsable con la profesión y la sociedad.

La formación de lo ético-profesional debe estar fundamentada en favorecer las oportunidades adecuadas a los

estudiantes de manera individual y colectiva, en concordancia con Sánchez (2007 y 2015). Debe haber en la realidad valores, valoraciones asumidas; por tanto, el espacio de los mismos reside en lo distintivo de su quehacer profesional. Siguiendo esta misma idea, la autora de esta investigación refiere que, por medio de los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, se podrá favorecer a la formación ético-profesional del estudiante en cuestión, desde una concepción del humanismo médico más logrado. Todo lo cual permite en el estudiante, el reconocimiento de valores, comportamientos y modos desde los ejemplos como modelo a seguir, desde una interpretación crítica de experiencias confrotadas. La presencia del ejemplo de las figuras trascendentes de la Medicina, implica descubrimiento, autodesarrollo, crecimiento y conciencia de la existencia del estudiante, que trasciende desde lo profesional, social e individual.

Aún cuando se ha perfeccionado los programas de formación para médicos, existen insuficiencias en el desarrollo de las formas y métodos para el tratamiento del contenido ético-profesional y de valores emergidos de figuras trascendentes de la Medicina relacionados con el ejemplo de la labor educativa.

Ello quiere decir, que intrínsecamente en el proceso de formación del estudiante de Medicina es necesario buscar instrumentos que favorezcan la formación ético-profesional desde el ejemplo de la labor educativa de figuras trascendentes de la Medicina, inherente de un arraigo de la identidad médica.

De ahí, que se requiera de una dirección pedagógica en correspondencia con la urgencia que impone el proceso formativo ético-profesional en las universidades medicas cubanas, no solo significa conocer los aspectos teóricos sino que hay que potenciar el enfoque valorativo del reconocimiento de su historia profesional, de sus figuras como ejemplo, de los valores emergido del estudio de su Historia de Vida, que intervenga el amor profesional, en su actividad clínico trasformadora, con una visión interventiva a los problemas más generales en los escenarios profesionales, aplicando el método de enseñanza de la profesión **"el método clínico-epidemiológico",** con sus diferentes etapas y formas de organización docente, que le dan respuesta a los principales problemas de salud.

Es por tanto que, esta investigación apunta a la necesidad de un perfeccionamiento en el tratamiento de la concepción

del humanismo médico, para el desarrollo de formas y métodos en la formación ético-profesional en la educación en el trabajo, todo lo cual apunta a la necesidad del desarrollo de las habilidades específicas de la profesión desde los ejemplos de figuras trascendentes de la Medicinas, que han sido modelo de condición humana, bien lo anota Fuentes, Montoya y Fuentes (2010) en su concepción socio-antropológica de la condición humana.

Es criterio de la autora, que el estudiante de Medicina tiene que formarse bajo la conceptualización de una práctica clínico-interventiva con un juicio clínico científico, donde la intervención, como complemento esencial en este proceso, permite la valoración clínica o diagnóstica, que le permita al estudiante de Medicina en situaciones reales o modeladas, seleccionadas o diseñadas por el profesor, bajo su guía y supervisión, contar con la capacidad resolutiva necesaria en la atención integral a pacientes desde los primeros años de la carrera, por la significación social que inviste unadecuado modo de ser y hacer en los escenarios profesionales.

En la Ciencias Médicas se adolece de conductas que expresen la verdadera realización de esta intensión, por lo que contribuir a la construcción de un proceso formativo ético-profesional desde una mirada más holístico, donde el estudiante sea capaz de reconocerse en su propio quehacer, desde el ejemplo de figuras trascendentes de la Medicina que han sido modelo de profesional, con un humanismo médico signado en los comportamientos éticos, permitiendo la continua y sólida formación de muchas generaciones.

Ocupan un lugar destacado importantes figuras, como los doctores Eusebio Hernández, Carlos Juan Finlay, Fidel Ilizastegui Dupuy, Julio Martínez Páez, Raimundo Llanio Navarro, Pedro Kourí Esmeja, Ángel Arturo Aballí, Manuel Villar, Eduardo Bernabé Ordaz, Reinaldo Roca Goderich, Ramón Salas Perea, José Miguel Goderich Lalán, entre otros, por solo mencionar algunos en las especialidades de mayor relevancia, que desde su comportamiento humano, práctica médica y su labor educativa en las salas de hospitalización y en las aulas, con su ejemplo personal contribuyeron a la formación de generaciones de médicos, por lo que constituyen parte de la identidad médica de esta profesión, como acervo cultural de los valores morales profesionales.

Existen investigaciones en el orden científico y pedagógico, es el caso de autores como León (1995 y 2016) que abordó la obra de Salvador Massip; Sánchez (1998) investigó a Alfredo Miguel Aguayo; Asín (2018 y 2019) la cual

investigó las ideas pedagógicas del maestro santiaguero Juan Bautista Sagarra Blez, entre otras investigaciones como Senú (2011 y 2015), Fernández (2013), Mulén (2016), Orpí, Senú y Céspedes (2018) y más resiente Oliva (2022).

Tales investigaciones sirven de referentes teóricos para la continuidad de estudios de figuras trascendentes, como modelo de la formación de nuevas generaciones., en el campo de la formación del estudiante de Medicina en Cuba, no existen suficientes estudios que se reconozcan los valores emergidos de las Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, que desde su naturaleza médica, docente-asistencial, investigativa y gerencial hayan contribuido a la generalización de la labor médico-pedagógica de este proceso formativo.

Ciertamente el estudio histórico-pedagógico sobre el ejemplo de la labor educativa de figuras trascendentes de la Medicina en relación con la sistematización de **Historias de Vida** como método generalizador para el estudio de estos procesos, que convide a revelar nuevos conceptos y categorías, aún se encuentra sesgado ante la insuficiente intencionalidad investigativa de carácter teórico, epistemológico y práctico. La historia de vida como método es una descripción rigurosa, argumentada, literal y completa, que con mucha frecuencia solo quedan en lo descriptivo.

Estas ideas dan cuenta de la necesidad de significar nuevos presupuestos que contribuyan al reconocimiento de las Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, que han sido ejemplo desde su labor educativa, en su actuación profesional, lo cual permitirá trasformar los comportamientos éticos del estudiante de Medicina en los escenarios profesionales donde interactúa con el paciente y sus familiares.

En correspondencia con Ramos y López (2020) quien refiere que se necesita **sistematizar** el quehacer científico, pero no siempre se cuenta con las herramientas y la argumentación necesaria para ello, se significa la intencionalidad finalde la sistematización desde Expósito y González (2017), que plantea que desde la sistematización de experiencias el objeto a sistematizar es la propia práctica, y si bien puede llegar a un primer nivel de teorización y alimentar un diálogo crítico con el conocimiento teórico, no tiene pretensiones de generalización ni de universalización.

Esta se basa en una concepción metodológica dialéctica, que considera que los fenómenos sociales son históricos, cambiantes y contradictorios y que son una síntesis de múltiples factores y determinaciones estructurales y coyunturales; una concepción que vincula la práctica con la teoría.

Las ideas antes planteadas no contemplan la posibilidad de **generalización** desde la sistematización, no obstante, las posibilidades de los análisis heurísticos permiten avanzar en aportes teóricos durante el proceso investigativo, que pudieran enfocarse en una generalización una vez visualizado la posibilidad de su viabilidad en la práctica.

La posibilidad de dar seguimiento a las experiencias y aportes construidos para llegar a una propuesta de transformación, se proyecta desde la intención de generalizar las experiencias sistematizadas en un proceso investigativo del conocimiento y las prácticas que puedan incorporarse a la esfera social interesadas en esta área del conocimiento, aquí se resalta la importancia de socializar y generalizar los resultados.

Se introduce como categoría fundamental la sistematización científica, abordada por Fuentes (2011), Fuentes y Zaldívar (2019), como el proceso que se desarrolla a través de las vivencias profesionales sistematizadas con una intencionalidad, condiciona al desarrollo del proceso de investigación científico-profesional, que permite transitar por estadios cualitativamente diferentes y dialécticamente interrelacionados a través de los cuales se desarrolla la abstracción y generalización.

Por otra parte, la sistematización científica, revela las relaciones estructurales en el objeto (proceso) investigado que se sintetizan en relaciones más esenciales resultante del propio proceso de construcción del conocimiento científico. Entonces, se puede expresar que la sistematización científica le es inherente el pensamiento lógico, pues conlleva la abstracción y comparación, habilidades que sustentan a la generalización. Se erige sobre una objetividad que tiene por base a la dialéctica, como continuidad y ruptura, que permiten la estructuración y valoración, del objeto de conocimiento en un análisis-síntesis.

Se advierte la trascendencia de la sistematización como proceso para inferir resultados generalizables, y se incorpora

el concepto de experiencia, de ahí que se connote entonces a la sistematización de experiencias, que al decir de Mera (2019). Al sistematizar las experiencias se trata de entenderlas en el marco de un proceso histórico complejo en los que intervienen diferentes actores, que se realizan en un contexto económico-social determinado y en un momento institucional del cual el ser humano forma parte.

La generalización se desarrolla a través de las vivencias profesionales sistematizadas con una intencionalidad, con ello enfrentan retos en los cuales no basta con trasladar conocimientos científicos establecidos, sino replantear las propias estructuras de los conocimientos. Desarrollar un conocimiento generalizado significa apropiarse de la esencia del conocimiento de la realidad y por tanto conlleva la abstracción de lo no esencial.

Las Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, sintetizada en la obra de sus profesionales, y en los valores emergidos de su vida profesional, permite sistematizar la práctica educativa desde las experiencias a partir de la integración de las funciones universitarias.

Por tanto, en la sistematización se desarrolla la abstracción, dado que todo conocimiento científico sobre un determinado proceso, está necesariamente condicionado a los procedimientos de la abstracción, sin los cuales es imposible revelar la esencia del movimiento de dichos objetos, revelando sus relaciones y regularidades.

1.2 Tendencias históricas de la formación ético-profesional del estudiante de Medicina

Para realizar el análisis histórico del proceso de formación ético-profesional del estudiante de Medicina en Cuba se revisaron fuentes teóricas[3] como: literatura especializada, el programa de estudio de la carrera de Medicina desde sus inicios, así como artículos científicos relacionados sobre este tema.

Comprender la importancia de la formación ético-profesional del estudiante de Medicina, exige considerar la realidad actual de la educación médica para determinar qué criterios morales se les debe inculcar a los estudiantes durante su formación profesional como un componente integral, ya que las acciones médicas tendrán que diseñarse y ejecutarse

[3] Estas fuentes se erigen en fundamento o base teórica del análisis histórico-lógico que se realiza del objeto y campo de investigación, y resultaron importantes para la determinación de las etapas, los criterios históricos de Álvarez (2005) y Delgado (2009).

de acuerdo con los más elevados principios de la bioética, como corresponde al sistema social (León, 1995 y 2016; García, 2014).

Este debe desarrollarse como un proceso integral, donde el estudiante es capaz de perfeccionar y desempeñar una comprensión del entorno desde el auto perfeccionamiento constante de saberes, habilidades de saber hacer y saber ser, aplicando el método clínico y el epidemiológico como métodos científico para el estudio del proceso salud-enfermedad en el individuo, con vistas a conocer, valorar y transformar dicho proceso, por lo que el estudiante debe de generalizar sus actuaciones en el cuidado de la salud de los seres humanos enfermos.

Al tener en cuenta, de forma precisa, estos aspectos se configuran el estudio tendencial[4]. El **criterio** seleccionado para el análisis histórico tendencial fue:

Criterio de análisis: evolución de las aspiraciones formativas en la educación médica, con respecto a la formación ético-profesional.

Como indicadores en este estudio tendencial se consideran:

1. Principales normativas, resoluciones y programas de formación del estudiante de Medicina.
2. Enfoque conceptual metodológico de la formación ético-profesional desde el perfil médico.
3. Presencia de ejemplos de figuras trascendentes de la Medicina en el proceso formativo.

Por tal motivo, se ha establecido la delimitación de las etapas que, en esta investigación, dan cuenta del fundamento histórico lógico de la dinámica del proceso de formación ético-profesional del estudiante de Medicina.

[4] Es válido aclarar que se tuvo en cuenta Delgado (2009), quien divide en grandes períodos el proceso de formación médica, cada uno desde su perspectiva y potencial de la información, además de la interpretación que realizan a lo largo del tiempo, donde el primer autor precisa: un período colonial (1492-1899); un período burgués. (1902-1958) y un período revolucionario socialista (1959-hasta la actualidad) y el segundo autor precisa un Periodo Revolucionario Socialista donde refiere una tercera y cuarta etapa que comienza en la década de los 80 y en sus finales. Esto constituyó un paso significativo en la comprensión e interpretación de la formación ético -profesional del estudiante de Medicina ya que propició las bases históricas indispensables. Para los fines de esta investigación**,** se asume las últimas etapas del segundo y se precisan los períodos para la investigación que se presenta en la formación del estudiante de Medicina. En las Ciencias Médicas se han producido importantes cambios, sobre todo posteriores a la Revolución Cubana, dados por el propio proceso de perfeccionamiento del Sistema Nacional de Salud Pública.

Las **dos etapas**, diferenciadas por su propia particularidad son**:**

Etapa. I. (1991-2001) De consolidación de la formación ético-profesional, orientada desde la formación en valores.

Etapa II. (2001-2022) De redimensionamiento de la formación ético-profesional en la educación médica.

Antecedentes desde 1959 hasta1990. Se inició una nueva etapa de la educación médica universitaria, hubo un perfeccionamiento de diferentes planes de transición, aúnque no trasciende el desarrollo de las formas y métodos para el tratamiento de lo ético-profesional. Al tener en cuenta estos antecedentes nos permite reconocer el desarrollo de sus etapas como consecuencias del objeto estudiado.

Primera etapa (desde 1991 hasta 2001) De consolidación de la formación ético-profesional, orientada desde la formación en valores

Los estudios de Medicina se iniciaron formalmente en Cuba el 5 de enero de 1728, en la Universidad Real y Pontificia de San Jerónimo de La Habana. En la Facultad de Medicina en 1734 se pusieron en vigor sus estatutos y con ellos, el primer plan de estudios de Medicina. El mismo estaba organizado en cuatro cátedras: Prima (Fisiología), Vísperas (Patología), Anatomía y *Methodus Medendi* (Terapéutica) (Delgado, 2009).

La ética en la profesión, a pesar de ser curricular, en este momento era el resultado de la lucha entre el sistema de valores imperantes y la acción de ciertos sectores progresistas en que hubo muchas personalidades médicas cubanas que brillaron en la Oficina Sanitaria Internacional.

En esta etapa pre revolucionaria los valores del médico eran individualistas-elitistas, lo cual estaba en correspondencia con los valores ético-morales de su formación académica universitaria, que aludían fundamentalmente a ganancias económicas personales, o sea, alejado de la sensibilidad humana ante el dolor ajeno. La profesión médica era una mercancía y el paciente un cliente.

Con el triunfo de la Revolución en 1959 se inició una nueva etapa de la educación médica universitaria. La Universidad reabre sus puertas, estando en vigor aún el plan de estudio de Medicina de 1942 y se comienzan a desarrollar diferentes planes de transición, a fin de resolver las deudas contraídas durante los tres años del cierre de sus aulas.

En 1960 se inició la construcción de su sistema sanitario, que definió sus políticas a corto, mediano y largo plazos. El primer paso dado fue la creación del Ministerio de Salud Pública (Minsap) y se comienza a llevar la atención médica a todos los rincones del país (Salas y Salas, 2012 y 2015).

En este sentido, son recurrentes el análisis y apreciación histórica del proceso de formación de valores éticos en la educación médica cubana, los estudios teóricos de Arana (2006), Rodríguez (2006), Brizuela (2012), Quertz (2013), Columbié y Columbié (2016) y Puente (2018), Cedeño (2020) que posibilitan discernir las características de tal proceso, en el contexto que se analiza para esta investigación.

Los autores referenciados consideran, desde sus fundamentos que, a lo largo de los últimos años, el enorme desarrollo de los conocimientos científico-técnicos en el campo de la Medicina, ha facilitado que los objetivos de la formación médica de base, hayan experimentado transiciones para afrontar las contradicciones de la atención al ser humano en los escenarios profesionales, pero más bien desde la tradición de los códigos de ética médica. Cabe ponderar, que existe consenso en que la Medicina es un quehacer moral, una profesión cuyos miembros comulgan con una serie de principios fundamentales: no maleficencia, beneficencia, justicia autonomía destacándose como características fundamentales: el desarrollo de una ética manifiesta en la educación en valores, La veracidad de los datos, del derecho del paciente y sus allegados de conocer la verdad y las relaciones interpersonales adecuadas entre todos los actores. Aún en la formación ético-profesional no se ha intencionado una clara integración en los planes de estudio, que revele la objetividad de un proceso consecuente y concebido, como expresan Columbié y Columbié (2016) y Cedeño (2020), en sus criterios.

A partir de la década de los noventa la formación ética médica ha experimentado una acelerada expansión ya que se les dedica mayor atención a los problemas orientado al perfil ocupacional, sin una adecuada articulación que conduzca a comportamientos éticos que distingan el encargo social y profesional de e estos profesionales. En tanto a nivel mundial, la propia crisis social y la globalización neoliberal condiciona el deterioro de los valores, del compromiso, la consagración y el humanismo médico, de esa sensibilidad humana que tiene que estar dotado el sujeto, en especial

el profesional de la Medicina. Aún, con la pretensión de encaminar la formación-ético desde el perfil ético humanista en el modelo del profesional para la formación de médico, no se ha logrado la integración coherente a la trasmisión de los fundamentos éticos que se requieren en el proceso formativo.

En esta primera etapa después de la reforma universitaria de 1962, se restableció por muy poco tiempo la asignatura de historia de la Medicina, que abarca desde los tiempos primitivos hasta el renacimiento, lo que se invalida hasta nuestros días, el conocimiento de figuras trascedentes de la Medicina, así como el reconocimiento de los valores emergidos de las Historias de Vida de estas figuras como ejemplos en el proceso formativo.

En esta etapa, se trabaja con el siguiente sistema de valores: la responsabilidad, la dignidad, el patriotismo, solidaridad y la laboriosidad. Aparece el humanismo dentro del programa director para la formación de valores, como valor social a fortalecer, que se define teóricamente, desde este documento, como el amor hacia los seres humanos, y la preocupación por el desarrollo pleno de todos sobre la base de la justicia.

Este programa propone tratar el humanismo sobre la base de la ética de José Martí y Fidel Castro, lo cual se evidencia en las siguientes ideas: del primero: "La cobardía y la indiferencia no pueden ser nunca las leyes de la humanidad. Es necesario para ser servido de todos, servir a todos" (Martí, 1991, p. 85) y del segundo: "es ser tratados y tratar a los demás como seres humanos" (Castro, 2000, p. 4).

El referido programa marca nuevas consideraciones sobre la formación ético-profesional en esta etapa porque ofrece una definición operacional del modo de actuación asociados a este valor como tal, entre ellos se cuentan:

- Sentir los problemas de los demás como propios. Brindar afecto, comprensión, mostrar interés, preocupación, colaboración y entrega generosa hacia las personas.
- Respetar a las personas sobre la base del valor intrínseco del ser humano.
- Favorecer un clima de confianza, respeto y amistad entre las personas, en la familia, la comunidad, el colectivo estudiantil o laboral. Escuchar a las otras personas con empatía y comprensión, en el que puedan expresar sus opiniones, preferencias y sentimientos.

- Autocontrolar las expresiones de agresividad que puedan darse hacia otras personas, afectando su integridad física y moral.
- Ser altruista y desprendidos con absoluto desinterés.

El tratamiento didáctico-metodológico en el proceso formativo en la educación médica se precisa en armonía con las nuevas pretensiones sociales, se trabajó con empeño en esa dirección; en conjunto con el claustro de profesores y el colectivo estudiantil, formando parte esencial en dicha intención, no se logró satisfacer las demandas de integrar los problemas sanitarios del contexto comunitario y las misiones del proceso de formación del profesional médico, en las dimensiones formativas. Tal como lo consigna Brizuela (2012) en su investigación, este se lleva a cabo en diferentes escenarios, sin intencionalidad, lo que impedía el desarrollo continuo, sistemático e integrador de valores en los estudiantes.

En esta etapa se alcanzan resultados importantes en la labor social, desde el enfoque comunitario de la Medicina. Sin dudas expresa lo más valioso de las aspiraciones socio-ético con un carácter más humanizado, así aparece una nueva especialización médica con un enfoque socio-médico: la Medicina General Integral (1986-1997) y los planes de estudio B y C, donde la formación axiológica se centraba en el enfoque comunitario de la Medicina. Sin embargo, se considera que se desarticula las acciones educativas dirigidas al comportamiento ético y el modo de actuación del estudiante de Medicina.

Segunda etapa (2001-2022): De redimensionamiento de la formación ético-profesional en la educación médica

Si bien en la década de los ochenta y los noventas la formación del estudiante de Medicina fue espontánea y fragmentada, caracterizada por la ausencia de documentaciones normativas precisas, se comienza un período de perfeccionamiento del proceso enseñanza aprendizaje en las Universidades médicas en Cuba; se fortaleció e incrementó la educación en el trabajo en los servicios de salud, vinculándolo más a la atención primaria de salud; y se impulsó el desarrollo de métodos activos, problémicos en la casi totalidad de las asignaturas; se perfeccionaron los

programas de las asignaturas y estancias, así como el del internado rotatorio; se fortaleció el sistema de evaluación del aprendizaje, estableciéndose progresivamente la realización de evaluaciones externas.

Ya en esta etapa se redimensiona el proceso formativo con el fortalecimiento de la educación médica, desarrollando en el 2001 la descentralización de la formación clínica hacia los municipios del país, con el fin de incrementar la calidad de la formación profesional de pregrado y posgrado.

Al mismo tiempo se funda la Facultad Caribeña de Medicina en Santiago de Cuba, para estudiantes, fundamentalmente, de Haití. A partir del año 2002 se incorporan crecientemente estudiantes de países africanos como Mali, Guinea Conakry, D'Jibouti, Sierra Leona, Tanzania. Más adelante entrarían, Jamaica, Guyana, Togo, Perú y Angola, con ello la educación médica exhibe su realización en la formación ético-profesional.

Al atender el enfoque conceptual metodológico de la formación ético-profesional en el proceso docente-educativo del médico, que constituye el segundo indicador propuesto para el análisis histórico tendencial, cabe enfatizar que en esta etapa se crea en el 2004 desde la estrategia de atención primaria de salud, el policlínico universitario, con el fin de incrementar la calidad de la formación profesional de pregrado y postgrado. Surge la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), hecho sin precedentes en la historia cubana y universal, se considera la mayor muestra de expresión de los valores éticos en el ámbito de la Medicina.

Los planes de formación médica respondieron a la necesidad de formación de becarios extranjeros dentro y fuera del país, experiencia que se extendió al currículo que se impartía en Cuba. En el año 2005, en la República Bolivariana de Venezuela, se decidió diseñar, en el contexto del ALBA y como parte de la oferta académica de la Misión Sucre, el Programa Nacional Formativo del Médico Integral Comunitario (PNFMIC) introdujo cambios sustanciales, donde el profesor principal responsable de la formación de este médico es fundamentalmente el especialista de Medicina General.

En esta etapa, es relevante el interés por perfeccionar el proceso formativo en todos los escenarios a través de talleres territoriales y nacionales, existen mejoras en la planificación, organización y control de la labor educativa y

político-ideológica, con la constitución de comisiones de trabajo. La misión principal del Destacamento Dr. Carlos Juan Finlay se centraba en la lucha por la ética profesional y la excelencia en los servicios de salud, es creciente el interés en la formación ético-profesional del futuro médico cubano. El sistema de valores que se trabaja, además de los de períodos anteriores, incluye ahora la justicia, entendida como el respeto a la igualdad social.

A partir del año 2016, se marca un nuevo hecho en la educación médica, en el mismo se aspira a la formación de un modelo de profesional que se connota como: médico general con sólida preparación científica, ético humanistay revolucionaria. El mismo incluye tres perfiles que se definen como: ético humanista, profesional y ocupacional. Su sistema de valores está conformado por todos lo anterior además de la inserción de la honradez, la honestidad y el humanismo.

Actualmente en el proceso formativo del estudiante de Medicina está vigente el Plan D y se aplica el E en los primeros años de la carrera de estudio para todas las universidades del país, en el que la formación en valores esenciales del médico se lleva a cabo a través de la educación en el trabajo, fundamentalmente para el logro de habilidades y competencias profesionales orientada al perfil ocupacional, sin la adecuada articulación que conduzca a comportamientos éticos que distingan el encargo social y profesional del estudiante de Medicina.

En la actualidad, bajo el perfeccionamiento del vigente Plan de estudios de la carrera de Medicina, se perfecciona el E, en el que se ha declarado como estrategia curricular el trabajo educativo y la formación ético humanista, aúnque han desarrollado algunos ajustes a las asignaturas de corte humanístico en función del modelo del profesional, permanecen las carencias para concebir de manera sistémica, integrada y contextualizada la formación ético-profesional en el proceso formativo del médico. No se tienen en cuenta desde la labor educativa el ejemplo de figuras trascendentes de la Medicina.

De manera general, el proceso de formación ético-profesional se ha visto distinguido desde su concepción en un currículo inmaterial, lo cual determina que fuera atravesando por variaciones entre su concepción extracurricular y el aumento de contenidos y acciones médico sociales, ponderando las funciones desde el perfil ocupacional, hasta

el actual perfeccionamiento del Plan de estudios de la carrera de Medicina.

Aún existen insuficiencias en la articulación de un desarrollo de formas y métodos para el tratamiento del contenido ético-profesional y de los valores emergidos de las Historias de Vida de figuras trascendente de la Medicina, como ejemplos en el proceso formativo.

El análisis histórico tendencial realizado revela, mediante las dos etapas seleccionadas en la orientación del proceso de formación ético-profesional del estudiante de Medicina en Cuba, el movimiento tendencial del objeto de investigación, lo cual ha posibilitado distinguir la evolución del referido proceso:

- Se ha transitado desde un proceso de formación ético-profesional centrado en acciones médico sociales, en respuesta a situaciones emergentes del país, hacia: Una formación ético-profesional orientada al perfil ocupacional, sin la adecuada articulación que conduzca a comportamientos éticos que distingan el encargo social y profesional del estudiante de Medicina.
- Desde un perfeccionamiento de los programas de formación del estudiante de Medicina, sin un adecuado desarrollo de las formas y métodos para el tratamiento del contenido ético-profesional. A un proceso con invalidada participación del estudiante de Medicina, en el reconocimiento de los valores emergidos de las Historias de Vida de figuras trascendente de la Medicina, como ejemplos en el proceso formativo.

1.3 Caracterización del estado actual del proceso de la formación ético-profesional del estudiante de Medicina, en el Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso

En este contexto se ha ido trabajando en el Hospital General Docente "Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso" de Santiago de Cuba, en la formación ético-profesional del estudiante de Medicina, la institución es Entidad Auspiciadora de la Academia de Ciencias, Entidad de Innovación Tecnológica y Hospital Universitario, con formación de estudiantes de pregrado desde el tercer año de la carrera y posgrado.

El diagnóstico se llevó a cabo en el curso 2016-2017 en un total de 136 estudiantes de tercero y cuarto año de la carrera de Medicina. Para reconocer la situación actual que presenta la dinámica del proceso de formación ético-

profesional del estudiante en cuestión, se realizó una observación, encubierta, discreta, participante a través de una guía de observación directa en las actividades de educación en el trabajo a 14 estudiantes (Anexo No. 1), que constituyó una muestra intencional de 136 estudiantes de tercero a sexto año de la carrera de Medicina. así como la aplicación de una encuesta a pacientes y familiares (Anexo No. 2), motivada por las insuficiencias presentes en el desarrollo de este proceso formativo, cuyo diagnóstico se reflejó en las manifestaciones externas, permitió reconocer el problema de investigación y determinar sus principales causas, expuestas en la introducción.

Se asume como criterio por parte de la investigadora, seleccionar la misma muestra para caracterizar el estado actual del campo de esta investigación y de este modo, viabilizar un proceso de sistematización investigativa para un mayor acercamiento en la indagación científica.

Los métodos y técnicas científicas utilizadas se sustentan en un proceso de continuidad en la valoración científica que se realiza en las diferentes etapas de desarrollo de esta investigación. Ello permite contrastar los resultados del diagnóstico expresado en las manifestaciones externas del problema y en la caracterización actual del campo de investigación.

Se realiza un diagnóstico que tuvo en cuenta los siguientes criterios:

1. Importancia que el estudiante atribuyen a su formación ético-profesional, para la solución de problemas profesionales en los escenarios profesionales.
2. Acciones intencionadas a potenciar comportamientos éticos del estudiante desde los ejemplos de figuras trascendentes de la Medicina y su modo de actuación en los escenarios profesionales durante la educación en el trabajo.
3. Vías y métodos para la formación ética y tratamiento del desarrollo de valores por los profesores (curricular extracurricular).

Para la realización de este diagnóstico se utilizaron los métodos empíricos siguientes:

- Revisión y análisis de documentos normativos.

- Aplicación de una guía de observación sistemática en los escenarios profesionales a 14 estudiantes en las actividades durante la educación en el trabajo (Anexo No. 3).
- Se aplica una escala auto-calificativa[5] (Anexo No. 4). Este instrumento detecta el grado en que el estudiante presenta el rasgo evaluado en 2 puntos para bueno, en 1 punto para regular y en 0 para malo. Se realiza la suma de todas las puntuaciones obtenidas en cada ítem: de 16-20 puntos: comportamientos éticos y modo de actuación en los escenarios profesionales. Adecuados. de 11-15 puntos: comportamientos éticos y modo de actuación en los escenarios profesionales y poco adecuados 0-10 puntos: comportamientos éticos y modo de actuación en los escenarios profesionales inadecuados. (Anexo No. 5).
- Entrevista a especialistas-docentes y profesores de varios servicios de la institución (Anexo No. 6).
- Aplicación de entrevistas a 10 autoridades administrativa de salud de la Universidad de Ciencias Médicas (Anexo No. 7).

Se selecciona a 10 directivos de la Universidad de Ciencias Médicas y de la Dirección Provincial de salud, por su nivel de influencia en la toma de decisiones con respecto a los procesos formativos y 50 especialistas-docentes[6], de diferentes Servicios. De los cuales 10 son de Medicina Interna, Ginecobstetricia 8, Psiquiatría 2, Terapia Intensiva 4, Anestesia y Reanimación 5, Dermatología 4, Ortopedia y Traumatología 5, Gerontología 2, de Cirugía 5 y de Neurología 5. Que interactúan de manera directa con los estudiantes seleccionados en los diferentes escenarios

[5]Este instrumento detecta el grado en que el estudiante presenta el rasgo evaluado, manifiesto en sus comportamientos éticos, modo de actuación en los escenarios profesionales durante las actividades de educación en el trabajo. Para realizar la autoevaluación se utilizaron los siguientes niveles: bueno, regular y malo que permite al estudiante autoevaluarse según el nivel en que se identifican los estudiantes de Medicina (nota de la autora).

Especialistas-docentes. Profesional médico capacitado y facultado, que imparte conocimientos, valores y da herramientas desde las bases de su especialización, destinados a evaluar integralmente las afecciones y mejorar el estudio de salud del paciente desde su práctica médica asistencial (nota de la autora).

formativos donde se concreta la educación en el trabajo, atendiendo a su implicación en el trabajo educativo (Tabla 1.3.1).

Tabla 1.3.1. Representación gráfica de la selección de la muestra de investigación

Muestra de docentes seleccionados para diagnóstico del proceso de formación ético-profesional	**Cant.**	**%**
Especialista Docente en el servicio de Medicina Interna	10	16,66
Especialistas Docentes en el servicio de Ginecobstetricia	8	13,3
Especialistas Docentes en el servicio de Psiquiatría	2	3,3
Especialistas Docentes en el servicio Terapia Intensiva	4	6,66
Especialistas Docentes en el servicio de Anestesia y Reanimación	5	8,33
Especialista Docente en el servicio de Dermatología	4	6,66
Especialista Docente en el servicio de Ortopedia y traumatología	5	8,33
Especialista Docente en el servicio de Gerontología	2	3,3
Especialista Docente en el servicio de Neurología	5	8,33
Especialista Docente en el servicio de Cirugía General	5	8,33
Autoridades administrativa de salud	10	16,6

Atendiendo a la tabla anterior, se puede precisar que del total de la muestra de especialistas-docentes, de ellos 10 que representan el 16,66 % de Medicina Interna, 8 (13,3 %) Ginecobstetricia, 2 (3,3 %) de Psiquiatría, 4 (6,66 %) Terapia Intensiva, 5 (8,33 %), 4 (6.66%) de Anestesia y Reanimación, 5 (8,33 %) Ortopedia y traumatología, 2 (3,3 %) Gerontología, 5 (8,33%) Neurología, 5 (8,33 %) Cirugía General; y 10 (16,66 %) autoridades administrativas de salud**.** Es oportuno señalar que no se constata diseños estratégicos para la formación ético-profesional en la universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, y menos en el contexto hospitalario, son insuficientes los estudios sobre los valores revelado desde las Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina y del reconocimiento de su ejemplo desde la labor educativa.

La escala auto-calificativa en relación con la encuesta aplicada a los estudiantes de Medicina nos permitió triangular los resultados y corroborar las insuficiencias en el proceso formativo.Para evaluar la aplicación de esta escala se

precisaron tres niveles para cada ítems, el estudiante que se encontró en el nivel bueno se le otorgó una calificación de dos puntos, para el nivel regular un punto y para el malo cero puntos, al finalizar la evaluación de los ítems se sumaron las puntuaciones para evaluar como adecuado o no adecuado. Se consideró adecuado si la puntuación total de la escala auto-calificativa superaba los 16 puntos y no adecuado los estudiantes que se auto-califiquen por debajo de esta puntuación (Anexo No. 4).

- Nivel bueno (valor de 2 puntos): cuando el estudiante reconoce que integra sus comportamientos éticos y modo de actuación elementos que caracterizan los valores éticos en los escenarios profesionales.
- Nivel regular (valor de 1 punto): cuando el estudiante reconoce que presenta algunas dificultades en sus comportamientos éticos y/o refleja pocos elementos que caracterizan sus valores éticos.
- Nivel malo (valor de 0 puntos): cuando el estudiante reconoce inadecuados comportamientos éticos y no dispone de elementos que muestren buenos valores éticos.

Se realiza el análisis de la lógica seguida en la obtención de los datos y hechos que justifican el problema de investigación. La encuesta aplicada a los 14 estudiantes de la carrera de Medicina en conjunto con la escala auto-calificativa, arrojó como resultado que solo 2 de ellos, lo que representa el 14,3 %, conceden importancia a su formación ético-profesional para la solución de problemas más generales en los escenarios profesionales. De la misma manera que, solo 3 estudiantes, para un 21,4 % fueron capaces de ejemplificar con al menos un caso, la relación de estos problemas con sus comportamientos éticos y su modo de actuación.

Resulta significativo, además, que solo 1 estudiante, el 7,1%, logró establecer la relación entre los valores emergidos desde los ejemplos de los educandos y su comportamiento individual, social y profesional durante la educación en el trabajo, a través de los análisis e integración de contenidos recibidos en las diferentes asignaturas se revelan insuficiencias, lo cual limita sus posibilidades de cuestionar y preservar puntos de vista basados en la importancia del

reconocimiento de figuras trascendentes de la Medicina, que han sido ejemplo del modelo de profesional que se pretende alcanzar.

Con respecto a valorar acertadamente, los valores que dan sentido profesional y social desde los ejemplos de figuras trascendentes de la Medicina, como modelo a seguir en su proceso formativo en contexto, solo 2 estudiantes, que representan el (14,3%) lo lograron. Mientras que el (7,1%), representado en 1 estudiante, mostró seguridad para lograr un razonamiento relacionado con el impacto que tiene en su formación integral.

De los estudiantes encuestados solo 2 (14,3 %), aciertan al reconocer acciones intencionadas a potenciarlos valores, comportamientos éticos y modo de actuación desde los ejemplos de figuras trascendentes de la Medicina como modelo, que le permitan intervenir en situaciones de salud, de manera emergente. Es significativo que el (92,9 %) para un total de 13 estudiantes no reconocen desde la labor educativa, formas y métodos para concernir los ejemplos dentro de los contenidos del perfil del Médico General.

Se propone por la importancia que reviste, un supuesto para el reconocimiento de los comportamientos éticos que revelan lo ético-profesional desde los valores compromiso, consagración y humanismo, del vínculo de la relación entre su comportamiento individual, social y profesional durante la educación en el trabajo y el saber hacer como sentido profesional, lo que permite caracterizar integralmente su actividad en la educación en el trabajo, sobre los diferentes objetos inherentes a la profesión, con una lógica tal que refleje que el estudiante ha aprehendido de los contenidos fundamentales de la ciencia, recíprocamente con los valores éticos esenciales que debe tener el futuro profesional.

En opinión de la autora, esta es una de las debilidades mayores que tiene el trabajo educativo en la formación ético-profesional en los estudiantes de Medicina, lo que da cuenta de la importancia que reviste esta realidad social, ha sido de gran importancia la sinceridad del estudiante al dar sus respuestas, lo que permitió revelar lo que acontece más allá de la realidad contextual, nos inquieta la manera en que los propios estudiantes se identifican, porque para tener protagonismo en su propia formación de valores el estudiante debe poseer una adecuada autocritica.

En tal sentido, los indicadores tributados en las encuestas a los estudiantes de Medicina y la escala auto-calificativa

aplicada, aportó datos nada desestimables que confirman lo anterior, lo que permitió revelar, que existen limitaciones en la formación de valores éticos, al demostrar dificultades en la utilización del método clínico epidemiológico desde una visión integradora en la práctica clínico-interventiva para la atención integral a pacientes. Solo 3 estudiantes lo que representa el 21,4 % reconocieron ser comprometidos con su profesión, de igual manera el 14,3 % para un total de 2 estudiante consagrados y humanista el 7,1 % para un total de 1 estudiante, se evidencia la necesidad perentoria de desarrollar estos valores en el proceso formativo del estudiante de Medicina, para que alcancen en ellos una mayor jerarquía, pues forman parte esencial en la profesión médica.

A partir del 2do indicador en el que se le pide la estudiante que enumere cuatro cualidades que se corresponda con los valores señalados, la mayoría consideró lo siguiente: ser respetuoso y cumplir con los deberes (50 %), ser disciplinado (28,6 %), ser honesto y honrado (14,3 %), solidario (7,1%). Los estudiantes contrastaban cualidades que se avenían con lo ético-profesional, se argumenta el desarrollo de estos valores y la necesidad de defenderlo y fortalecerlo en el proceso formativo del estudiante en contexto.

La auto-evaluación del estudiante a partir de criterios revelados en la escala propuesta, así como la triangulación de los criterios emitidos por los especialistas-docentes, profesores, directivos y la autora de esta investigación, la misma es metodóloga de la institución y en supervisiones integrales como: pases de visita, discusión diagnóstica, conferencias, ha podido corroborar los resultados de las observaciones directas en la educación en el trabajo.

Todo lo cual no solo nos permitió corroborar las insuficiencias presentes en el desarrollo de este proceso formativo, sino que también nos permitió caracterizar integralmente su actividad en la educación en el trabajo, permitiéndonos actuar sobre los diferentes objetos inherentes a la profesión, con una lógica tal que refleje que el estudiante ha aprehendido de los contenidos fundamentales de la ciencia, recíprocamente con los valores esenciales que debe tener el futuro profesional.

En las entrevistas a los especialistas-docentes y directivos se pudo constatar que solo 25,5 % consideraba el proceso formativo muy adecuado; y 78,2 %, entre adecuado e inadecuado. La mayoría conocía los valores institucionalizados

en la sociedad cubana, pues además de mencionar más de seis, opinaban que el compromiso con la profesión, el humanismo y la ética eran imprescindibles en la profesión médica, aún cuando no consideraban la consagración a la profesión como un valor superior, develado desde los comportamientos éticos y el modo de actuación del estudiante de Medicina en los escenarios profesionales donde interactúa con el paciente y sus familiares.

Acerca de ello, 95,0 % concordaba en que apremiaba seguir desarrollando los valores en el proceso formativo de los estudiantes, ya que no siempre se trabajaban con intencionalidad los concernientes con lo ético-profesional y su importancia. El 100 % de los especialistas-docentes compartían el criterio de que la educación en el trabajo ofrecía las mayores posibilidades para desarrollar los valores en los estudiantes aún cuando no poseían una intencionalidad formativa.

Lo anterior, se evidenció en la observación realizada a las actividades docentes, donde los estudiantes estaban en contacto directo con el objeto de la profesión, podían desarrollarlo con independencia y considerar ellos mismos su crecimiento. Se constató que los objetivos de la clase eran precisos en función del aprendizaje, pero los educativos no se dirigían con intencionalidad hacia el desarrollo de valores, las preguntas formuladas eran generalmente problémicas y de aplicación orientada al perfil ocupacional.

En la observación, los profesores demostraron tener dominio de los contenidos que impartían; sin embargo, en su preparación metodológica no siempre se tenían en cuenta aspectos metodológicos para desarrollar valores; el ejemplo, la comunicación, indicadores de los valores y su integración con los problemas de salud, en los contenidos de aprendizajes, entre otros. En el plan metodológico se demostró que, aúnque el desarrollo de valores constituía una línea de trabajo metodológico, era limitado el tratamiento científico de dicha problemática y sobre todo los valores emergido desde el ejemplo de figuras trascendentes de la Medicina, como modelo a seguir, las actividades que se desarrollan son insuficientes la intencionalidad en esa dirección, argumentado por lo antes expuesto.

Siguiendo estas ideas se reconocen las dificultades teóricas y metodológica que tienen presentes para desarrollar el proceso de formación ético-profesional, sustentado en el modo de actuación desde lo individual, social y

profesional, de manera integral y sistémica, cuando solo 5 profesores (3,67 %) acertaron en sus respuestas sobre algún contenido de este proceso, la ejemplificación de las acciones metodológicas para su desarrollo, de qué formas y métodos, para la solución de problemas del contexto y su proyección en los escenarios profesionales, donde interactúa con los pacientes y sus familiares.

De igual manera, las autoridades administrativas de salud (10) en su totalidad (100 %) coinciden en la necesidad de lograr que este proceso se sistematice y contextualice en su vínculo bidireccional, sobre la base de la toma de decisiones estratégicas para su desarrollo tanto en lo curricular como en lo extracurricular.

Así mismo, la opinión de los profesores, que se desempeñan en los escenarios docente-asistenciales, acerca de la Vías y métodos para la formación ética y tratamiento del desarrollo de valores por los profesores (curricular extracurricular), en que se debe intencionar la atención a los problemas de los comportamientos de los estudiantes de Medicina. Los resultados de 46 encuestados que representa un 92 %, es que los comportamientos del estudiante, en la relación con los pacientes, requiere de saberes que se direccionen hacia la exploración del paciente y las relaciones interpersonales.

La entrevista a 10 directivos correspondientes a la Universidad de Ciencias Médicas y del Sistema provincial de salud, seleccionados por su nivel de influencias en la toma de decisiones con respecto a los procesos formativos. Se pudo constatar que el 100 %, otorga una alta importancia al proceso de formación ético-profesional en la formación de médicos y a su relación con la calidad de los servicios. Reconocen la necesidad de realizar acciones encaminadas a fortalecer los valores éticos y el modo de actuación del estudiante de Medicina en los escenarios profesionales donde interactúa con el paciente y sus familiares y en este sentido darle tratamiento.

A su vez, se realizó otra entrevista a 10 especialistas-docentes de las especialidades de Medicina Interna y Ginecobstetricia, por ser las especialidades en las que las rotaciones de los estudiantes de Medicina se desarrollan en un tiempo más prolongado. Ello permite determinar que existen insuficiencias y limitaciones, lo cual se sintetiza en:

- Los estudiantes de Medicina no atribuyen mucha importancia a su formación ético-profesional, para la solución de problemas de salud en los escenarios profesionales donde interactúan con el paciente y sus familiares, aún existen insuficiencias en acciones intencionadas a potenciar comportamientos éticos desde los ejemplos de figuras trascendentes de la Medicina, de igual forma, las vías y métodos para el desarrollo de valores por los profesores (curricular extracurricular).
- Limitado tratamiento didáctico-metodológico del contenido ético-profesional para la formación del estudiante de Medicina, todavía es insuficientes la sistematización de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina como ejemplos y su tratamiento desde la estrategia educativa.
- Necesidad de reinterpretar la formación ético-profesional, dirigidas al tratamiento de los valores compromiso, consagración y humanismo desde los ejemplos de figuras trascendentes, que posibiliten totalizarlo en los comportamientos éticos y el modo de actuación del estudiante de Medicina en los escenarios profesionales donde interactúa con el paciente y sus familiares.

Las regularidades que emergen del diagnóstico realizado, expresan que la formación ético-profesional del estudiante de Medicina exige, en los escenarios actuales, un profundo análisis que permita equilibrar hacia dónde se orienta su contenido, por lo que se trata entonces de utilizar las herramientas validadas por una correcta concepción científica, con una sólida base teórica en la comprensión de este problema y en su instrumentación práctica. Como consecuencia del insuficiente énfasis en los aspectos del desarrollo de valores éticos esenciales como el compromiso, la consagración y el humanismo en el proceso formativo y de los ejemplos como incentivo para desarrollar acciones conducentes a perfeccionar los comportamientos éticos en el estudiante de Medicina, donde interactúa con los pacientes y sus familiares.

Conclusiones parciales del capítulo 1

- Los estudios realizados en torno a la formación ético-profesional aún carecen de una construcción epistemológica que resignifique la sistematización desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras

trascendentes de la Medicina, como núcleos dinamizadores del proceso de formación del estudiante de Medicina en los escenarios profesionales.

- El análisis e interpretación de las tendencias históricas, en el proceso de formación ético-profesional, refleja la existencia de un vacío epistémico en el referido proceso, lo cual se expresa en su movimiento tendencial.
- El análisis histórico tendencial, del objeto y campo, permitió revelar una insuficiente trayectoria de los mismos, ya que se caracterizó por a continúan centrados en el aumento de contenidos y acciones médico social**,** en respuesta a situaciones emergentes del país, hacia: Una formación ético-profesional orientada al perfil ocupacional, sin la adecuada articulación que conduzca a comportamientos éticos que distingan el encargo social y profesional del estudiante de Medicina, invalidando la participación del estudiante de Medicina, en el reconocimiento de los valores emergidos de las Historias de Vida figuras trascendentes de la Medicina, como ejemplos en el proceso formativo.
- El análisis causal realizado para esta investigación, sobre el proceso de formación ético-profesional en Hospital General Docente “Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso” de Santiago de Cuba, permite corroborar el problema científico planteado y determinar la situación actual del proceso de formación ético-profesional del estudiante de Medicina, en la referida Institución.

Capítulo 2.

Formación ético–profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina

CAPÍTULO 2. FORMACIÓN ÉTICO-PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE DE MEDICINA DESDE LOS EJEMPLOS DE HISTORIAS DE VIDA DE FIGURAS TRASCENDENTES DE LA MEDICINA

En el presente capítulo, se presenta la modelación de la formación ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina. Desde los fundamentos pedagógicos se consideró la propuesta de Fuentes (2011), dichas concepciones teóricas conciben la evaluación como uno de los eslabones del proceso de formación además de ser un espacio de construcción de significados del cual emergen categorías como juicio, razonamiento, valoración y calificación**, concepción científica de lo Holístico Configuracional. Lo anterior, es expresión de las relaciones esenciales que se establecen entre sus configuraciones y dimensiones, desde las cuales se originan los movimientos que dan lugar a nuevas cualidades en el objeto transformado lo que** permite considerar un modelo de la dinámica ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida y tiene como intención dar respuesta a la integración de las dimensiones socio-humanista y clínico-trasformadora para la formación ético-profesional del estudiante de Medicina.

Esto supone un proceso alejado de la tradicional concepción de evaluación como un hecho concreto final, pasando a considerarla como un proceso continuo, que además de calificar sirva para orientar, motivar, incentivar el deseo de formarse y promover la intervención en la práctica clínica entre estudiantes y profesores desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina.

2. 1. Fundamentación teórica del modelo de la dinámica ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida

Los fundamentos epistemológicos del modelo, permiten argumentar las transformaciones actuales que se requieren en la formación inicial del médico, con cualidades humanas que favorezcan la relación médico-paciente-familia, en aras de realizar adecuadamente su encargo social.

Se parte de reconocer la formación ético-profesional del estudiante de Medicina como un proceso consciente, de naturaleza holística, compleja y dialéctica y se modela ésta a partir de configuraciones y dimensiones que revelan un sistema de relaciones dialécticas y una regularidad que las identifica y connota su esencia (Fuentes, 2011).

En la construcción del modelo de la dinámica ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida. Se determinan puntos de partida, que permiten orientar el fundamento de este modelo, y que tienen una validez universal, a la vez que particularizan el movimiento de la formación ético-profesional los cuales se advierten de la siguiente manera:

- El hombre es un ser social, complejo, con conciencia, capacidad trasformadora y espiritualidad, que expresan su esencia y su condición humana en un espacio y un tiempo histórico, social, económico y cultural concreto en que vive y se desarrolla plenamente. La formación profesional en las universidades médicas está signada en la actualidad, por enfrentar los retos sociales, en su devenir histórico, como un proceso que involucra determinante la condición humana.
- El contenido de lo ético-profesional, constituye el basamento para el desarrollo de la concepción del humanismo médico, con una pretensión más perfeccionada desde el perfil ético humanista, que se pretende alcanzar en el modelo del profesional de la Medicina.
- Formación ético-profesional deviene como un proceso de negación de la negación, resultando de la autoformación humanista profesional, desde la educación en el trabajo como método.

Los fundamentos epistemológicos del modelo de la dinámica ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida. Permiten las trasformaciones actuales que se requieren en la forma inicial del médico, con cualidades humanas que favorezcan la relación médico-paciente-familia, en aras de realizar adecuadamente su encargo social.

En la construcción del modelo de la dinámica ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida, se determinan como pilares que sustentan el constructo teórico que se presenta en el capítulo, que

permiten orientar el fundamento de este modelo y que tienen una validez universal, a la vez que particularizan el movimiento de la formación ético-profesional, los cuales se señalan de la siguiente manera:

1. El hombre es un ser social, complejo, con conciencia, capacidad trasformadora y espiritualidad que expresan su esencia y condición humana en un espacio y un tiempo histórico social, económico y cultural concreto en que vive y se desarrolla plenamente.
2. La formación profesional en las universidades médicas está signada en la actualidad, por enfrentar los retos sociales, en su devenir histórico, como un proceso que involucra determinantemente la condición humana.
3. La relación entre lo personal, social y lo profesional, constituye un criterio asegurador del proceso de formación ético-profesional a partir de la autoformación humanista profesional en el estudiante de Medicina.
4. El enfoque histórico-cultural de Vigotsky (1998), permite discernir que la naturaleza histórico-social y el carácter mediatizado y activo de los procesos psíquicos.

Los principales fundamentos teóricos asumidos son**:**



Figura 2.1.1 Representación de los principales fundamentos epistemológico del Modelo

Sobre los pilares que sustentan el constructo teórico:

1. Asumir el fundamento epistemológico de la Concepción Científica de lo Holístico Configuracional (Fuentes, 2011), es de especial importancia dentro de este proceso de investigación, el mismo aporta una lógica de pensamiento en la construcción del conocimiento científico, favorece una apropiación y transformación pedagógica activa, constructiva, desarrolladora y creadora, que permita sustentar, e**l** hombre es un ser social, complejo, con conciencia, capacidad trasformadora y espiritualidad que expresan su esencia y condición humana en un espacio y un tiempo histórico social, económico y cultural concreto en que vive y se desarrolla plenamente. Es, además, reconocer la consideración de la condición humana como sustento antropológico de los procesos formativos, para la atención de la contradicción dialéctica entre la naturaleza humana, capacidad transformadora, actividad y cualidades humanas. Tales argumentos, permiten la interpretación de la formación cultural del ser humano, así como el carácter consciente y transformador de la formación profesional, todo lo cual se adjudica en la construcción del conocimiento científico de la investigación.
2. **Desde la concepción pedagógica del método clínico y epidemiológico en la formación clínico-integral de los autores** Ilizástigui y Douglas (1993a y b) y Roca (2007 y 2011), autores que visualizan desde un enfoque intencionado y que tiene su particularidad en la Pedagogía Hospitalaria, toda vez que desde la misma se agrupan una serie de categorías que propician dilucidar la existencia de una formación que se caracteriza por la relación entre la sistematización y la intencionalidad, ambas como vías expeditas en la compresión e interpretación de un proceso en constante movimiento, de ahí que lo estático y lo tradicional queden a un lado, dado el movimiento ascendente, cíclico y progresivo.

   Se concibe el carácter dinámico de este proceso formativo del estudiante de Medicina, desde considerar los aspectos fundamentales que se contienen en el mismo, todo lo cual tipifica las relaciones esenciales que son indispensables entre las categorías asumidas, sobre todo porque permiten dilucidar los eslabones mediadores que propician establecer el reconocimiento dialéctico de la contradicción de su misma naturaleza, pero que se

resignifica a partir de los pares dialécticos mediados mutuamente condicionados y establecen el auto movimiento y autodesarrollo de la formación del estudiante de Medicina.

Desde lo epistemológico, emerge la necesidad de asumir los presupuestos pedagógicos que concretamente soportan el constructo teórico de esta investigación, para discernir los referentes básicos de este modelo, de ahí que interpretar el proceso de formación ético-profesional del estudiante de Medicina, proceso permanente, social y humano que promueve la capacidad para vivir coherentemente con comportamientos éticos en su quehacer profesional y social, como normas de comportamiento generalizado en el ejercicio pleno de su profesión, se encamina a ampliar las potencialidades humana y garantizar una formación integral del médico, permitiéndole un desempeño profesional superior en su práctica formativa.

3. La relación entre, lo personal, lo social y lo profesional, constituye una directriz garante del proceso de formación humanista, en relación al autodesarrollo de referentes personal profesional en la formación del estudiante de Medicina expuesto por Cedeño (2020).
4. Así que el enfoque histórico-cultural de Vigotsky (1998), permite comprender que la naturaleza histórico-social y el carácter mediatizado y activo de los procesos psíquicos, le confiere gran importancia a la actividad conjunta que se establece en el plano de las relaciones del sujeto en contexto. Tales cuestiones, evidencian la relevancia de los ejemplos en el proceso formativo, de manera particular en la educación en el trabajo, que distingue el modelo del profesional de la Medicina. En la profesión médica, es importante asumir comportamientos éticos dignos de admirar, del modo de actuación, de relaciones esmeradas, responsable, humana, empática.

Se asevera, desde esta investigadora que, en relación al reconocimiento **de los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina**, en el proceso formativo de este profesional debe posibilitar en los mismos valores fundados, un auto acercamiento a la espiritualidad, al desarrollo de la sensibilidad humana, desde la **autoformación humanista profesional**, "a decir propio, de perfeccionar las características de la personalidad y saber autorregular aquellas que estén resultando inconvenientes para alcanzar las metas en pos de un proyecto de vida"

(Cedeño, 2020), encaminados al compromiso social y profesional responsable, a la emancipación, la autonomía y empatía, considerando la responsabilidad del individuo para la vida y el desarrollo común de toda la sociedad, con respecto a la ética que distingue a este profesional.

Al respecto es válido destacar que el modelo propuesto tiene un nivel de concreción en la resignificación del perfil ético-profesional, desde una concepción del humanismo médico con una concreción generalizable en el proceso formativo del estudiante de Medicina.

2.2 Modelo de la dinámica ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida

El modelo de la dinámica ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida: está estructurado a la dimensión socio-humanista y la dimensión clínico-trasformadora que son expresión de sus movimientos internos y permiten revelar, a partir de las relaciones establecidas entre las configuraciones, su transformación a un estadio superior.

La dimensión socio-humanista es la cualidad resultante de las relaciones existentes entre sus configuraciones. Su movimiento se revela a partir de la intencionalidad formativa de la **concepción del humanismo médico,** configuración, síntesis de la contradicción dialéctica existente entre **la construcción de una identidad médica** en relación dialéctica con **la interpretación crítica de experiencias confrontadas y la sistematización desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascedentes de la Medicina** (Figura 2.2.1).



Figura 2.2.1 Dimensión socio-humanista

La configuración que inicia el movimiento de la primera dimensión es la **concepción del humanismo médico,** resultado de un proceso que se organiza desde las actividades extracurriculares, con el objetivo de favorecer la formación multilateral de los estudiantes, se organizan un conjunto de actividades Científicas Estudiantil, lo que permite desarrollar motivaciones, habilidades y hábitos de investigación, capacidades intelectuales estéticas y culturales, con el objetivo de propiciar la participación de los estudiantes en investigaciones que connoten los ejemplos de las Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, la cual se convierte en un proceso significativo que debe estar presente en el proceso formativo del estudiante en cuestión, en aras de lograr la solidez de la formación de valores fundados desde los ejemplo de figuras trascendentes.

En esta configuración se describen las cualidades esenciales del profesional que se aspira formar, desde una concreción del humanismo médico más perfeccionada, más allá de lo que se revela en el perfil ético humanista del modelo del profesional para la formación de médicos. A partir de considerar los problemas que se reflejan en literaturas especializadas y en la propia práctica de la autora de esta investigación, se identifica que existe una deshumanización en el proceso formativo del médico.

En tal sentido, se conceptualiza la concepción del humanismo médico como la intencionalidad de esta investigación;

es el proceso didáctico encaminado a desarrollar comportamientos éticos en su quehacer profesional y social, permitiendo el perfeccionamiento en cada nivel del proceso formativo del estudiante de Medicina, se fundan valores desde los ejemplos de figuras trascendentes de la Medicina, donde a su vez se constituye en el movimiento continuo y generalizador de la formación ético-profesional.

Se establece, así **la intencionalidad de la concepción del humanismo médico**, que se erige en la **relación entre los comportamientos éticos** del estudiante de Medicina, con respecto a la ética que distingue a este profesional, **permitiendo que este desarrolle la autoformación humanista profesional** dese los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina. En los aspectos individuales de las actitudes, el modo que conducen al desarrollo de cualidades morales que distinguen al profesional, sobre el cual la sociedad deposita un alto grado de expectativas en concordancia a su forma de relacionarse, de vivir, de ser y hacer.

Por tanto, parte desde un proceso trascendente, por la consolidación de una formación que se desarrolla fundamentalmente en las actividades de educación en el trabajo, que se expresa en su carácter formativo, a partir del desarrollo de un ámbito axiológico y bioético, en la consolidación de la sensibilidad humana y la espiritualidad, dando nuevos significados y sentidos al estudiante de Medicina.

La intencionalidad a la vez que es un proceso que se desarrolla en la medida que se sistematizan las Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina y su ejemplo, así como niveles superiores que aumenten sus habilidades y capacidades intelectuales, físicas, estéticas y culturales, permitiéndoles desplegar motivaciones y hábitos de investigación, que garanticen la apropiación de conocimientos y valores éticos que le permita una integración de nuevas herramientas que trascienda a planos superiores en la práctica médica profesional.

Por tanto, se reconoce que la pertinencia, el impacto y la relevancia de la concepción del humanismo médico como un proceso más trasformador, donde el estudiante no solo aprenden lo técnico y práctico, sino también llegan a marcar la impronta de valores trascendentes y de esta forma jerarquizarlos, todo lo cual le va permitiendo en estadios superiores ir construyendo la identidad médica desde la experiencias confrontadas, el juicio crítico y autocritico en

todo el proceso formativo, convirtiéndose así, en auténticos en su actuar y flexibles ante los problemas médico-sociales de los pacientes.

Para ello, este estudiante con un encargo social particular debe desarrollar y alcanzar en forma constante, como elementos básicos: competencias para resolver los problemas de salud a nivel primario; secundario y terciario, capacidad para asumir labores de gestión, capacidad para integrarse e integrar al trabajo en equipo y disposición interventiva en la educación en el trabajo.

Esta configuración en tanto, expresa la correspondencia entre el actuar ideal, deseado y real del estudiante de Medicina, el sistema de normas y valores establecidos, construidos socialmente en una relación de sentido, tiempo y espacio determinado, que alcanzan significativo valor instrumental y metodológico asociada a la atención integral a pacientes, dando cuenta, de la expresión externa de la conducta individual en correspondencia con la subjetividad, a partir de la unidad de lo externo y lo interno, de la relación de lo consciente y lo inconsciente, de lo cognitivo y lo afectivo en la función reguladora de la conducta del estudiante de Medicina.

Desde la intencionalidad del humanismo médico se marca la impronta de este comportamiento ético sistematizado, que se refiere a la existencia y esencia de esa sensibilidad humana y espiritualidad de la que tiene que estar dotado este profesional, pues entender su especificidad requiere comprender que la esencia humana no es algo abstracto alejado de lo socio, profesional, individual, sino el conjunto de sus relaciones sociales y profesionales cualitativas, de ahí la necesidad de humanizar cada vez más las cuestiones referidas a la atención integral a pacientes con una mirada desde la práctica clínico-interventiva, como aspecto significativo en el proceso formativo del estudiante de Medicina.

Todo lo cual van a beneficiar el perfeccionamiento de la estrategia educativa, ya que favorece el proceso de diagnóstico así como el sistema de acciones, desde un nuevo enfoque, con una **autoformación humanista profesional,** una integración y significación de los valores compromiso con la profesión y la sociedad, significando la responsabilidad con los pacientes y sus familiares, la consagración y el humanismo, así como el rescate de la Historia de la Medicina y de la identidad médica por medio de los ejemplos de figuras trascendente de esta ciencia.

Con la intención desde la concepción del humanismo médico, que se expresa un nivel de regulación y autorregulación de comportamientos éticos, conforme al mantenimiento, optimización, con una sensibilidad humana que los tipifique dentro de otros profesionales, reflejo del incremento de la autonomía, la independencia y la responsabilidad, de las consecuencias en las decisiones auto determinadas sobre la base de la confianza en sí mismo, así como en sus relaciones e interacciones integral, de la espiritualidad, del modo de actuación que debe tener el estudiante de Medicina, para entender y ponerse en el lugar de los pacientes y sus familiares, que de la misma forma sobrellevan el dolor y la angustia de su familiar, a la luz de la confianza, exigencias y requerimientos socio-psicológico dentro del marco contextual donde se desarrolla la práctica clínico-interventiva, en las cuales se establecen las normas en la atención integral a pacientes.

El vínculo de la **construcción de la identidad médica** constituye la configuración que propicia activar el conjunto de atributos que permiten al individuo reconocerse a sí mismo como integrante de un gremio profesional, por lo que, al realizar actividades y tareas en un contexto laboral, otorgan al sujeto reconocimiento social, que lo distingue de otros profesionales. No surge espontáneamente, ni se obtiene de manera automática, sino que se construye a través de un proceso complejo, dinámico y sostenido en el tiempo.

El estudiante como todo individuo al reelaborar la identidad médica como el cumplimiento de principios éticos y de la obligatoriedad de contribuir al desarrollo de su profesión, de acuerdo a su encargo social, teniendo en cuenta las condiciones que determinan los fenómenos de salud y enfermedad de cada paciente, utilizando adecuadamente el método clínico y epidemiológico, para indagar críticamente la realidad, respetando la individualidad y la diversidad cultural desde un compromiso profesional, social y moral de preservar la vida, aliviar sufrimiento, prevenir enfermedades con el objetivo de orientar a los pacientes y familiares, ayudarle frente a problemas difíciles, devolviéndole la esperanza de que puedan mejorar y recuperarse de las enfermedades.

La construcción de la identidad médica tiene relación con un significado individual, también en relación con el otro. La identidad médica es asimismo dinámica, con un fuerte componente social, profesional y emocional, permitiendo

consolidar y orientar hacia valores emergidos desde los ejemplos de figuras trascendentes, desde una interpretación critica de experiencias confrontadas, el estudiante de Medicina desarrolla una identidad médica legítima, que se considera determinante para el éxito de las prácticas clínico-interventiva.

La configuración identidad médica hace referencia a lo que interviene en los comportamientos éticos de este profesional, que al mismo tiempo motiva e impulsa la voluntad y la capacidad trasformadora del estudiante de Medicina. Por tanto, esta configuración, la identidad médica se construye identitariamente mediante un proceso donde explora y trata su propio ser, tanto por sí mismo como por los demás. Ofrecen una perspectiva, que corresponde con lo individual, social y profesional. Supone un eje fundamental para la construcción de valores fundados desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendente de la Medicina.

Siguiendo estas ideas, se asevera que la configuración identidad médica es constitutivo de los comportamientos éticos del estudiante de Medicina, es importante resaltar su duplicidad identitaria, es miembro de un gremio profesional, educando, compañero, responsable de cumplimiento de normativa, relaciones empáticas médico-paciente-familia.

Cuando se reconoce desde los ejemplos de otros sujetos, se establece categorías determinadas que consolidan los significados y sentidos de hacer y ser, de los comportamientos éticos en los escenarios profesionales.

Es, por tanto, la configuración identidad médica, la que individualmente construida y contextualizada, se pondera en los escenarios sociales y profesionales para dar solución adecuada a los dilemas que se les presentan durante el ejercicio de sus funciones profesionales, mediado por el gestor de dicho proceso, la autoformación humanista profesional.

Entre las configuraciones **construcción de la identidad médica y la interpretación crítica de experiencias confrontadas** se establece una relación dialéctica a partir de reconocer que en la medida en que el estudiante de Medicina va interpretando las experiencias confrontadas desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina construye su identidad médica, lo que le permite al mismo tiempo no solo reconocerse

así mismo como integrante de un gremio profesional, sino, que de la misma forma desde lo individual desarrolla su perfeccionamiento profesional motivado en los ejemplos de figuras trascendentes de la Medicina.

El estudiante identifica situaciones profesionales desde la educación en el trabajo, se estructura un nuevo aprendizaje y con ello la autoformación humanista profesional. Es la configuración interpretación crítica de experiencias confrontadas donde se desarrolló el perfeccionamiento profesional, para que este sea propicio, es preciso perfeccionar el proceso formativo, motivar al estudiante, proyectar las acciones profesionales y extender la actividad trasformadora y creadora en los escenarios profesionales.

El estudiante de Medicina tiene que ser crítico a partir de sus comportamientos éticos en situaciones profesionales desde la educación en el trabajo como modelo pedagógico que lo ubica como protagonista, aprender haciendo. Se deben promover ejercicios didácticos en grupos de encuentros, donde los estudiantes participen de forma activa y distingan actitudes, modos, valores y comportamientos desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, con una nueva visión en el proceso formativo, como elección eficaz para crear valores fundados desde los ejemplos, que permita favorecer la atención integral a pacientes.

Para que este sea favorable, es preciso perfeccionar el proceso formativo desde establecer mecanismos entre lo individual, social y profesional como juicio asegurador del proceso ético-profesional del estudiante de Medicina, lo que condiciona la capacidad transformadora del estudiante de Medicina, en su saber, hacer, ser y convivir, los cuales sustentan los conocimientos, habilidades, valores y valoraciones, a partir de lo cual se desarrolla el estudiante en contexto.

La unidad dialéctica entre ambas configuraciones se sintetiza en la **sistematización desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina,** que se erige en la directriz dinámica a seguir en este proceso formativo, en tanto, al considerar la necesidad de una formación atemperada a los derroteros del desarrollo de la ciencias, es ineludible el perfeccionamiento del humanismo médico desde una concepción más **desarrolladora, como vía que permita articular** comportamientos éticos en el estudiante de Medicina desde su encargo social y profesional.

Conlleva a que el estudiante de Medicina en formación, sistematicen la formación ético-profesional con una consolidación de la sensibilidad humana y la espiritualidad, donde se erige la **autoformación humanista profesional,** como movimiento que van a dar cuenta de comportamientos éticos, intencionado en el reconocimiento y diagnóstico de los problemas de salud en los pacientes, desde la interpretación de la naturaleza y la existencia humana.

Desde esta perspectiva esta configuración es la que sustenta el desarrollo de lo ético-profesional, a niveles superiores en las transformaciones del humanismo médico afianzado en la sensibilidad humana y la espiritualidad que van sucediendo en los estudiantes en el proceso formativo, cementando valores como: el compromiso, la consagración, el humanismo, vivencias, autonomía alcanzada, imagen del mundo y de sí mismo, autovaloraciones, sentidos y significados en su quehacer profesional.

Constituye la configuración en que se establece el espacio en el que los sujetos implicados se reconocen desde los ejemplos, de los valores emergidos del estudio de la vida profesional de estas figuras trascendentes de la Medicina, desde una interpretación crítica de experiencias confrontadas, comparten irresoluciones y preguntas que surgen desde la práctica clínica con enfoque trasformador, interventivo. Es un espacio de encuentro, enriquecimiento, de indagación, reflexión y trasformación.

De esta manera, la sistematización desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina permite el fortalecimiento de los escenarios del desarrollo profesional y la autoformación humanista profesional. Para que el estudiante desarrolle esta actuación tiene que desarrollar el interés en aprender de las experiencias anteriores y superarlas en pos de su perfeccionamiento profesional, lo cual requiere, además de capacidad para analizar la experiencia sin prejuicios, dejarla hablar por sí misma, disposición a investigar las situaciones socio profesionales que se le presentan y habilidad para formar reinterpretaciones y formular juicios de valor, sin temor a la crítica improcedente.

Uno de las principales finalidad de esta configuración, es la conceptualización de los comportamientos éticos, desde los valores emergidos de las Historias de Vida de figuras trascedentes, que es precisamente el que establece y

desarrolla el proceso de formación ético-profesional del estudiante de Medicina, en tanto permite caracterizar integralmente el desempeño estudiantil competente, desde el juicio propio del estudiante, lo cual reconoce al estudiante de Medicina como un sujeto autónomo, con capacidades trasformadora, el cual en el momento que lo requiera, le permita actuar sobre los diferentes objetos inherentes a la profesión, con una lógica tal, que refleje que el estudiante ha alcanzado de los contenidos fundamentales de la ciencia, la lógica esencial de la profesión, en relación con sus comportamientos éticos.

En esta configuración no solo se aborda las experiencias individuales de las etapas vividas por las figuras, sino además la interpretación crítica de varias experiencias, que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, hace explicita la lógica del desarrollo profesional y social, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y porqué lo han hecho de ese manera, por tanto, produce un nuevo conocimiento, a la vez que posibilita su interpretación y comprensión, apunta a trascenderlo.

Al reconstruir las Historias de Vida se toma como referentes, identificar sus valores, comportamientos éticos, como regularidad, clasificarlos y reordenarlos, hace objetivar lo vivido, y convertir así la propia experiencia en objeto de estudio e interpretación teórica, a la vez que un objeto de transformación.

Las relaciones que se establecen entre sus configuraciones devienen en la identificación de **la dimensión socio-humanista** entendida esta como cualidad que complementan en torno a lo ético-profesional que desdoblan sobre el sentido de utilidad, de importancia, de belleza, de la moral, la profesión y el amor al prójimo, lo cual posibilita el desarrollo cognitivo, espiritual y social. La motivación del estudiante le da un carácter formativo, por lo que también tiene una cualidad trasformadora.

Como dimensión del proceso de formación ético-profesional más académico, donde se resignifica, que desde la práctica docente se incorporen valores universales, humanos, ético, es el espacio idóneo, para trabajar esta dimensión socio-humanista. Por cuanto, las acciones que en ella se establecen en esta dimensión tienen un carácter genuino, por darle sentido y significado desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, al

desarrollo profesional del estudiante de Medicina. Esta dimensión revela un carácter flexible, la cual debe ser entendida, no solo desde los aspectos organizativos y estructurales del perfil ético humanista, sino que también permite ir dando una formación ético-profesional en la educación en el trabajo, como componente desarrollador en la calidad médica, en la solución a los problemas de salud que se presentan en los escenarios profesionales.

Dimensión clínico-trasformadora constituye la cualidad de orden superior resultante del entramado de relaciones de sus configuraciones (figura 2.2.2)



Figura 2.2. Dimensión clínico-trasformadora

La primera configuración que inicia el movimiento en este constructo teórico **es la atención integral a pacientes**. Es el proceso que involucra al estudiante en formación para propiciar las vías, conductas y actuación sistemática ante los problemas de salud y a la urgencia de la atención de enfermedades, esto implica que se ha de alcanzar un plano superior en la praxis clínica profesional, por tanto es un proceso que es expresión de la realidad participativa en las instituciones de salud, a partir de una continua sistematización, rasgo que cualifica de forma permanente los estadios de la práctica clínica trasformadora.

La dinámica del aprendizaje que se realiza durante el ejercicio profesional a partir de la educación en el trabajo, no se circunscribirá únicamente a la formación de un saber en el estudiante que sintetice todo el legado acumulado; sino

que será un proceso orientado al desarrollo de un accionar clínico humanista asistencial con una que simultáneamente integre lo clínico interventivo, todo lo cual permite dar una formación bajo verdaderos conocimientos científicos, ello es expresión de una formación en orden superior desde la interpretación consciente del médico, desde el momento de asumir su formación en el trabajo, lo cual genera en cada uno la formación sistematizada de la comprensión de una atención distante e improcedente, cual lo conlleve al perfeccionamiento humanista, así como su acervo cultural bajo la égida de un enfoque que contribuye a la autoformación humanista profesional.

De ahí que, esta configuración le confiere un matiz pedagógico auténtico al proceso de formación del estudiante de Medicina, toda vez que al expresarse una sistematización de lo, ético-profesional se constituye en un reto interventivo desde lo asistencial en lo clínico humanista que, al ser llevados hasta su máxima expresión formativa, sienta las bases para la satisfacción de una atención integral a pacientes, ante todos aquellos que acarreen un problema de salud.

Esta configuración permite formar al estudiante de Medicina en la amplia gama de situaciones multidiversas que se presentan en los escenarios profesionales para que pueda adquirir las destrezas que le propicien solucionar situaciones de emergencia, las cuales afectan a los pacientes. De esta manera, se puede apreciar un proceso formativo del estudiante bajo los derroteros de la atención integral a pacientes, y solucionar satisfactoriamente los estados negativos de salud.

Además, se erige en un proceso que actúa positivamente para mejorar la eficiencia en el proceso asistencial formativo en los procesos de salud. Por tanto, opera sobre las bases del establecimiento del aprendizaje de la orientación estratégica de reconocimiento y observación sistematizada de los pacientes desde las actividades en la educación en el trabajo, en la medida que facilitan una mejor atención integral a pacientes y el desarrollo de comportamientos éticos en su quehacer profesional.

Se erige el criterio a seguir en este proceso formativo en tanto, al considerar la necesidad de una formación atemperada a los derroteros del desarrollo de la atención integral a pacientes, conlleva a que el estudiante de

Medicina en formación sistematice la práctica clínico-interventiva, donde esta última se erige como movimiento del

comportamiento intencional en el reconocimiento y diagnóstico de los problemas de salud en los pacientes desde la interpretación de la naturaleza y la existencia humana. Se trata de una atención que tiene por objeto la transformación social y cultural de los que se forman en el proceso formativo del estudiante de Medicina, resaltando los ejemplos de figuras trascendentes de la Medicina, de sus valores, comportamientos éticos y el modo de actuación ante situaciones médicas complejas, con una capacidad de intervención oportuna, para darle la debida atención y solución a los problemas de salud complejos.

Esta configuración permite la puesta en práctica de los procedimientos de atención que se van adquiriendo durante la educación en el trabajo, como formas de trabajo y de pensamientos que apoyan la realización consciente de actividades exigentes. Por tanto, estos procedimientos como método científico que pueden dividirse en principios, reglas y estrategias han de estar en correspondencia con el método clínico epidemiológico a partir de que faciliten la búsqueda de vías de solución a problemas de salud que se presentan tempestivamente; o sea, para resolver situaciones de cualquier tipo, para las que no se cuente con un procedimiento algorítmico de solución, en muchos casos de enfermedades complejas.

De igual forma, la necesaria existencia de esta configuración, como bien se respaldó, logrado bajo los principios de educación en el trabajo durante el proceso formativo conlleva a la aplicación, con eficiencia y eficacia, de sus diferentes tipos de atención holística que se expresan en su carácter totalizador, porque propicia reconocer la necesidad de sintonizar y armonizar con el sujeto social (paciente) las relaciones entre su naturaleza humana, su capacidad, actividad y cualidad, pues es allí donde se interrelacionan los múltiples aspectos imprescindibles para el funcionamiento del delicado equilibrio del ser humano.

Ahora bien, la configuración antes argumentada no puede establecerse por sí sola si no está relacionada con la **práctica clínico-interventiva** la cual, como contrario dialéctico a la antes mencionada, estipula la consolidación de potencialidades y capacidades humanas una interpretación sui géneris establecida para la atención integral a pacientes, que propicia la recuperación de las.

La configuración de desarrollo de la **práctica clínico-interventiva** emerge como configuración que establece el objetivo específico del proceso formativo, por lo que garantiza una transformación que se encuentra en lo formativo, con resultados notables en lo social, pues propicia y asegura la capacidad transformadora del estudiante de Medicina que ha de estar en correspondencia con el desarrollo de la formación de los valores, comportamientos éticos, desde actuaciones de esas figuras que han sido ejemplo desde lo profesional.

Al significarse la práctica clínico-interventiva, se establece la delimitación del carácter potencial y significativo de la interpretación consciente del médico, desde el momento de asumir su formación en el trabajo, lo cual genera en cada uno la formación sistematizada de la comprensión de una atención apartada y prejuiciosa, que lo conlleva al perfeccionamiento humanista, así como su acervo cultural bajo la égida de un enfoque que contribuye al desarrollo humano.

En esta configuración se plantea el proceso sistematizado de lo clínico, lo formativo y lo interventivo que contempla las nuevas perspectivas de interpretación de la relación médico-paciente-familia, pues permite contribuir con los comportamientos éticos y el modo de actuación. Concurriendo la eficiencia y la competencia del estudiante, ello es expresión de la preparación alcanzada durante el proceso formativo.

La práctica clínico-interventiva fortalece la formatividad del estudiante pues como resultado de las actividades constantes sobre la base de atención humanizada integral a pacientes, ubica todo el caudal de lo asumido. Esta configuración tiene una connotación pedagógica a los fines de la formación del estudiante, puesto que tiene el rol dinamizador como criterio valorativo de la formación, que se fomenta en los procesos de desarrollo consciente y activo que deviene en una intencionalidad formativa, que alcanza un significado como medio de transformación a partir de lo ético-profesional y la **autoformación humanista en el proceso formativo.**

Además, desde que se le considera como un proceso intencionado, esta práctica clínico-interventiva se erige como el proceso práctico donde se privilegia la acción de una atención integral a pacientes desde enfoque esencialmente humanista.

Al significarse como configuración, en el proceso formativo del estudiante, es entendida como el proceso íntegro de inserción ante el proceder práctico que engloba las realizaciones acumuladas, creaciones, proyectos y fines propios desde su identidad médica que emergen de la atención integral humanizada a pacientes, en la actividad consciente y activa, capaz de articular dialécticamente el complejo proceso de formación ético-profesional del estudiante de Medicina. Se logra la transformación del desempeño estudiantil competente y satisfacer las necesidades de salud en los escenarios profesionales, a la vez que influye en los procesos de formación y desarrollo de la capacidad transformadora profesional del estudiante de Medicina.

En su expresión más acabada, que deviene de la educación en el trabajo, se sustenta en una concepción pedagógica en el proceso de formación del estudiante de Medicina, que se expresa como proceso activo y transformador en el ser humano y revela la integración e interacción con la atención integral humanizada en los pacientes. Esta configuración es el resultado de la integración de todas las proyecciones prospectivas dimanadas en la formación del estudiante de Medicina, que han interpretado desde la singularidad de cada uno de los procesos pedagógicos en su formación, compartida en la relación de significados y sentidos que le da a este los ejemplos de figuras trascendente, a la vez que se establece la base fundamental para un desarrollo exitoso en la práctica formativa, a partir de que se construye entre todos los participantes en el proceso.

En esta configuración debe de significarse los ejemplos de figuras trascendentes de la Medicina, de cómo se comportaron estos, intencionado valores éticos como: el compromiso social responsable, el amor a la profesión revelado desde la consagración profesional y social, el humanismo médico en su práctica clínico-interventiva pues es aquí donde se expresa esa fuerza moral que se exterioriza, en la que se apoya el estudiante de Medicina y ante todo, constituye el símbolo de autenticidad y de identidad médica, con un comportamiento conforme a los principios éticos de la profesión médica, es desde el desempeño estudiantil competente y su excelencia en la atención integral humanizada a pacientes. Donde este puede autoformar el humanismo médico.

Esta configuración es el resultado de la integración de todas las proyecciones prospectivas dimanadas en la formación

del estudiante de Medicina , que han interpretado desde la singularidad de cada uno de los procesos pedagógicos en su proceso formativo, la posibilidad de una realidad compartida en la relación de significados y sentidos de una intervención adecuada para minimizar el dolor de los pacientes, a la vez que se prefija la base fundamental a partir de que se construye entre todos, es decir, entre el estudiante en la atención integral a pacientes que reciben el servicio en salud, y es que se concretan las vivencias como factor de condicionamiento en la apropiación de una práctica clínica de excelencia, con una aserción interventiva, donde se encuentra el desempeño de acciones concretas duranteel tiempo determinado en su proceso formativo.

Las configuraciones de atención integral a pacientes en relación dialéctica con la práctica clínico-interventiva da cuenta de una nueva síntesis que expresa no solo la sistematización desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, sino también a la formación ético-profesional en la educación en el trabajo, para ofrecer una nueva visión del proceso formativo del estudiante de Medicina , ya que como contrarios dialécticos propician un avance pedagógico en el desenvolvimiento de la lógica formativa del estudiante de Medicina.

Ambas configuraciones, **la atención integral a pacientes** y **la práctica clínico-interventiva** contrapuestas dialécticamente son a la vez, pares dialécticos mutuamente condicionados pues si se establece a partir de **la formación ético-profesional en la educación en el trabajo**, esta configuración se erige como un proceso permanente, social y humano que promueve las capacidades trasformadora para vivir coherentemente con los comportamientos éticos y el modo de actuación desde el modelo profesional**, es a partir de la autoformación del humanismo médico** en que el estudiante de Medicina desarrolla acciones que le permitan transitar a un nivel superior de desarrollo en el proceso formativo.

En la medida en que se logran niveles superiores de desarrollo, desde los valores emergidos de la Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina la profesión adquiere cada vez más, sentido para los estudiantes de Medicina, los proyectos empiezan a entenderse más desde la educación en el trabajo, se consolidan el cumplimiento de las normas, las costumbres, los preceptos y mandamientos médicos, como una forma de vivir en consonancia con los

cambios culturales, aparejado significativamente a las transformaciones que acontecen en la sociedad y en una época determinada.

Como se puede apreciar resulta de gran significación la formación ético-profesional del estudiante de Medicina en la educación en el trabajo, ya que constituye la configuración que propicia activar constantemente el proceso formativo del estudiante de Medicina para significarlo como un proceso permanente, social y humano que promueve las capacidades trasformadoras, que hacen y mejoran al desarrollo de las actividades profesionales, y determinan los comportamientos éticos mediante valores comprometidos con el modelo profesional.

La formación ético-profesional en la educación en el trabajo del estudiante de Medicina, se fundamenta en el principio martiano y marxista de la vinculación estudio-trabajo. Esta constituye la modalidad fundamental de organización del proceso docente-educativo en la carrera de Medicina. Por tanto, desde la educación en el trabajo donde el estudiante de Medicina, se forma de manera integral, donde se brinda atención médica, interactúa con los demás miembros del equipo de trabajo, con los pacientes y familiares, los cuales en muchas ocasiones no se integran como miembros en el proceso formativo, la autora de esta investigación lo tiene en cuenta en este proceso por ser un agente influyente en el transcurso de recuperación del aquejado, las cuales deben de ser una unidad indivisible en la atención integral a los pacientes al reconocer la relación médico-paciente-familia

Se reconoce que la pertinencia, el impacto y la relevancia en la relación médico-paciente-familia dado en la formación ético-profesional en la educación en el trabajo, como propósito a alcanzar en el estudiante de Medicina en formación la consolidación de la sensibilidad humana y la espiritualidad en la atención integral a pacientes, se convierte en fundamento esencial en toda praxis formativa, que propicia una transformación cualitativa, a la vez que conlleva a que puedan desarrollarse conscientemente en esta práctica, cargadas de los más disímiles conocimientos, ideas y realizaciones de los diferentes contextos, lo cual se erige en un proceso formativo de gran significación.

De igual forma, es necesario que en el proceso de formación ético-profesional en la educación en el trabajo humanizado se denoten la educación en los principios éticos, en el logro de una relación médico-paciente-familia

transformativa. Que, entre el médico el paciente y la familia debe existir una adecuada comunicación y su éxito, depende de la empatía y asertividad en las relaciones interpersonales profesionales y sociales, con la sensibilidad humana y la espiritualidad, con que el estudiante de Medicina sea capaz de direccionar su comportamiento ético el modo de actuación en los escenarios profesionales donde interactúa con el pacientes y sus familiares.

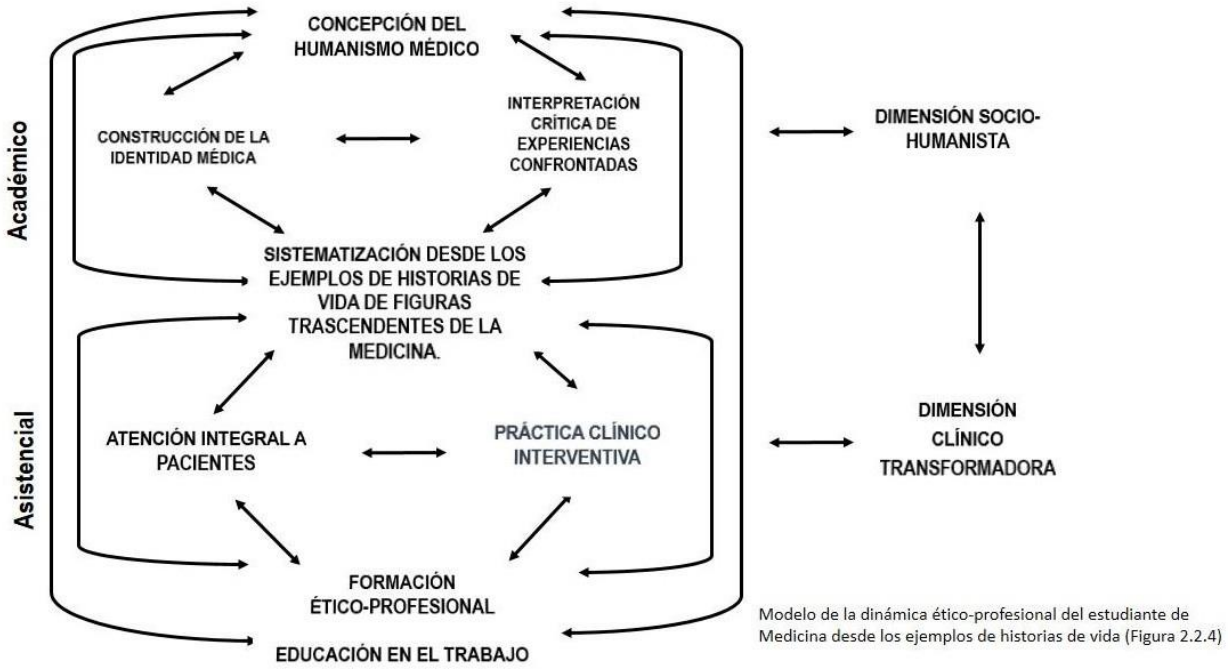
De este manejo adecuado de las relaciones humanas supone en el caso de los profesionales médicos, no solo el natural y espontáneo comportamiento comunicativo que lo acompaña desde su inicio en la vida laboral, requiere, además, del desarrollo de aprendizajes básicos vinculados a la consolidación del humanismo médico, de la sensibilidad humana y la espiritualidad, del modo de actuación en relación con una atención integral a pacientes.

No basta que el médico en formación logre un alto nivel de conocimientos y habilidades propios de su profesión, es necesario propiciar en él una disposición permanente para la formación ético-profesional y perfeccionamiento del humanismo, sus habilidades comunicativas, del modo de actuación y del respeto por las normas y valores universales que mejoran el desarrollo de las actividades profesionales.

En esta configuración, la formación ético-profesional en la educación en el trabajo es el espacio idóneo para lograr el desarrollo y aprendizaje de actuaciones profesiones dignas de admirar. El estudiante de Medicina diariamente presenta situaciones en su proceso formativo, donde estas se deben de concertar con el grupo de trabajo, por tanto, es el espacio idóneo para desarrollar acciones en la que se puedan prever contrariedades en los pacientes y familiares. En este sentido, la formación ético-profesional en la educación en el trabajo, se direcciona en la consolidación del humanismo médico, como componente más asistencial, desde la sensibilidad humana y la espiritualidad, de esos valores que se van desarrollando en todo el proceso formativo desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, de comportamientos éticos, con lo que hace y como es, lo que determina una práctica formativa con acción comprometida, esto tienen que ver como integración en los procesos de atención integral a pacientes, así como su vínculo a la resolución de problemas de salud. Se ha comprobado que los comportamientos éticos, por medio de la empatía, el modo de actuación de este en los escenarios profesionales y la asertividad dirigida

a la resolución de problemas de salud, los pacientes incrementan su estado de salud, trascendiendo en las relaciones sociales, proporcionando esperanzas de futuro para el paciente y su familia.

Modelo de la dinámica ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida.



Modelo de la dinámica ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de historias de vida (Figura 2.2.4)

Las relaciones que emergen desde el modelo de la dinámica ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida (Figura 2.2.4), son las siguientes:

- La relación conexa entre la construcción de la identidad médica y la interpretación crítica de experiencias confrontadas condiciona la proyección de la concepción del humanismo médico desde el proceso educativo desde lo más académico.
- La relación dialéctica de la atención integral a pacientes en vínculo con la práctica clínico-interventiva establecen la necesidad de la formación **ético-profesional en** la educación en el trabajo.

Revelado el modelo nos conduce que, para cada etapa del desarrollo en el proceso formativo del estudiante de Medicina modelado en la tesis, se determinan niveles que se definen como: grado de desarrollo que alcanza el

estudiante de Medicina que revela el tránsito hacia estadios superiores en su formación, alcanzando desarrollar un comportamiento ético acompañado de la conformación del modo de actuación, lo cual permitirá su valoración en la práctica de los patrones de logros de la metodología.

Lo que permiten intervenir al mismo tiempo en la solución a los problemas más generales y frecuentes en los escenarios profesionales, dimensionado desde lo socio-humanista en integración con la clínica-trasformadora. Los niveles declarados constituyen eslabones que propician sistematizar la formación de los valores compromiso, consagración y humanismo, necesarios para formar a este profesional, sustentados en el ejemplo de las Historias de Vida de figuras trascendente, contextualizada en el proceso formativo. Estos niveles se les denominan y argumentan de la siguiente manera (Figura 2.2.4):

Nivel 1: Sensibilización del compromiso social-responsable.

Nivel 2: Orientación de la actividad clínico-trasformadora.

Nivel 3: Trascendencia del humanismo médico.

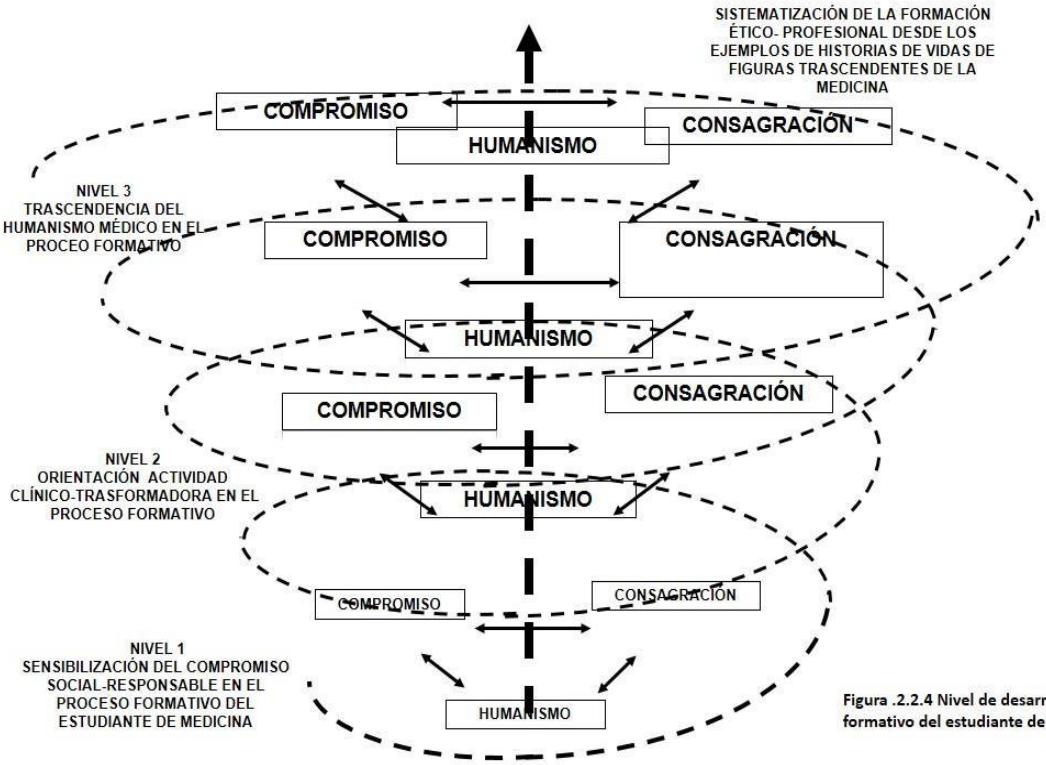


Figura .2.2.4 Nivel de desarrollo en el proceso formativo del estudiante de Medicina:

Nivel 1. De sensibilización del compromiso social-responsable

El nivel de sensibilización del compromiso social-responsable, este desarrollo formativo se corresponde con el tercer año de la carrera de Medicina bajo supervisión profesoral, se caracteriza por la sensibilización del estudiante de Medicina, desde los valores emergidos de figuras trascendentes de la Medicina como ejemplo, a partir de los resultados del diagnóstico de esta investigación, en cuanto a la necesidad de favorecer la formación ético-profesional en el proceso formativo.

Tiene como plataforma la interpretación crítica de experiencias confrontadas, a partir de la interacción reflexiva, el establecer relaciones empáticas entre los pacientes y sus familiares, lograr la significatividad de la experiencia, con la utilización de técnicas que promuevan la dinámica de lo individual y grupal. Motivar una comunicación activa, que aporte ideas previas para el proceso de reconocimiento y auto transformación en el proceso formativo del estudiante,

elevando el nivel de responsabilidad, compromiso social y profesional, la consagración y el humanismo médico ante las actividades designadas en la educación en el trabajo.

Este nivel de desarrollo formativo de sensibilización del compromiso social-responsable con la profesión, como cualidad, va a dar cuenta del cumplimiento del encargo social y profesional, revelado en un alto grado de competencia en el desempeño profesional, aptitud y responsabilidad con lo que se hace, atemperado a los momentos históricos en el que se vive, en función de aminorar el dolor humano, modifica los escenarios profesionales de salud, alcanzando indicadores superiores en los resultado de salud-enfermedad en contexto. Dentro de este, pues guarda relación dinámica con otros valores, desarrollando cualidades superiores que va dar cuenta del compromiso social responsable, la actividad clínica trasformadora y el humanismo médico, lo que ratifica una consonancia desde lo que se hace.

Implica esforzarse por representar lo que se predica, desde este eslabón, se trata de una invitación a aceptar el llamado, hacer algo que trasciende en la vida, hallarle sentido a la existencia a partir del aporte que se sustentan los valores que emergen desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina.

Nivel 2: Orientación de la actividad clínico-trasformadora

En este nivel se corresponde con el cuarto año de la carrera de Medicina, bajo supervisión profesoral, en este nivel se siguen sistematizando los valores anteriores a un nivel superior de desarrollo, en este sentido se expone una perspectiva profesional dinámica y personal que encuentra su principal mecanismo en el desarrollo de la autoformación humanista. Por tanto, parte desde un proceso trascendente, por la consolidación de una formación que se desarrolla fundamentalmente en las actividades de educación en el trabajo, que se expresa en su carácter formativo, a partir del desarrollo de un ámbito axiológico y bioético, en la consolidación de la sensibilidad humana y la espiritualidad, dando nuevos significados y sentidos al estudiante de Medicina.

Esto implica que la orientación en la práctica clínica exprese lo interventivo desde el reconocimiento, diagnóstico y tratamiento relacionados con la coherente interpretación que se realiza, lo cual trae consigo la autonomía del estudiante de Medicina, en momentos emergentes antes alguna afección médica, anteponiendo siempre los principios al mismo tiempo se encarga del desarrollo profesional del estudiante, en la medida que este proceso se interprete desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, facilitará los cimientos que proporcionan una mejor entereza de las situaciones y el desarrollo de valores como el compromiso, la consagración y el humanismo desde cualidades personales, sociales y profesionales en el estudiante de Medicina, de carácter más estable, capaces de transformar los escenarios profesionales, donde interactúa con los pacientes y sus familiares.

Nivel 3: Trascendencia del humanismo médico

El tercer nivel se corresponde con el quinto y sexto año de la carrera de Medicina donde el estudiante de forma independiente, bajo supervisión profesoral, el estudiante debe ser capaz de aplicar el método de trabajo de la profesión, el método clínico-epidemiológico. Todo lo cual le permite realizar al estudiante análisis general de la situación de salud, conjuntamente con el equipo básico de salud aplicando las tecnologías de la información, los métodos para la recolección, procesamiento, análisis y presentación de datos, y el plan de ejecución con la comunidad a su cargo, a partir del diagnóstico y la priorización de los problemas, cumpliendo con los requisitos éticos de toda investigación en la que participan sujetos humanos, así como prestar atención integral a pacientes en cualquier grupo de la sociedad, entre ellos la atención a grupos especializados, mediante las acciones de promoción de la salud del individuo, la familia y la comunidad, la prevención específica en individuos sanos y enfermos, la atención a pacientes ambulatorios, dispensarizados o no, o a enfermos hospitalizados, y la rehabilitación física, psicológica y social de aquellos que la requieran.

Este nivel de desarrollo formativo se corresponde con la trascendencia del humanismo médico como intencionalidad en el proceso formativo del estudiante de Medicina, de la autonomía y el logro del perfeccionamiento de la autoformación humanista en la educación en el trabajo, la toma de decisiones independientes del estudiante, para la

solución de los problemas más comunes o complejos en los escenarios profesionales. En este nivel, el humanismo médico se concreta en los tres niveles de desarrollo formativos que se propone en el modelo. Es el eslabón que dimensiona el humanismo médico desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, se concretan acciones en la educación en el trabajo donde el compromiso, la consagración se integran de manera holísticas expresan en su carácter totalizador, porque propicia reconocer la necesidad de sintonizar y concertar con el sujeto social (paciente y familia) en los escenarios profesionales.

Esta cualidad, el humanismo médico, parte de reconocer desde lo más asistencial, la atención integral a pacientes desde una práctica clínico-interventiva, va dar cuenta del nivel de autonomía autodeterminación del estudiante, expuesto en el intercambio profesional entre paciente, familia, profesores y alumnos, indivisible con el desempeño estudiantil competente.

El humanismo médico es el rasgo o cualidad del proceso de formación del estudiante de Medicina, que direcciona sus comportamientos éticos desde la sistematización de los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascedentes de la Medicina, de esos valores que emergen de la sistematización de la vida profesional y como este estudiante lo generaliza desde el modo de actuación en los escenarios profesionales. Lo que le permite incorporarlo en estadios superiores del desarrollo profesional médico lo que dan razón de la consolidación de la autoformación humanista**,** de esa sensibilidad humana y espiritualidad que debe de estar dotado este profesional, dando nuevos significados y sentidos al estudiante de Medicina.

Como elemento dinamizador, transita todo el modelo y da cuenta de la trascendencia de este, en el que el estudiante de Medicina, es capaz de incorporar en su proceso formativo.

La **regularidad esencial:** La relación que se establece entre lo individual, social y profesional, sustenta las trasformaciones del estudiante, desde lo académico y asistencial en relación con los valores consagración, compromiso y humanismo, síntesis de las relaciones esenciales del modelo, consolidando la formación ético-profesional.

Para llevar a la práctica el sistema de relaciones esenciales y la regularidad de la modelación realizada, se requirió de la elaboración y aplicación de una metodología de Sistematización Generalizadora desde Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, para la formación ético-profesional del estudiante de Medicina.

2.3. Metodología de Sistematización Generalizadora desde Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina para la formación ético-profesional del estudiante de Medicina

Los criterios de Alonso, Leyva y Mendoza (2019) se tienen en cuenta para la metodología de Sistematización Generalizadora desde Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina , para la formación ético-profesional del estudiante de Medicina; pues consideran que la metodología como resultado científico puede ser reconocida como un aporte práctico cuando establece en su componente instrumental, la propuesta de nuevas acciones que instrumentan en la práctica educacional una concepción teórica (pedagógica, formativa o didáctica) o un modelo formativo, educativo o didáctico (que puede ser aportado o no por el investigador que la construye o ser asumidos como referente teórico.

Se integran las etapas de los procesos de investigación humana y social identificados con el desarrollo a través de las etapas preactiva, activa y postactiva de Pérez (2001), con la relación dialéctica entre la sistematización y la generalización.

La autora de esta investigación asevera que la metodología tiene como requerimiento fundamental, una mirada capaz de prever las transformaciones en el mismo proceso investigado, lo que comprende desarrollar capacidades transformadoras de los sujetos implicados, desde un contexto real; flexible ante las posibles situaciones, que el propio desarrollo favorezca la formación de nuevos significados y sentidos, de manera que constituya una herramienta instrumental que permita obtener o generar nuevos conocimientos a partir de métodos que permite verificar y validar la realidad del objeto investigado, a su vez la solución del problema.

La metodología de Sistematización Generalizadora de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, no es más que un conjunto de procedimientos y acciones específicas, consciente, reflexiva, y concebidas a partir de las

Historias de Vida de uno o varios sujetos, que posibilitan reconstruir, identificar y reordenar elementos esenciales de la Vida estudiada, como resultado de una comprensión continua en su devenir profesional y un entendimiento que revela su realidad histórico contextual, propicia construir el acervo cultural, sobre el cual se sustente la educación de las generaciones actuales y futuras de profesionales.

La metodología de Sistematización Generalizadora de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, se sustenta en las potencialidades de los seres humanos estudiados, de caracterizar una situación concreta que sea auténtica y quede representada en su totalidad, lo que permiten interpretar y contribuir a la auto-transformación, individual, grupal y a los sujetos implicados o derivar consideraciones educativas diversas a otros sujetos desde los ejemplos de las figuras trascendentes, aporta nuevas relaciones en la dinámica del proceso.

La metodología de Sistematización Generalizadora desde Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, para la formación ético-profesional del estudiante de Medicina, se sustenta en dos métodos esenciales en este proceso formativo, el método de Historias de Vida con sus procedimientos definidos y el método clínico y epidemiológico desde sus diferentes formas de procedimientos y etapas de organización, que le dan respuestas a los principales problemas de salud de manera integral. Donde queda definido el papel del médico ligado al de la relación médico-paciente-familia lo que constituye su esencia más profunda. Materializado en el interrogatorio por medio de entrevistas profundas y el examen físico desde una relación humana afectiva.

El cumplimiento del método clínico y epidemiológico, como todo proceder científico, tiene un modo de hacer que no obstante debe ser consecuente con las necesidades de cada paciente, el compromiso, el humanismo con el paciente, desde esa atención integral desde una perspectiva interventiva, que exigen no solo el dominio y perfeccionamiento continuo de habilidades clínicas, enseñadas en las educación en el trabajo las que se aprenden y desarrollan plenamente solo durante esa práctica asistencial, sino que también este debe de ser un profesional consagrado con su profesión que no es más que una cualidad, una virtud, que desde lo profesional define a una personal, que se pone de manifiesto en su comportamiento, es hacerse algo que se vuelva sagrado o que alcance una posición de privilegio

por sus logros y se manifiesta en la dedicación, abnegación, esfuerzos sin límites, motivado en su labor, lo que te ratifica una identidad desde lo que se hace.

Los métodos se integran hacia una lógica que permite desarrollar los procedimientos en cada una de las etapas desarrollada en la metodología. Los mismos son coherente con las dos dimensiones que conforman a su vez el cuerpo categorial. Estas dimensiones son:

1. Dimensión socio-humanista en el proceso formativo del estudiante de Medicina.
2. Dimensión clínico-trasformadora en el proceso formativo del estudiante de Medicina.

En el aparato teórico de la metodología se asumen dos principios pedagógicos.

Principio de la vinculación de la educación en el trabajo

1. La esencia de este principio está dada en propiciar la participación del educando en el conocimiento valoración y transformación de la salud del individuo (método clínico) y la población (método epidemiológico) con la conducción (orientación, modelación, monitorización) del profesor. Tal es la esencia de la concepción ilizastiguiana de la educación en el trabajo, además de métodos como forma principal de enseñanza para aprender la Medicina, constituyéndose en el principio rector de la educación médica cubana.

   Las Ciencias Médicas solo pueden aprenderse en la práctica integrada con actividades de estudio congruentes. Sacar a los estudiantes de las aulas y anfiteatros y llevarlos donde están los pacientes (hospitales y policlínicos). Ninguna habilidad, destreza, conducta apropiada se conseguirá por la lectura de textos, conferencias magistrales, demostraciones clínicas esporádicas (comunicar, palpar, auscultar, diagnosticar, tratar y realizar planes terapéuticos). No se trata de un enfoque empírico, aprender solo trabajando, sino se requiere de la acción instructiva/educativa del profesor interactuante como modelo profesional a ser reproducido y transcripto, más del estudio correspondiente.

   La integración de la docencia, asistencia e investigación (IDAI), la relación entre la práctica docente, la práctica investigativa y la práctica clínica, deben responder a la integración, bajo la categoría principal por excelencia

de la actividad humana: la práctica social transformadora. La formación de los estudiantes a partir de la práctica clínica, en estrecha relación médico-paciente-familia, como fuente de aprendizaje y educación, complementada en las actividades designadas en la educación en el trabajo.

2. Principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo. La ascensión de este principio significa ser consecuente con la finalidad de la metodología, la cual busca el desarrollo desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, roles que debe desarrollar desde labor educativa que dirija el proceso formativo en la educación médica. El cual plantea la necesidad de conocer los intereses profesionales e individuales de los estudiantes de Medicina, lo que permite motivarlos, orientarlos y guiarlos en la consecución de la actividad. Algunos de los procedimientos que evidencian el sustento de este principio están dadas en las etapas preactiva y activa de la metodología, donde los especialistas-docentes, profesores, estudiantes y las propias figuras por medio del procedimiento de interacción motivacional, revelando nuevos significados y sentidos para los sujetos implicados, lo que permite contribuir a la auto-transformación, individual y grupal.
3. Metodología constituye una forma concreta de expresar el sistema de relaciones y la regularidad esencial, revelada en el proceso formativo del estudiante de Medicina. Se estructuró en objetivo, premisas, cualidades en tres etapas cada una con sus procedimiento y patrones de logros en relación con las dimensiones como se observa (Figura 2.3.1) fundamentalmente en la etapa postactiva introduciendo la sistematización científica y su connotación generalizadora, que permite revelar nuevos significados; conceptos, categorías y relaciones, que constituyen un replanteamiento del proceso estudiado y con ello un aporte práctico y teórico. En cada etapa del proceso se desarrolla un método con los correspondientes procedimientos, que se desarrollan o a partir de patrones de logros.

Premisas de la metodología:

- Requerimiento de políticas y proyecciones para la formación de valores éticos en la formación del estudiante de Medicina.

- Compromiso de la institución de salud con la formación práctica-docente-asistencial del estudiante de Medicina. para garantizar el desarrollo de la excelencia médica en la atención integral a pacientes.

- Posibilidad de resignificar la relación médico-paciente-familia en la lógica desde los comportamientos éticos del estudiante de Medicina y su proyección en los escenarios profesionales.

- Escasa presencia en el proceso formativo del estudiante de Medicina estudio de las Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina y su ejemplo en la labor educativa.

Sin embargo, la implementación de la metodología que se propone no se reduce solo a estas premisas o condicionantes, sino que también debe precisar las cualidades, los cuales emergen de la valoración contextual realizada, como aspiración que encauza la elaboración y aplicación de este instrumento y condición imprescindible para su existencia y perfeccionamiento.

Requisitos de la metodología:

- Articular la nueva dinámica propuesta en los contenidos, formas y métodos en el proceso formativo del estudiante de Medicina, para garantizar un redimensionamiento. Esto determina la necesidad de hacer cambios en las actividades académicas, y consecuentemente, en lo asistencial dimensionando los comportamientos éticos del estudiante de Medicina en su quehacer profesional.
- La formación del estudiante de Medicina, debe ser direccionada y supervisada por especialistas-docentes o profesores con experiencia en el proceso formativo.

- Realización de un diagnóstico de las potencialidades del estudiante y de los especialistas-docentes y profesores implicados en la dinámica del proceso, que tome en cuenta sus intereses educativos y profesionales, nivel de compromiso y expectativas para proyectar las acciones de la metodología.
- Sensibilización y responsabilidad de los actores implicados en el proceso formativo de reconocer el valor de la labor educativa, desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina.
- Los implicados deben estar positivamente dispuestos para asumir esta metodología como instrumento pedagógico novedoso, que integre la atención integral a pacientes desde una práctica clínico-interventiva con una visión holística, desde lo ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendente de la Medicina y su labor educativa en el proceso formativo.

La precisión de las premisas y requisitos declarados permite determinar el **objetivo general** de la metodología: Contribuir a favorecer la formación ético-profesional del estudiante de Medicina, desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, para la apropiación de comportamientos éticos en los escenarios profesionales donde interactúan con el paciente y sus familiares, con una proyección humana auténtica.

Las características de la metodología son las siguientes:

- Carácter afectivo: tiene en consideración la valoración del estudiante acerca de sus propias cualidades personológicas, de ahí que posibilite el auto perfeccionamiento en este proceso formativo.
- Carácter vivencial y participativo: desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina. y en la que estos deben movilizar todo su potencial reflexivo en función de su autorreconocimiento.
- Cognoscitiva: permite comprender a los especialistas-docentes en los escenarios profesionales como

mediadores en las acciones de enseñanza-aprendizaje para la sistematización del contenido ético-profesional en el proceso formativo, a favor del (estudiante-grupo), ente activo y protagonista desde el aprender haciendo, según las potencialidades y necesidades de aprendizaje de cada estudiante.

- Integradora: se interrelacionan y complementan la orientación didáctica y la facilitación sistematizada para la construcción significativa del comportamiento ético del estudiante de Medicina.
- Flexible: puede adaptarse a los diversos contextos formativos en que se desarrolle, organizarse de acuerdo con las circunstancias concretas que se presentan.
- Factible: su aplicación es compatible con las exigencias del Modelo del Profesional que se pretende alcanzar en la educación médica, con énfasis en la sistematización de los contenidos éticos-profesionales en la carrera de Medicina.

La práctica médica combina las ciencias de la vida con el humanismo, es ciencia y arte, válida en el proceso formativo del estudiante de Medicina, Por tanto, es de máxima exigencia para la implementación de la metodología de Sistematización Generalizadora desde Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, para la formación ético-profesional del estudiante de Medicina aspectos fundamentales:

- El dominio de las características psicopedagógicas del estudiante que se encuentran en el proceso formativo, atendiendo a las diferencias según los grupos etarios en que se encuentran y el contexto de salud en que se desarrollan.

- Dominio del sistema categorial conceptual sobre formación ético-profesional, ética, humanismo. Los métodos y procedimientos pedagógicos que se cumplen deben propiciar en el estudiante de Medicina un pensamiento reflexivo, flexible en función de su desarrollo individual, profesional y social que le permitan las trasformaciones actuales que se requieren en la forma inicial del médico, con cualidades humanas que favorezcan la relación médico-paciente-familia, en aras de realizar adecuadamente su encargo social.

Formación humanista: Se relaciona con el desarrollo de actitudes y valores que se encaminan en la autoformación humanista**.** De esta manera, un sujeto formado desde la dimensión humana, actúa como esquemas de valorares, coherentes, propositivos y propios. Es un ser que reconoce su papel en la sociedad, en la institución para la que trabaja y en la familia; comprende la diversidad cultural en la que está inmerso; es en consecuencia con un sujeto desarrollado (Cedeño, 2020).

Desarrollo ético-profesional: Se define, como el proceso permanente, social y humano que promueve las capacidades trasformadoras, que hacen y mejoran al desarrollo de las actividades profesionales, y determinan los comportamientos éticos con el modelo profesional, que permite un nivel superior de regulación y autorregulación comportamental y de normas, a partir de las exigencias de la sociedad, todo lo cual beneficia una mejor correlación con su entorno y consigo mismo (Zaldívar, Cedeño, Marañón y Vinent, 2022).



Figura 2.3.1. Metodología de Sistematización Generalizadora desde Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina

Esta metodología dispone de un conjunto de procedimiento para su aplicación, que deben tenerse en cuenta por los especialistas-docentes como mayor responsable en el proceso evaluativo.

Procedimientos de la metodología en la etapa pre-activa:

1. Desarrollar un diagnóstico inicial, que permite identificar los aspectos trascendentes de la vida de la personalidad o colectivo.

Para lo cual se diseñan triangulaciones sucesivas de la información que se obtiene, como de los métodos y técnicas que serán empleados, que por lo general son los propios de las investigaciones humanas y sociales a saber:

- Las de obtención de datos primarios, como ejemplos están; las encuestas, entrevistas y testimonios.

  Las encuestas han de ser redactadas que impliquen una respuesta concreta y esencial sobre las personalidades o colectivo humano estudiados, cumpliendo con el objetivo de que el encuestado sea preciso en aquellos aspectos realmente significativos, lo que es contrario a la elaboración de encuestas con muchas preguntas que terminan con respuestas sin profundidad.

  Las encuestas se aplicarán a sujetos que expresen opiniones desde posiciones contrapuestas, pero implicados en el proceso en el que se desarrollan los casos estudiados.

  Otro aspecto a tener en cuenta es asegurar, a los encuestados que su opinión quedará en el secreto, evitando en los créditos de la encuesta se pueda determinar quien respondió la encuesta, al poner datos por los cuales se pueda identificar.

  De igual manera que el encuestado tenga la seguridad, que su encuesta no está marcada y que al entregarla lo haga a través de un buzón y no de forma directa. Estas consideraciones aseguran la certeza de las opiniones, ajenas a influencias.

- Las de obtención de datos secundarios, cuyas fuentes pueden ser los estudios de perfiles bibliográficos y los métodos documentales en sus diferentes soportes.

En la triangulación de los datos primarios o secundarios se seguirá con alternativas tales como:

Relación de los resultados de las encuestas a discentes y docentes, como implicados en un proceso de formación.

Relación entre los resultados de las entrevistas y las evidencias documentales que avalan la obra de la personalidad o grupo colectivo humano.

2. Redactar una síntesis que justifica la realización de la investigación de Historias de Vida y la obra de la personalidad o colectivo humano. Donde se identifican los aspectos, resultados y hechos que se consideran relevantes. Determinar los ejes de sistematización, se convierten en canales orientadores del proceso investigativo a través de la metodología.
3. Determinar las sub-etapas comprendidas dentro de la etapa activa, para lo cual se han de delimitar los resultados que han caracterizado cada sub-etapa y su desempeño por la personalidad o colectivo humano.
4. Determinar de los métodos y técnicas para la obtención de la información en cada una de las sub-etapas de la etapa activa, en dependencia del sector en que se desarrolla la personalidad o colectivo que se estudia y de su propia trayectoria social, científica, del arte, la academia, entre otros.

Procedimientos de la metodología en la etapa activa:

1. Aplicar los instrumentos referidos y en la propia aplicación se identifican nuevos aspectos de la vida, de la personalidad o colectivo, que requieren ampliar los instrumentos considerados, para esclarecer los conceptos y categorías que identifican los aspectos considerados en cada sub-etapa.
2. Analizar de la información obtenida del contexto en que se desarrolló la vida de la personalidad o colectivo, que caracterizan las sub-etapas en la trayectoria por la que ha transcurrido la vida activa, acorde a las sub-etapas.
3. Identificar la obra (científica, técnica, artística...) en cada sub-etapa, según los conceptos, categorías y relaciones en la obra en cada sub-etapa. A partir de los resultados de entrevistas, testimonios, encuetas, entre otras

4. Determinar mediante categorías y relaciones que caracterizan de los productos (textos, artículos, objetos) que revelan la obra.
5. Triangular la información, para verificar la misma, contraponiendo las diferentes fuentes, para lo cual se determina un esquema de triangulaciones sucesivas, que pueden generar nuevos instrumentos y fuentes de información.
6. Determinar las categorías y relaciones que caracterizan cada sub-etapa de las Historias de Vida estudiadas, resultado de la aplicación de la triangulación de la información**.**

Procedimientos de la metodología en la etapa post-activa:

1. Sistematizar la trayectoria de la vida, según los conceptos, categorías y las relaciones entre ellas, que emergen de las sub-etapas, lo que determina los aspectos considerados relevantes y las relaciones que expresan las cualidades que caracterizan la vida de la personalidad o colectivo estudiado.
2. Generalizar las relaciones, como regularidad que caracteriza el comportamiento de la personalidad o colectivo, a lo largo de la vida y constituye un aporte para la ciencia, la tecnología, el arte, la educación de otros profesionales o en general los sujetos del sector, con un enfoque holístico (integrador).
3. Aplicar la Sistematización Generalizadora para determinar las relaciones dialécticas entre las categorías, conceptos esenciales y relacionales, como aporte teórico que constituye la esencia en la obra, como generalización de las Historias de Vida de figuras trascendentes.
4. Generalizar las relaciones, como regularidad que caracteriza el comportamiento de la personalidad o colectivo, a lo largo de la vida y constituye un aporte para la ciencia, la tecnología, el arte, la educación de otros profesionales o en general los sujetos del sector, con un enfoque holístico (integrador).
5. Estructurar y argumentar el aporte teórico y práctico desde la formalización, de categorías relaciones y regularidades como resultado final para la comunicación de los aprendizajes.

Criterio evaluativo

La precisión de la intencionalidad formativa en el proceso de formación del estudiante de Medicina, correspondiente a cada procedimiento en las etapas de desarrollo de la metodología de Sistematización Generalizadora desde Historias de Vida de figuras trascendentes, para el desarrollo de comportamientos éticos del estudiante, a partir de diferentes niveles de evaluación sobre la base del desarrollo de valores compromiso, consagración y humanismo, la integración de las dimensiones socio-humanista y la dimensión clínico-trasformadora.

Los comportamientos éticos en los escenarios profesionales serán sistematizados y generalizado desde los valores emergidos de figuras trascendentes de Medicina como ejemplos, coexistirá en expresión de los logros alcanzados, estructurados en niveles para la formación ético-profesional del estudiante de Medicina (Anexo No. 10).

Lo anterior, posibilita que el estudiante de Medicina en su proceso formativo, puedan exhibir las cualidades humanas desde los ejemplos de figuras trascendentes de Medicina y de esta forma, sistematizarlas y generalizarla, que trasciendan en los escenarios profesionales donde interactúan con el paciente y sus familiares.

Por tanto, en la esencia de cada etapa de la metodología, está la lógica para la apropiación de los valores compromiso, consagración y humanismo desde lo académico y asistencial en el propio proceso formativo, En cada etapa se hace un seguimiento a la formación ético-profesional del estudiante de Medicina en las actividades de educación en el trabajo, dando continuidad a la etapa anterior. No ha finalizado el proceso, por tanto, se puede corregir aspectos que no hayan quedado resueltos y requieran mayor atención personalizada. Las etapas, coexisten de forma holística. Se recomienda emplear como forma de evaluación los patrones de logros antes expuestos.

Conclusiones parciales del Capítulo 2

- Las consideraciones teóricas que emergen de la valoración de diferentes fundamentos epistemológicos, se dirigen a la elaboración de un modelo de la dinámica ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida**,** el cual revela las relaciones esenciales entre las configuraciones que lo integran, conduce a la interrelación entre sus dimensiones: la dimensión socio-profesional y la dimensión

trasformativa ético-humanista.

- Al revelar las relaciones esenciales que se establecen entre las dimensiones, emergen como cualidades esenciales, la lógica integradora entre la construcción de la identidad médica y la interpretación crítica de experiencias confrontadas; la relación entre la atención integral a pacientes y la práctica clínico-interventiva en contexto de salud.
- Como regularidad esencial de este modelo, aparece la sistematización desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, como eje formativo del proceso de formación ético-profesional, donde emergen cualidades superiores que se van desarrollando desde lo académico a lo asistencial en integración con el método clínico-epidemiológico en el proceso formativo, valores que se van a revelar a partir de investigaciones orientadas por el profesor en cada una de la especialidades en que el estudiante va transitando, aseverando los comportamientos éticos del estudiante de Medicina.
- La metodología elaborada constituye el instrumento esencial que complementa el desarrollo de la formación ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, para asumir comportamientos éticos en los escenarios profesionales donde interactúa con el paciente y sus familiares.

Capítulo 3.

Valoración de la pertinencia y la factibilidad del modelo de la dinámica ético–profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida y la metodología propuesta

CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA Y LA FACTIBILIDAD DEL MODELO DE LA DINÁMICA ÉTICO-PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE DE MEDICINA DESDE LOS EJEMPLOS DE HISTORIAS DE VIDA Y LA METODOLOGÍA PROPUESTA

Introducción

En el presente capítulo se exponen los resultados, en la valoración del aporte teórico y práctico de la investigación, referidos al modelo de la dinámica ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida. Se muestra también la metodología para la formación ético-profesional como parte de las acciones, para la valoración de la pertinencia y la factibilidad de ambos.

Se realiza el análisis de los resultados obtenidos en los talleres de socialización con especialistas-docentes y profesores, para valorar la pertinencia científico-metodológica del modelo y la metodología Se presenta la aplicación de dicha metodología en el Hospital General "Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso", de Santiago de Cuba, lo que permitió revelar el perfeccionamiento del proceso y mostrar sus principales impactos a partir de la implicación del estudiante de Medicina, especialistas-docentes, profesores y las propias figuras en la realización de las acciones propuestas.

3.1 Valoración científico-metodológica de los aportes fundamentales de la investigación a partir de la realización de talleres de socialización con especialistas-docentes y profesores

La búsqueda de valoraciones en torno a la pertinencia científica de los principales resultados de la investigación se realizó, esencialmente, mediante un proceso de socialización integral entre los académicos, especialistas-docentes y profesores responsabilizados con el trabajo educativo en la educación en trabajo, que puedan aportar en sus criterios, revalidación y enriquecimiento, con visiones diversas y justificaciones conceptuales y prácticas.

Para la realización de los dos talleres de socialización con especialistas-docentes, profesores, fue necesario

primeramente la precisión del objetivo de la aplicación de la metodología y a continuación establecer la selección de los especialistas.

1. Precisión del objetivo de la aplicación de la metodología.

La metodología se socializó con los especialistas-docentes y profesores, se utilizó con el objetivo de obtener juicios valorativos y para que esto alcanzara una comprensión por parte de la comunidad científica especializada, para llevarlo a la práctica formativa desde cada una de la etapas de la metodología, además de la valoraciones pertinente de la factibilidad del modelo y la metodología para la formación ético-profesional del estudiante de Medicina, a fin de perfeccionar y enriquecer la propuesta.

2. Selección de los especialistas-docentes y profesores.

Con este propósito se aplicó una encuesta a 50 especialistas-docentes y profesores responsabilizados con el trabajo educativo en la educación en trabajo, para valorar y hacer recomendaciones sobre el sustento teórico y metodológico que se desarrollan en la metodología diseñada para la formación ético-profesional del estudiante de Medicina.

Los criterios de inclusión de los especialistas-docentes y profesores fueron:

- Desempeño profesional relacionado con el proceso de formación ético-profesional en los diferentes escenarios de salud.
- Más de 10 años de experiencia en la formación del estudiante de Medicina.
- Categoría docente.
- Categoría científica.

La población de especialistas-docentes estuvo integrada por 50 profesionales que tienen como promedio 20 años de experiencia profesional y conocimientos sobre el proceso de formación ético-profesional del estudiante de Medicina, entre ellos se cuenta con Doctores en diferentes modalidades de ellos 12 de Ciencias Pedagógicas, Máster en

Ciencias, de diferentes especialidades de la salud y en educación superior. Todos los especialistas-docentes y profesores seleccionados poseen la categoría docente superior y evaluación de excelente en su desempeño docente. El 100 % de los especialistas-docentes seleccionados (50) poseen experiencia profesional sobre la temática que se investiga, se desempeñan en diversos cargos, lo cual permite una mayor precisión, diferentes miradas a la problemática objeto de estudio en la presente investigación a partir de la experiencia personal y el nivel de conocimientos alcanzados.

En sentido general, se corrobora como satisfactoria la selección de los expertos para valorar la factibilidad de la aplicación en la práctica de la metodología para la formación ético-profesional del estudiante de Medicina, siendo necesario considerar metodológicamente la estructuración en dos momentos (Anexo No. 7):

3. Talleres de socialización con los especialistas-docentes y profesores.

En un **primer momento** por el que transitó los talleres de socialización con los especialistas-docentes y profesores se realizaron las siguientes acciones:

- A los participantes, se les entregó anticipadamente un informe contentivo de los aportes teórico y práctico de la investigación, para su valoración crítica.
- Exposición de las ideas sistematizadas en correspondencia con el diseño de la investigación y argumentadas dentro de la fundamentación teórica y praxiológica del objeto y campo de acción investigado.

Exposición de los fundamentos del modelo de formación ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida y de la metodología para la formación ético-profesional del estudiante de Medicina.

En un **segundo momento** del taller de socialización con los especialistas-docentes y profesores se procedió a:

- Intercambiar entre los especialistas-docentes, profesores y la autora, a través de la exposición de criterios valorativos, preguntas y respuestas, acerca de las principales fortalezas y debilidades de los aportes, así como acertadas sugerencias para su perfeccionamiento.

- Realizar la relatoría del debate de conocimientos y propuestas prácticas por razón de intervenciones de los participantes desde un diálogo productivo.

En el documento de relatoría confeccionado, se evidencian las siguientes ideas:

Los expertos consideraron oportuna la elaboración de la metodología que se propone, para perfeccionar la estrategia educativa con que se cuenta en la Universidad Médica, en función de la atención al desarrollo de los comportamientos éticos del estudiante de Medicina en los escenarios profesionales, donde interactúa con el paciente y sus familiares. En la realización de los talleres, se observó la necesidad de los tutores de concientizar su función educativa en el acompañamiento del estudiante de Medicina; en cuanto al enfoque humanista, mostraron entereza al cambio, fueron conservadores, sobre todo en la realización de los encuentros, interviniendo según sus criterios la carencia de espacio y de tiempo.

- Fue preciso esclarecer que, a pesar de la multiplicidad y versatilidad heterogénea del claustro pedagógico desde diferentes matices, el propósito fundamental de la metodología que se aplica, es la formación ético-profesional del estudiante de Medicina, la que merece ser utilizada por el docente en función del trabajo educativo.
- Precisaron que se explicara el contenido desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina y surgieron cuestiones relacionados con la diferenciación de este con los objetivos de la formación de valores, lo cual se precisó en la fundamentación epistemológica.
- Sugirieron profundizar en las definiciones aportadas, para significar solo los rasgos necesarios y suficientes en ellas. Esta apreciación se tuvo en cuenta para el perfeccionamiento del modelo propuesto.
- Sugirieron realizar distinciones en las categorías utilizadas para nombrar las dimensiones del proceso de formación ético-profesional del estudiante de Medicina. Esta valoración se tuvo en cuenta para el perfeccionamiento del modelo propuesto y se realizaron los arreglos pertinentes.

- Los críticos resaltan la intencionalidad de la metodología propuesta para propiciar la autoformación de comportamientos éticos del estudiante de Medicina, que necesita para establecer relaciones sociales y profesionales positivas en los escenarios profesionales.
- Aprecian la consagración profesional y social como valor, implica esforzarse por significar lo que se predica, desde esta perspectiva, se trata de una invitación a aceptar el llamado a hacer algo que trasciende en la vida, hallarle sentido a la existencia a partir del aporte que se hace desde lo profesional y social, desde lo humano del sujeto, consagrado(a) solo si es posible y sentir en el corazón que todo aquello que se hace es realmente su vocación.
- Las opiniones emitidas resaltan la impronta pedagógica y metodológica de la propuesta y enfatizan en su factibilidad y viabilidad en la práctica educativa del estudiante de Medicina.
- Se demuestra la cientificidad de las propuestas para la viable solución del problema científico planteado. Los aspectos presentados denotan los criterios positivos en los expertos que fueron seleccionados para participar. Es preciso señalar que no se ofrecieron criterios en sentido contrario, sobre la pertinencia, la actualidad, cientificidad y novedad del modelo y la metodología para la formación ético-profesional del estudiante de Medicina.
- También se evidenció, a partir de las argumentaciones empleadas en incuestionables respuestas, que los resultados emanados trascienden en el logro de un profesional con cualidades que diferencian sus comportamientos éticos, la que se distingue en valores esenciales en la profesión, el compromiso, la consagración y el humanismo médico, que responde a las necesidades actuales de la sociedad.

Por otra parte, resultó fundamental el procedimiento de la triangulación para ser contrastada la información desde fuentes diferentes. En este momento se aúnaron los resultados de las encuestas con los criterios de los expertos, convocados por segunda ocasión y se procedió a contrastar la información obtenida a través de la opinión crítica de

los especialistas-docentes y profesores, así como las entrevistas realizadas en diferentes espacios y tiempos, se pudo comprobar que los resultados obtenidos son sólidos.

Se llegó a la conclusión, después de perfeccionada la valoración científica, de que estos resultados investigativos son novedosos y pertinentes, lo cual permitió pasar a una nueva tarea, que se concretó en poner en práctica la metodología para la formación ético-profesional del estudiante de Medicina.

3.2. Ejemplificación de la aplicación de la metodología para la formación ético-profesional del estudiante de Medicina y valoración de los resultados obtenidos en la práctica

La metodología resultado de la presente investigación fueron sometidos a la consideración de los expertos seleccionados por medio de talleres de socialización, se estructuró dentro del tipo de investigación cualitativa, lo cual permitió la aplicación de la metodología con la muestra seleccionada de tercer año de la carrera para darle continuidad en el seguimiento que incluye la metodología hasta el 6to año para favorecer un mayor desarrollo en los comportamientos éticos del estudiante de Medicina, donde interactúa con el paciente y sus familiares.

La implementación inició con un primer momento de sensibilización a los estudiantes acerca de la importancia de los comportamientos éticos con la profesión, por la connotación social y profesional, que adquieren en la provincia y la necesidad desarrollar acciones más eficientes en las actividades de educación el trabajo designadas, para perfeccionar su práctica clínica desde lo interventivo asistencial en la atención integral a pacientes.

Así mismo se aplicaron algunas técnicas de dinámica grupal para favorecer el intercambio entre los participantes. A partir de esta motivación inicial, se determinaron las insuficiencias en el proceso formativo del estudiante de Medicina. Esto garantizó la efectividad, refuerzo y contribución al desarrollo, desde los ejemplos de figuras trascendentes. De igual forma, se planificó el proceso formativo, a partir de indagar en las experiencias y conocimientos previos de los estudiantes acerca de las vías y alternativas seguidas por ellos para la atención integral a pacientes, lo que promovió posiciones estimulantes para el desarrollo de los contenidos y un clima favorable para el intercambio y reflexión grupal.

La precisión de la intencionalidad formativa en el proceso de formación del estudiante de Medicina, correspondiente a cada procedimiento en las etapas de desarrollo de la metodología de Sistematización Generalizadora desde Historias de Vida de figuras trascendentes de Medicina para el desarrollo de comportamientos éticos, a partir de los niveles de sensibilización del compromiso-responsable, la orientación de la actividad clínico-trasformadora y la trascendencia del humanismo médico, revelado desde patrones logros, en integración con las dimensiones socio-humanista y la dimensión clínica-trasformadora.

Por tanto, en la esencia de cada etapa de la metodología está la lógica para la apropiación del estudiante de Medicina de los valores fundados desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, en esta etapa se argumenta la Historia de Vida del Dr. C. José Miguel Goderich Lalán, como ejemplo.

RESULTADO ETAPA PRE-ACTIVA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

1. Se Desarrolla un diagnóstico inicial, que le permite al estudiante precisar que figura trascendente va a investigar, en este caso se tiene en cuenta el ejemplo del Dr. C. José Miguel Goderich Lalán.
2. Se caracteriza la trayectoria de la vida y los indicadores considerados. Se determinan posibles sub-etapas en la etapa activa.
3. Acciones intencionadas de la investigadora, profesores, estudiantes a partir del estudio de la figura trascendente por medio de métodos: entrevistas y encuestas a personas clave.
4. Diseño de Instrumentos para caracterizar la Historia de Vida.
5. Determinar los métodos y técnicas para la obtención de la información, los que se seleccionaron: ejemplo de testimonios de personas claves y de la misma figura trascendente, entrevistas a amigos y familiares que se relacionaron con la figura en cada una de las sub-etapas seleccionadas y su desempeño, se grabaron y se

hicieron videos como evidencias reconocidas en este proceso investigativo, también se revisaron fuentes documentales, textos publicados y otros.

Se realizan las acciones fuera del horario de clases, en encuentros extracurriculares del proceso formativo, a partir de talleres grupales entre los estudiantes, profesores participantes y la investigadora.

RESULTADOS DE LA ETAPA PRE-ACTIVA:

1. Se precisan dos sub-etapas a desarrollar en la Etapa Activa del proceso formativo.
2. Se precisan las tres etapas de la Historia de Vida del Dr. C. José Miguel Goderich Lalán.
3. Se concibe cómo incorporar el contenido y las experiencias de la Historia de Vida al proceso formativo, formas y métodos.

ETAPA ACTIVA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN:

I. Aplicación de los instrumentos diseñados en la etapa pre-activa.

II. Incorporación de los resultados de la caracterización al proceso formativo. Desarrollo de talleres grupales para la formación ético-profesional del estudiante de Medicina.

III. Desarrollo de las dos sub-etapas.

1. Primera sub-etapa de reconocimiento de los valores y particularidades de la figura.
2. Segunda sub-etapa de inserción del contenido asumido desde las experiencias confrontadas y su aplicación en el proceso formativo, a través de las diferentes formas de educación en el trabajo.

RESULTADOS DE LA ETAPA ACTIVA

La sistematización de la historia de la vida del Dr. C. José Miguel Goderich Lalán, como ejemplo.

En este momento se hace referencia al ejemplo de la Historia de Vida del Dr. C. José Miguel Goderich Lalán como figura trascendente de la Medicina, lo que no significa que se haya trabajado en el proceso formativo del estudiante

de Medicina solamente con esta figura trascendente, sino que esto es un ejemplo de Sistematización Generalizadora de Historias de Vida para la formación ético-profesional del estudiante de Medicina.

Se dará la opción a los estudiantes que tengan alguna inquietud y deseen plantearla de forma individual, lo que propiciará el tratamiento individualizado, a partir de la exploración de valoraciones, puntos de vistas, motivos, actitudes, conductas, rasgos, conflictos y otros aspectos del estudiante de Medicina (individual y grupal), lo cual se necesita para ejercer influencias educativas. En este primer taller se parte del conocimiento que poseen los estudiantes sobre la exploración de esta temática y se accedió a que mostraran sus necesidades en tal sentido.

Se ejemplifica la Historia de Vida de una figura trascendente de la Medicina, que impacta en el proceso formativo del estudiante, por ser distinguido entre la multitud médica, reconocido por su quehacer profesional y social. Esto permitió tenerlo en cuenta, como modelo de profesional, revelando los valores que emergen de su vida profesional.

Este eminente profesional reconocido más allá de su contexto, aportó en los estudiantes de Medicina nuevas relaciones en la dinámica de este proceso, se tomaron criterios a partir de las entrevistas, testimonios, revisión de literatura

La triangulación de estos instrumentos aplicados, reveló el esclarecimiento de las particularidades pedagógicas que articulan el legado histórico educativo y la resignificación pedagógica de su vida profesional, el recorrido por su vida profesional, posibilita un acercamiento al contexto y a la realidad que le rodea, la aptitud de los cambios que le fueron afectando y la evaluación de su experiencia. Con ello, se ofrece desde el punto de vista histórico pedagógico las transformaciones que le fueron necesarias para vivir en un contexto histórico determinado y los aspectos adaptativos de sus distintas experiencias interpersonales e institucionales.

Se construye una comprensión sistemática de la Vida profesional del doctor en Ciencias Médicas José Miguel Goderich Lalán, no como una cronología sucesiva de acontecimientos, sino más bien como consideraciones fundamentadas en una historia viva, tomando solo los sucesos más relevantes de su devenir profesional, reconocido desde los valores que la autora reconoce a partir de los testimonios de amigos, colegas y familiares, todo lo cual dan

razón como sucesos trascendentales, para de esta forma establecer los valores más notables como aspectos de una dimensión personal y a su vez contextual.

La necesidad de abordar estos contenidos conduce a la autora a la reflexión de que en la historia de la pedagogía médica, son pocos los estudios realizados de este tipo y las acciones pedagógicas que se han identificado como aporte educativo se han quedado en un plano más descriptivo, sin tener en cuenta los ejemplos de la Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina y sus valor en el proceso formativo, como elemento que sirva de iniciativa para desarrollar valores ignorados en los estudiantes de Medicina, que permita consolidar valores éticos como: el compromiso social y profesional, la consagración en su quehacer y ser revelado en el amor profesional, contemplado en su proyección humanista.

El Dr. C. José Miguel Goderich Lalán, nacido el 25 de noviembre de 1944 y natural de Santiago de Cuba, José Miguel Goderich Lalán, destacado doctor en Ciencias Médicas, cirujano general, profesor de mérito, titular y consultante de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Durante ocho años fue presidente de la Sociedad Cubana de Cirugía, y en el momento de fallecer era su presidente de honor, además de presidente del Capítulo de Santiago de Cuba.

Miembro de la SILAC y responsable del Comité Hernia de la FELAC, fue jefe del Servicio de Cirugía General por más de 27 años y profesor principal de la asignatura durante 30 años. En el marco del IX Congreso de Cirugía Italia-Cuba, que fue auspiciado por la Universidad de Roma La Sapienza y celebrado en el Palacio de Convenciones de La Habana el 24 de abril de 2017, le fue otorgado, junto a otras dos personalidades cubanas, el Premio de la Fundación AILA, homenaje por la obra de toda su vida.

Experto internacional en la cirugía herniaria, ha participado en todos los congresos o reuniones mundiales relacionados. Participó como invitado de honor a 39 Congreso de la Sociedad Europea de Hernias, participó en el Palacio de los Congresos de Viena, del 24 al 28 de mayo de 2017, donde presentó los trabajos Evolución de la cirugía herniara en Cuba y Estudio comparativo entre distintas suturas en el cierre de la pared abdominal.

Fue autor de los libros Hernias de la región inguinocrural y Herniorrafia inguinal: técnica por sobre capas de fascia

transversalis, y coautor de otros como Hernias de la pared abdominal: tratamiento actual. Publicó además varios folletos didácticos para pregrado y posgrado, múltiples artículos científicos en revistas de cirugía cubanas e internacionales y seis vídeos educacionales sobre hernias y técnicas quirúrgicas. El Dr. C José Miguel Goderich Lalán dedicó su vida a la enseñanza, es ejemplo de profesión médica.

Primera etapa del estudio de la vida profesional del Dr. C. José Miguel Goderich Lalán. Etapa de estudiante de Medicina 1961-1967

El 22 de mayo de 1961 se matricula a estudiar becado en la Universidad de Ciencias Médica de La Habana, ya con el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959 vuelven las actividades a la Universidad de La Habana, suspendidas oficialmente por el Consejo Universitario el 28 de noviembre de 1956. Con la Reforma Universitaria implantada el 10 de enero de 1962 continúa sus estudios. El plan de la Reforma era de seis años de duración y se realizó en función de aumentar la cifra de estudiantes de Medicina ante la necesidad de ampliación de los servicios de salud y el aumento en la deserción de los médicos en ejercicio, lo cual respondía a la política trazada por el imperialismo de atacar a la Revolución dejando al pueblo sin médicos.

De igual manera, se pretende reducir el plan de estudios de seis a cinco años cronológicos, incluyendo el internado, con una reducción de los periodos de vacaciones, aprovechando mejor el tiempo disponible. Aúnque no hubo ninguna graduación de médicos con 5 años de carrera. Estuvo vigente, con las adaptaciones que lo prolongaron a seis años, los cursos 1963, 1964 y 1965.

En este contexto se desarrollaron los primeros años como estudiante de Medicina del Dr. C. José Miguel Goderich Lalán. A los pocos días de matriculado se insertó en la Asociación de Estudiantes de Medicina en dicha universidad, lo cual fortaleció su compromiso con la Revolución y se destacó en todas las acciones convocadas por la Federación Estudiantil Universitaria y la Asociación de Jóvenes Rebeldes (más tarde Unión de Jóvenes Comunistas). Por tanto, pudo ser testigo y protagonista del papel desempeñado en aquellos difíciles años de fuertes batallas ideológicas, en que un gran número de galenos optaron por el éxodo, poniendo en riesgo la continuidad de la formación de médicos y estomatólogos.

Siendo en poco tiempo el jefe de propaganda, perteneciente a la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de La Habana, jugó un papel destacado en medidas concluyentes, en las adecuaciones que se les hicieron a los planes de estudio de Medicina. El doctor Omar González de la Cruz, profesor Consultante, Especialista de II en Medicina Interna del servicio de Medicina Interna en el "Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso" recuerda: y cito textualmente "en esta etapa de estudiante yo era un año superior al doctor José Miguel Godericha Lalán, pero lo conocía muy bien porque éramos de la misma provincia y además "los Goderich" eran ya reconocidos en su contexto socio histórico en que le tocó desenvolverse y lo reflejó desde siempre en su modo de pensar y responde en su actuación, junto a otros estudiantes notables" (Omar González de la Cruz, comunicación personal, 22 de octubre de 2017).

Rasgos característicos más significativos en esta etapa

Sensibilidad, patriotismo; compromiso social y profesional, identidad médica y nacional; actividad científico investigativo, responsabilidad; humanismo, respeto, solidaridad, cortesía, justicia, consagración profesional y social.

II ETAPA/ PROFESIONAL 1967-1992

En febrero de 1976 se aprobó en referéndum una nueva Constitución de carácter socialista. En octubre del mismo año se celebraron las elecciones a la Asamblea Nacional del Poder Popular, órgano que a su vez eligió el Consejo de Estado, con Fidel Castro Ruz como presidente, las relaciones con EE. UU se deterioraron aún más con la participación de tropas cubanas en las **guerras de Angola** (1976) y **Etiopía-Somalia** (1977). En esta etapa el Dr. C José Miguel Goderich Lalán, aún siendo residente cumple misión internacionalista combativa como médico guerrillero en las tropas del Partido Africano, para la independencia de Ginea Bissay y Cabo Verde, participando en varias acciones combativas, cumpliendo exitosamente su misión.

Ya graduado regresa a su ciudad natal donde sigue con su desempeño meritorio y su destreza para la cirugía, todavía aún no categorizado desde lo docente demuestra su actitud en el curso elemental de Organización y Táctica de los Servicios Médicos en la academia básica de retaguardia. Con rigor innato en la enseñanza comienza su residencia en

Cirugía, le asignan la responsabilidad de dirigir la Vice-dirección Técnica en el Hospital Militar Dr. Joaquín Castillo Duany de Santiago de Cuba, responsabilidad que asume con profunda consagración, cuando su preparación docente era aún insuficiente.

Al terminar su primer año con notas excelente y una trayectoria ética/ profesional honorable es seleccionado para cumplir misión internacionalista combativa como médico guerrillero en las tropas del Partido Africano para la Independencia de la República de Guinea Bissau y Cabo Verde, donde se pasa 14 meses, lo asignaron como Jefe del destacamento Médico Independiente. En situaciones precarias procedió a intervenir un grupo importante de intervenciones quirúrgicas, todas en condiciones excepcionales de casa de campaña, lo cual permitió tomar alternativas en sus procederes en situaciones infortunadas.

Rasgos característicos más significativos en esta etapa

Sensibilidad, instigadora actividad científico investigativo**,** patriotismo; identidad profesional y nacional; responsabilidad; humanismo, respeto, solidaridad, compromiso social y profesional**,** cortesía, justicia, consagración profesional, amor profesional, altruismo e independencia creadora.

III ETAPA/ ESPECIALISTA CONSAGRADO-RELEVANTE 1992-2017

Recorrido un largo camino en la asistencia, docencia e investigación aportando nuevos métodos y técnicas quirúrgicas, con resultados científicos publicados en revistas nacionales e internaciones, concibió desarrollar, preservar y promover la cultura médica y pedagógica, que como contenidos se incorporen a la actividad y desempeño del profesional de manera sistemática, llegando con ella a las diversas generaciones de profesionales de la Medicina. No solo en su provincia natal sino en todo el país y fuera de este contexto donde ha impartido múltiples cursos de posgrados, socializando en su 25 edición. “Técnica de avanzada en la reparación protésica de las hernias de la pared abdominal”.

A partir del año 1992 comienza a trabajar como Jefe del Servicio de Cirugía General en el Hospital General Universitario “Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso”. Ya como profesor consultante, en este contexto en el cual lo tomamos como ejemplo de figura **trascendente de la Medicina**, hombre de ciencia, que profesaba el amor y la

calidez con solo conversar con él, con valores notables, de un hombre con una condición humano-universal, lo que se puede tomar como modelo de profesional, desde un comportamiento ético digno de admirar, como cualidad que lo distingue.

En esta etapa se considera la presencia de un sistema de procedimientos instructivos en la obra del Dr. C. José Miguel Goderich Lalán, por encontrar en ella cómo debe desarrollarse el acto educativo en la formación del médico y sobre el papel del profesor en este.

Su constancia, su compromiso, humanismo, su consagración, de una sensibilidad notable, la entrega en todo lo que profesaba, revelado en su amor con la profesión médica, con todo lo hecho y proyectado, que las cosas debías fraguarse desde la mente hacia el corazón para que fuese autentico. Analiza la educación en su carácter social y humano. Comprende la profesión del médico como la inquebrantable ocupación, la labor permanente, que a pesar de encontrase muy aquejado por una enfermedad que casi ni le permitía hablar adecuadamente, se reincorporó después de un tratamiento invasivo a su actividad laborar, cumpliendo con todas las tareas docentes asistenciales y científicas como profesor principal de la asignatura de pre y posgrado,

Era un hombre impecable con su bata sanitaria abotonada completamente, alegre, sencillo, amable, veraz, siempre dispuesto, les enseñaba a los estudiantes, residentes, enfermeras y profesores, el cuidado de la bata sanitaria, el significado que tenía para el cómo atributo del médico.

Destacándose en la preocupación, ocupación por la superación de sus residentes y colegas, intolerante con los que no estudiaban. El respeto al prójimo, como muestra de dignidad y grandeza, la de constantes iniciativas y creación, del consejo oportuno, la responsabilidad de asumir los errores, la honradez, la cortesía, abogaba por la confianza que debe sentir hacia el médico, tanto el paciente como sus familiares.

Buscó su autonomía intelectual que lo condujo a las críticas problematizadoras de su realidad, adopta una participación activa en el entorno, en la interdisciplinariedad de la atención integral a pacientes, es en esa adecuada

relación médico-paciente-familia, responsable, propia, era el camino más certero para la formación de los fines de la educación médica y en sus resultados; señaló la necesidad de la formación de los profesionales de la Medicina con un desempeño ético-profesional más humano, una práctica médica apropiada para lograr la eficiencia y la actuación de todos en el contexto de la Educación Médica Superior.

En esta etapa es nombrado miembro de la comisión territorial de Grado Científico del Instituto Superior de Ciencias Médicas, en el 2012 como Profesor de Méritos y en el 2014 es nombrado como Profesor Internacional por la Asociación Mexicana de Cirugía. Con más de 586 artículos científicos presentado en eventos científicos nacionales e internacionales, autor de dos libros, más de 7 folletos didácticos para pregrado y posgrado, participó en más de 26 países en eventos internacionales tanto de la Sociedad Americana de Hernia como la Sociedad Europea de Hernia, así como sin número de distinciones, reconocimientos y premios por su labor profesional, científica y asistencial.

Rasgos característicos más significativos en esta etapa

Compromiso social y profesional, sensibilidad, patriotismo; fortaleza; identidad profesional y nacional; responsabilidad; humanismo, instigación motivadora en la actividad científico-investigativo**,** solidaridad, cortesía, justicia, consagración profesional, amor profesional, altruismo e independencia creadora, dignidad, flexibilidad.

En concordancia con todo lo antes expuesto la autora fundamenta que la historia de la vida profesional de Dr. C. José Miguel Goderich Lalán como ejemplo de figura trascendente de la Medicina, contribuye a uno de los desafíos de la formación ético-profesional del estudiante de Medicina, un aspecto de construcción de valores legítimos que desarrollen sus potencialidades, tomando al sujeto centro mismo del conocimiento lo que se establecen como contenido en la formación ético-profesional del sujeto como elemento dinamizador, articulado por un sistema de objetivos y métodos formativos que definen, no solo el comportamiento, el modo, la competitividad, sino también la sensibilidad humana, como rasgo distintivo del sujeto que permita contribuir, estructurar un autodesarrollo,

profesional y un desempeño educativo trascendente en la formación del estudiante de Medicina.

Cuando se profundiza en el extraordinario hecho contributivo de esa labor para las actuales generaciones de estudiante, ulteriores profesionales de la Medicina, se presentan sus rasgos característicos, su compromiso, consagración y su humanismo médico, lo que ratifica su Identidad médica, sensibles de su verdadera dimensión pedagógica, de lo epistemológico y lo educativo.

Se deriva que las ideas pedagógicas hilvanadas permiten comprender los principales contenidos de una formación profesional de excelencia, un estilo propio con un lenguaje asequible, donde se aprecian los rasgos que lo caracterizó en esta etapa. Al reconocer sus valores contribuyen a valorar la ejemplaridad de su práctica formativa para la formación de los futuros profesionales de la Medicina como contenidos educativos, debe destacarse que se ha justificado eventos en su persona que le dan validez a su alegato y pertinencia educativa.

Se tomaron como criterios desde la vida profesional del Dr. C. José Miguel Goderich Lalán para la formación de ético-profesional del estudiante de Medicina:

- Adiestramiento asiduo en su formación ético-profesional, evidenciado en una reconocida trayectoria estudiantil, profesional, social e individual.
- Significó de manera relevante el empleo acertado del método clínico-epidemiológico para un abordaje interventivo de las enfermedades.
- Relaciones empáticas entre los pacientes y sus familiares, desde comportamientos éticos y el modo de actuación en los escenarios profesionales.
- Instigaciones más motivadoras en la dedicación patriótica, por las causas justas.
- Permanente, la enseñanza con los actos, como muestra de dignidad y grandeza, la constantes iniciativas y creación, del consejo oportuno.

- Demostró la necesidad de la Pedagogía, de una dinámica en la formación del estudiante y profesionales de la Medicina con un desempeño ético-profesional, constante.

- Cultivo continuo por el amor y las relaciones interpersonales enmarcadas en una atención integral a pacientes y sus familiares.
- Inquebrantable disciplina, compromiso social y profesional responsables mostrado en su actividad clínica- investigativa con un humanismo médico digno de admirar.

La característica de los valores emergidos de la Historia de Vida del Dr. C. José Miguel Goderich Lalán, se hace del mismo una compleja totalidad, en su esencia inseparable en cada acto profesional, humano, se manifiesta a través de los movimientos y trasformaciones que se producen el desarrollo de su vida y reflejan las cualidades del proceso como un todo y ensu integración determinan su comportamiento (Anexo No. 11).

ETAPA POSTACTIVA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN, VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS:

I. Generalizan las relaciones y regularidades que refuerzan la identidad médica, Se constituye la cátedra de historia de la Medicina y de sus figuras trascendentes.

II. Estructuración de aportes teóricos y prácticos que se incorporan al proceso formativo, a partir de sistematizar la experiencia desde el ejemplo investigado.

1. Se enfocan nuevos métodos para desarrollar contenidos de los cursos.
2. Incorporación de los estudiantes a nuevos espacios de reflexión fuera del horario de clases previsto.
3. Reconocimiento tangible de valores y actitudes desarrollados en los escenarios profesionales, con el refuerzo del humanismo médico.

RESULTADOS DE LA ETAPA POST-ACTIVA

1. Resultados de encuestas a pacientes y familiares al concluir la aplicación de la metodología.
2. Criterios de indicadores de impacto en las transformaciones de los estudiantes.

3. Resultados del Proyecto de formación de valores en salud (FORVAS) que integra a profesores y estudiantes, incentivando la formación doctoral.
4. Se logra la aprobación de cuatro temas de doctorados, devenidos del proceso investigativo que acompañó esta tesis.

En el proceso de la aplicación de la metodología de Sistematización Generalizadora desde Historias de Vida de figuras trascendentes para la formación ético-profesional del estudiante de Medicina, se propuso talleres grupales para la formación ético-profesional del estudiante de Medicina, cada uno con sus objetivos ejecutantes que el estudiante tendrá que resolver paulatinamente y que se van dando en cada etapa del proceso de la aplicación de la metodología, lo que va a permitir desarrollar en el estudiante de Medicina, la autoformación individual desde los ejemplos de figuras trascendentes.

Talleres grupales realizados en el proceso de la aplicación de la metodología para la formación ético-profesional del estudiante de Medicina

Principales acciones organizativas para la aplicación de la metodología para la formación ético-profesional del estudiante de Medicina.

Estos se desarrollan en el primer encuentro:

1. Convocar a los estudiantes seleccionados para la participación en los talleres.
2. Sensibilizar a los estudiantes y en conjunto proyectar la planificación de las investigaciones que motiven a los estudiantes de Medicina, esto se puede determinar a través de subgrupos de dos o tres estudiantes.
3. Informar el plan temático con anterioridad para que se puedan sugerir nuevas o más convenientes temáticas.
4. Motivar a los estudiantes facilitando compresión de lo que se pretende alcanzar.

1er Taller de formación ético-profesional: **"Reconociendo los ejemplos de figuras trascendentes de la Medicina"**

Objetivos:

- Crear un estado favorable en los participantes que facilite el debate en los talleres grupales.
- Reflexionar en relación con los comportamientos en los escenarios profesionales donde interactúan con el paciente y sus familiares.
- Examinar las posibilidades particulares de los estudiantes en relación con la carrera.
- Conjunto argumental, cómo es el comportamiento ético del estudiante de Medicina en los escenarios profesionales y la proyección que muestra con el paciente y sus familiares.

Organización y desarrollo. Previa coordinación con el grupo de estudiantes seleccionados, se desarrolló una actividad inicial en la que de manera participativa se expuso a los estudiantes los fundamentos teóricos-metodológicos desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, motivándolos a partir de ejemplos vivenciales, al conocimiento del tema, propiciando el intercambio, la reflexión y el debate de los estudiantes en torno al mismo. Esta es una sesión que puede repetirse tantas veces como se considere preciso por el coordinador y el grupo.

2do. Taller de formación ético-profesional: "Experiencias de la interpretación de los ejemplos"

Objetivo: Reflexionar en torno al concepto y la valoración que tienen los estudiantes de sí mismos a partir de su experiencia personal en los escenarios profesionales.

Organización y desarrollo. Iniciar la sesión de trabajo con la aplicación de la técnica participativa "¿Cómo me comporto?", para promover y estimular la reflexión de los estudiantes acerca del conocimiento de sí mismo.

Instrucciones: En un lugar determinado del local de trabajo seleccionado, se colocarán tarjetas donde se relacionan cualidades de comportamientos éticos, modo de actuación y valores emergidos desde Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina. Todo lo cual permitió orientar a los estudiantes en la selección de aquellas que más lo caracterizan. Puede establecer comunicación con otros participantes para intercambiar criterios acerca de cómo se

compartan, como son y cómo los ven los otros. Esta sesión puede repetirse tantas veces como se considere preciso por el coordinador y el grupo.

En plenaria, cada cual explicará la cualidad que seleccionó y se hará énfasis en que explique por qué de su elección. El resto de los participantes intervienen para corroborar o aportar algún criterio del compañero, al promover la confrontación de ideas y el debate analítico acerca de las cualidades que debe caracterizar el comportamiento ético en los escenarios profesionales donde interactúan con el paciente y sus familiares.

La aplicación de esta técnica demanda contar con el tacto pedagógico necesario para no dañar la autoestima de los estudiantes que intervienen en la actividad y facilita la reflexión y autorreflexión a partir de los contenidos, reconocer su tratamiento, desde sólidas posiciones científicas como expresión de la transmisión de referentes cognoscitivos. Escuchar los criterios y las consideraciones de los estudiantes, favorecer su internalización desde la expresión de sus sentimientos y valores a través del intercambio y la discusión de las ideas presentadas.

El coordinador guiará al estudiante para la construcción del conocimiento científico, para la búsqueda de alternativas en la solución de conflictos reales y en las respuestas a las siguientes interrogantes: ¿cómo me comporto ?, ¿quién soy?, ¿qué lugar ocupo en diferentes contextos?, ¿cuál es mi origen?, ¿qué elementos me hacen ser igual o diferente a los demás?, ¿cuál es la razón de mi actuación?, ¿cómo soy?, ¿qué me gustaría cambiar en mi forma de ser?, ¿cómo hacer para lograrlo?, ¿cómo es mi modo de actuación ? Estas interrogantes guiarán la búsqueda de datos significativos, que le servirán para la interpretación adecuada de los hechos o acontecimientos y reconocimiento desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, las expectativas personales profesionales, por las que transita su formación.

A través de la técnica Positivo, Negativo e Interesante (PNI) se ha de realizar, con la intervención de un facilitador, el registro de la actividad desarrollada.

3er. **Taller de formación ético-profesional: Cuestionamiento y reconsideraciones, "¿mis experiencias?"**

Objetivo: Valorar la importancia de los comportamientos éticos que favorezca la proyección positiva en los escenarios profesionales donde interactúan con el paciente y sus familiares.

Organización y desarrollo. Para el análisis de la importancia del desarrollo del comportamientos éticos, para la proyección positiva en los escenarios profesionales donde interactúan con el paciente y sus familiares, se constituyeron realidades de aprendizaje sociales y profesionales desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, se desarrolla la sistematización de la Historias de Vida del Dr. C. José Miguel Goderich Lalán, como recurso didáctico, mediante el cual se modelan diferentes situaciones de la realidad educativa, en las cuales los estudiantes debe reconocer críticamente, la repercusión de los comportamientos éticos improcedentes e identificar las causas que lo pudo condicionar. Esta sesión puede repetirse tantas veces como se considere necesario por el coordinador y el grupo.

Es esencial para la solución de cada situación, que el estudiante se identifique con la necesidad del cambio en los comportamientos éticos que construya las vías para transformarlo. Se requiere una adecuada autovaloración y valoración de la situación social y profesional, lo que posibilitará identificarse con la problemática, reflexionar, tomar decisiones y significar la importancia de favorecer la fase de resignificación desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina para el desarrollo social y profesional. A través de la técnica PNI realizar con la intervención de un facilitador, el registro de la actividad desarrollada. En este taller se presenta la figura trascendente tomada como ejemplo, como componente motivador para el estudiante.

4to. **Taller de formación ético-profesional: "Mensajes, video- debates"**

Objetivo: Desarrollar en los estudiantes comportamientos éticos a partir de los ejemplos de figuras trascendentes de la Medicina, en la disposición para la realización de sus actividades en la educación en el trabajo. Participa y desarrolla tareas de investigaciones vinculadas a problemas identificados en los escenarios profesionales. Divulga los resultados de las mismas por medio de publicaciones científicas y presentación en eventos científicos.

Organización y desarrollo. Se realizará a partir de las experiencias confrontadas desde los ejemplos de figuras trascendentes, se concibe a partir de una secuencia de encuentros participativos, flexible en cuanto al número de sesiones, en relación con las demandas del grupo. Se proponen aspectos esenciales relacionados con los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina para el desarrollo individual, social y profesional, a través de la exposición de fotos, documentos inéditos para su estudio, análisis, discusión y apropiación.

También se realiza la presentación de cortos video-debates, así como presentación de PowerPoint con propuestas de contenidos y representaciones de ejemplos de figuras trascendentes de la Medicina, sus testimonios vividos, dirigidas al beneficio profesional y social.

Al finalizar cada una de las propuestas, se realizan debates grupales, encaminados a la crítica y autocrítica mediante discusiones grupales. Esta sesión puede repetirse tantas veces como se considere preciso por el coordinador y el grupo.

Para su desarrollo, se utilizan por los estudiantes, fotos, documentos, materiales de apoyo impresos, que le han sido entregados por familiares o por la misma figura trascendente, para el desarrollo social y profesional, así como la construcción de PowerPoint de contenido hechas por ellos mismo, lo que le permite desarrollar tareas de investigaciones que contribuirá en su presentación al terminar la carrera.

Resultan esenciales las opiniones reflexivas y críticas de los estudiantes, las cuales tendrán una conclusión que favorecerá la sistematización de los contenidos teóricos básicos para enriquecer su proceso formativo. Se forja una identidad médica auténtica, configurada desde los ejemplos de figuras trascendentes de la Medicina y desarrolladas desde las propias necesidades y potencialidades.

Paralelamente a las acciones diseñadas e implementadas en los talleres de formación ético-profesional se privilegia la dimensión socio-profesional y la dimensión clínico-trasformadora, en desarrollo con los niveles de desarrollo de los valores compromiso, consagración y humanismo se abrió en cada taller un espacio para las necesidades de

orientación desde los ejemplos de figuras trascendentes de la Medicina para el desarrollo de comportamientos éticos en las actividades designadas en la educación en el trabajo.

Con las valoraciones individual y colectiva de los resultados obtenidos con la aplicación de la metodología de Sistematización Generalizadora desde Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, se lograron registros de sistematización de experiencias que, en un análisis colectivo, posibilitó la indagación desde las actividades en la educación en el trabajo de los estudiantes de Medicina, donde interactúan con el paciente y sus familiares, alcanzados a partir de logros definidos en la metodología, en correspondencia con las etapas precisadas en esta. Cada momento de intercambio que se produjo entre la investigadora y los sujetos involucrados, permitió colegiar alternativas para corregir errores y dar tratamiento a situaciones imprevistas en su implementación. En un primer **Nivel de sensibilización del compromiso social-responsable.** La investigadora posibilitó desde su orientación acertada, la comprensión del compromiso social-responsable con la profesión, a partir de los ejemplos de figuras trascendentes de la Medicina. Lo anterior, fue enriquecido con los debates científicos desarrollados en los talleres para la formación ético-profesional, a partir de que estos expusieran los comportamientos éticos y el modo de actuación en contexto de la figura investigada, con casos reales y vivenciados por los propios estudiantes en los escenarios profesionales.

Esto les permitió a los estudiantes reconocerse y explorar sus actitudes, modo de proyección en contexto, .lo que favoreció de manera pertinente el desarrollo de la atención integral a pacientes a partir del tratamiento adecuado del interrogatorio y examen físico al paciente para el diagnóstico de enfermedades, así como la competencia en el desempeño profesional y compromiso con el paciente y sus familiares.

La investigadora en conjunto con las figuras trascendentes, utiliza una técnica grupal de colaboración y debate científico, motivo el análisis crítico valorativo de los estudiantes, de las formas más pertinentes para la consolidación de los valores: compromiso, consagración y humanismo, el empleo acertado del método clínico-epidemiológico para

un abordaje interventivo de las enfermedades, del modo de actuación, de relaciones empáticas entrelos pacientes y sus familiares. Este proceso condicionó la posibilidad de consolidar la atención integral a pacientes, como aspectos sustantivos de la formación ético-profesional del estudiante de Medicina, sobre la base de comprenderlos conocimientos, habilidades clínico-interventiva, para una atención de excelencia en los escenarios profesionales donde interactúan con el paciente y sus familiares.

Esto fortaleció la sistematización de la práctica clínico-interventiva del estudiante de Medicina, desde los ejemplos de figuras trascendentes. De esta forma, se fue alcanzando una lógica de sistematización de comportamientos éticos, lo que se tradujo en una mayor calidad en la relación médico-paciente-familia, el empleo de una comunicación positiva y empática con ello y sus familiares, propiciando un estado anímico de seguridad, respeto al paciente y su familia. Potencialidades creativas para la incorporación de comportamientos éticos en los escenarios profesionales donde interactúan con el paciente y sus familiares.

Lo anterior, favoreció el tránsito a un **segundo Nivel de desarrollo de orientación de la actividad clínico-trasformadora.** Este segundo nivel permite sistematizar el ordenamiento de la proyección médica del estudiante de Medicina en los escenarios profesionales, donde interactúa con los pacientes y sus familiares. Para el diagnóstico y tratamiento de los casos clínicos analizados, a partir de la fundamentación de su proceder y del abordaje interventivo para evitar complicaciones en los pacientes.

Con ello, se logró sistematizar su comportamiento médica a seguir a partir de nuevas formas y métodos continuos en el abordaje médico (cada paciente es único e irrepetible) así como la evolución de las enfermedades, la determinación de sus síntomas y la búsqueda exhaustiva de las causas y consecuencias que inciden en ella. A partir de este proceso de orientación, se estimuló la actividad desde la práctica clínico-interventiva con una mirada holística más coherente y articulada, al revelar las potencialidades creativas de los estudiantes al consolidar una práctica clínico-interventiva para la atención integral a pacientes lo que se manifestó en:

- Calidad en la orientación educativo-preventiva-interventiva a pacientes y sus familiares.
- Empleo correcto de la terapéutica curativo-preventivo a los pacientes con el fin de reducir dolor y molestias.
- Responsabilidad, compromiso con los pacientes y sus familiares.
- Autonomía, demostrada en la atención integral a pacientes desde lo interventivo.

Esto reveló un mayor nivel de generalización, su impacto y pertinencia de la **trascendencia del humanismo médico, como tercer Nivel de desarrollo en el proceso formativo del estudiante de Medicina,** implementadas para mejorar la insuficiencia en los comportamientos éticos del estudiante de Medicina, lo que limita su proyección en los escenarios profesionales, donde interactúa con los pacientes y sus familiares para una atención integral de excelencia, lo cual reveló un mayor nivel de autonomía y compromiso, consagración en logro de la excelencia clínico-trasformadora en la atención integral a pacientes.

Esta lógica integradora trascendente permitió la sistematización y generalización de valores compromiso, consagración y humanismo, de comportamientos éticos, de esa sensibilidad humana y espiritualidad que debe tener este profesional en la atención integral a pacientes, de la calidad en la relación médico-paciente-familia a partir del empleo de una comunicación positiva y empática desde el respeto a la dignidad e integridad humana. Redimensiona el principio de la educación en el trabajo, como sustento básico en la formación del médico desde el modelo pedagógico cubano y en particular para la formación del estudiante de Medicina.

Selección y aplicación de una prueba estadística apropiada

Para evaluar la metodología, se empleó el test de McNemar, que es una prueba no paramétrica de comparación de proporciones para muestras pareadas o relacionadas. Esta prueba se utiliza cuando la variable dependiente o de respuesta es nominal dicotómica, lo que coincide con las características de la presente investigación. Este test permitió evaluar los resultados de la metodología aplicada y comparar si se producen cambios significativos entre las dos muestras (antes y después de la intervención o metodología. Como variable respuesta se tomó la evaluación

integral del estudiante de Medicina en cuanto a su desempeño profesional, comportamientos éticos, teniendo en cuenta los resultados de la guía de observación del desempeño ético-profesional del estudiante de Medicina, la auto-calificativa y la guía de observación de la formación ético profesional del estudiante de Medicina.

La prueba de McNemar es un caso particular de la prueba de X^2 y simplificando la correspondiente fórmula para obtener las frecuencias observadas y esperadas en ambas celdas, se tiene como resultado la fórmula siguiente para calcular el valor de X2 con un grado de libertad gl=1:

$$X^2 = \frac{(A - D)^2}{(A + D)}$$

Cuando todas las frecuencias esperadas son pequeñas (menores que 5), se aplica la corrección de continuidad de Yates y la fórmula anterior se modifica ligeramente:

$$X^2 = \frac{(|A - D| - 1)^2}{(A + D)}$$

En esta fórmula se le resta uno al valor modular de (A - D) antes de elevar al cuadrado.

Los cálculos se realizaron mediante el programa estadístico SPSS versión 25, para lo cual se escogió un nivel de significación alfa (α) = 0,05, considerándose estadísticamente significativo valor de p< 0,05; que se corresponde con McNemar igual o mayor de 3,841 para aceptar o rechazar la hipótesis nula.

Las hipótesis planteadas son:

H_0: La proporción de estudiantes con respuesta satisfactoria antes y después de aplicada la metodología es igual.

H_1: La proporción de estudiantes con respuesta satisfactoria antes y después de aplicada la metodología es diferente.

Para probar la significación de cualquier cambio observado, se elaboró una tabla donde se muestran los valores observados en las variables analizadas antes y después de aplicada la metodología (Anexo No. 12).

Valoración de los resultados obtenidos con la aplicación de la metodología

Durante la aplicación de la metodología propuesta, se ha revelado una tendencia satisfactoria de perfeccionamiento del proceso de formación del estudiante de Medicina, ello se confirma a través de avales emitidos por directivos y responsables de docencia del Hospital General Dr. "Juan Bruno Zayas Alfonso" donde se aplicó la experiencia (Anexo No. 13), **revelándose impactos formativos**

- El **100 %** de los estudiantes lograron resultados académicos favorables, evidenciándose autonomía y dominio de las habilidades previstas según contenido en el P1 (planificación docente) al tratar con destreza a los pacientes, a través del método clínico-epidemiológico en su práctica asistencial.
- El **35,7 %** de los estudiantes escogieron desarrollar investigaciones en temas relacionados con la Historia de la Medicina y sus figuras trascendentes.
- EL 100% de los estudiantes desarrolló potencialidades creativas para la incorporación de comportamientos éticos en su quehacer profesional en los escenarios profesionales donde interactúan con el paciente y sus familiares en la educación en el trabajo.
- Se desarrolla en los estudiantes de Medicina un sistema de valores, que le permitan demostrar una clara concepción de su encargo social, alejado de posiciones elitistas, con respecto al desempeño de la profesión, con un elevado compromiso con lo que hace, desde una consagración social y profesional, con espíritu humanista, dispuesto a tratar a los demás sin distinción como seres humanos.
- El 100 % de los estudiantes alcanzó resultados académicos favorables, evidenciándose en la obtención de premios en jornadas científicas estudiantil, sellos forjadores del futuro, premio joven investigador y en cantera como aspirante a investigador.
- El 100 % de los estudiantes se le asignó carreras directas por los resultados obtenidos desde

sus actividades científicas profesional.

- Destacados en ayudantías en especialidades de complejidad como Ginecobstetricia, Medicina Interna y Terapia Intensiva. Optaron especialidades como Cirugía, Neurología, Inmunología, Cardiología, Medicina General Integral (MGI), donde se desempeñan con excelentes resultados.

Así mismo se revelaron los siguientes **impactos sociales en los pacientes**:

- Calidad en la orientación educativo-preventiva a pacientes y sus familiares.
- Empleo correcto de la terapéutica curativo-preventivo a los pacientes con el fin de reducir dolor y molestias
- Se alcanzó un alto nivel de autodesarrollo humanista, expresado en su proyección en los escenarios profesionales donde interactúan con el paciente y sus familiares.
- El 100 % de los estudiantes demostró, nivel de autonomía en la atención integral a pacientes desde lo interventivo.

Se fortaleció el **trabajo docente-metodológico en el proceso formativo,** lo que se concretó en:

- Se sistematiza el desarrollo de experiencias vividas desde los ejemplos de figuras trascendentes, que significaron la observancia de los comportamientos éticos en los escenarios profesionales.
- Se logró el carácter subjetivo y profundo de investigaciones de corte histórico, no solo en estudiantes, sino también en profesores, emitiendo criterios muy apropiados, se motivó desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina para el autodesarrollo del humanismo médico.
- Se desarrolla en el estudiante de Medicina un sistema de valores que le permitan demostrar una clara concepción de su encargo social, con un elevado compromiso con lo que hace, desde una consagración social y profesional, con espíritu humanista, dispuesto a tratar a los demás sin distinción como seres humanos.

- Un proyecto de investigación con el objetivo de formar valores desde las Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina en la provincia de Santiago de Cuba. con fecha de culminación el 10 de septiembre 2025 y registrado en el Registro de Proyectos en Salud (REPIS), donde se insertan a los estudiantes que estén interesado en esta línea investigativa, en estos momentos están incluidos 12 estudiantes, todos de tercer año de la carrera de Medicina.

Se tuvo en cuenta para los argumentos cualitativos expresados los criterios emitidos los especialistas-docentes y profesores, de los estudiantes participantes en la investigación y que se encuentran actualmente, como médicos (Residentes), en diversos escenarios profesionales. Este seguimiento, a través del tiempo, permitió la corroboración científica de los resultados teóricos y prácticos de esta investigación.

Fueron entrevistados seis tutores. De ellos, dos especialistas en Cardiología, dos en Medicina General Integral (MGI), uno de Ginecobstetricia y uno de Terapia Intensiva de los cuales, dos se encuentran de misión internacionalista uno en Angola y el otro en República Bolivariana de Venezuela, los otros cuatro, tres están trabajando en esta institución y la otra en el Cardiocentro de Santiago de Cuba.

- La evaluación que recibieron los estudiantes de parte de sus Tutores, en relación al desempeño profesional y sus comportamientos éticos y modo de actuación con la profesión.
- Se caracterizan por ser reconocidos y queridos por los pacientes y familiares de estos.
- Han recibido reconocimientos por su labor destacada, en situaciones de contingencia, en zona roja con la pandemia de la COVID-19, en las mismas se distinguen por el amor a la profesión entusiasmo, sentido de pertenencia y alto grado de respeto.
- Los resultados de las observaciones y valoraciones emitidas sobre los profesionales que fueron muestra de esta investigación, explicitan una proyección humana auténtica y trascendente en los escenarios profesionales.

- Las cualidades humanas más apreciables están relacionadas con el humanismo médico, el compromiso social responsable la consagración profesional y social desde el amor a la profesión, revelado en su comportamiento ético en los escenarios profesionales donde interactúan con el paciente y sus familiares.

A pesar de estos logros, aún se evidenciaron **retos** para la implementación de la propuesta:

- Necesidad de involucrar a un mayor número de profesionales del territorio en la dinámica del proceso de formación ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de historias de vida
- Se requiere una mayor sensibilización por parte de la totalidad de los estudiantes para asumir cambios en su práctica clínica desde lo interventivo, que integre la prevención, el diagnóstico y la terapéutica de una manera integral, evitando dolor y molestias en los pacientes y sus familiares.

Conclusiones parciales del Capítulo 3

- La eficacia y validez del modelo de formación ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida y la pertinencia de la metodología se corroboran a través de la valoración científica realizada en los talleres de socialización con especialistas-docentes y profesores como expertos dan cuenta del reconocimiento, que admite mostrarse conforme al valor epistemológico y práctico de ambos aportes.
- Como resultado de la aplicación práctica de la metodología para la formación ético-profesional del estudiante de Medicina, se pudo valorar que es factible, por los logros que se revelan con la transformación de los participantes, que sintetizan el impacto social de la metodología, en los estudiantes implicados.
- Como resultado del seguimiento a los estudiantes que fueron muestra de la investigación, actualmente residentes se pudo valorar que existe una proyección ético-profesional auténtica y trascendente con una

devoción más humanista en los escenarios profesionales, así como en el contexto social, lo cual sintetiza el impacto y trascendencia social y profesional de la metodología.

Conclusiones

CONCLUSIONES GENERALES

- La caracterización epistemológica y praxiológica del objeto y el campo de acción de esta investigación, así como el análisis de las tendencias históricas, evidenció las limitadas referencias teóricas a la dinámica del proceso de formación ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida, pues no se ha sistematizado, suficientemente los comportamientos éticos desde un nuevo enfoque, con una autoformación humanista profesional, una integración y significación de los valores éticos, compromiso social responsable, la consagración profesional, el humanismo médico, así como el rescate de la Historia de la Medicina y de sus figuras trascendentes, contentivo de identidad médica. Estas inconsistencias, que tienen su expresión en la práctica clínico-interventiva, revelaron la necesidad de profundizar en cómo se singulariza este proceso, a partir de una lógica de sistematización desde los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina como eje articulador de su dinámica.
- El modelo de la dinámica ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida, como constructo teórico propuesto, revela una nueva lógica de Sistematización Generalizadora desde los ejemplos de figuras trascendentes de la Medicina, que permite su valoración en la práctica e intervenir en la solución a los problemas más generales y frecuentes en los escenarios profesionales. Los niveles declarados constituyen eslabones que propician sistematizar la formación de los valores compromiso, consagración y humanismo, que orienta la dinámica formativa, en un movimiento integrador, para perfeccionar la formación de este futuro profesional.
- Las relaciones aportadas entre las configuraciones y dimensiones del modelo, se concretan en una metodología pedagógica para la formación del estudiante de Medicina, como instrumento práctico que orienta la dinámica formativa, en un movimiento integrador, para perfeccionar la formación de este futuro profesional.

- Los constructos teórico-prácticos aportados fueron corroborados a través de la realización de talleres de socialización con especialistas-docentes y mediante su aplicación a un grupo de 14 estudiantes de Medicina del Hospital General "Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso" de Santiago de Cuba, lo que enriquece y perfecciona la estrategia educativa a partir el Modelo del profesional, desde el perfil ético-humanista y profesional, lo cual queda expresado en el impacto y trascendencia social de los comportamientos éticos y el modo de actuación de los estudiantes de Medicina que participaron como muestra, en la investigación.

Recomendaciones

RECOMENDACIONES

- Continuar profundizando en la búsqueda de nuevas relaciones conceptuales y didácticas que contribuyan al perfeccionamiento en la formación ético-profesional del estudiante de Medicina, tomando como punto de partida los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina.
- Extender la aplicación de la metodología para la formación ético-profesional del estudiante de Medicina a todos los grupos por año académico, para lo cual se requiere, hacerla parte de la Estrategia Educativa, que permitirá alcanzar impacto social positivo en el proceso formativo del estudiante de Medicina.
- Profundizar en nuevas relaciones teóricas que permitan sistematizar las configuraciones formación ético-profesional en la educación en el trabajo y concepción del humanismo médico en aras de generalizar los ejemplos de Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, para garantizar su pertinencia profesional, social e individual en los escenarios profesionales.
- Sistematizar permanentemente, la lógica formativa propuesta a través de la práctica clínico-interventiva en educación en el trabajo, en aras de lograr una atención integral a pacientes, para la continua efectividad de la nueva dinámica que se defiende en la formación del estudiante de Medicina y lograr mayores niveles de confiabilidad y validez de la propuesta.
- Valorar la posibilidad de generalizar los resultados científicos alcanzados a través de su aplicación en otras instituciones del sistema de salud del territorio y el país, garantizando los recursos humanos, materiales y financieros para su puesta en práctica.
- Proponer a las autoridades competentes el perfeccionamiento de los contenidos y las orientaciones metodológicas en la estrategia educativa, a tono con la nueva dinámica propuesta para garantizar un redimensionamiento desde la concepción del humanismo médico**,** integración y significación de los valores compromiso, consagración y humanismo, así como el rescate de la identidad médica por medio de los ejemplos de historia de Vida de figuras

trascendente de la Medicina.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA

1. Acevedo, E. (s.f.). *La formación humana integral: Una aproximación entre las Humanidades y la Ciencia*. Recuperado de http://www.oies.es/
2. Acosta, J. R. (1999). Una bioética sustentable para un desarrollo sostenible. En: Delgado, C. (comp.). *Ecología y Sociedad. Estudios*. (pp. 35-40). La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
3. Adam, S. (s.f.). *La filosofía del Hombre*. (s.l.): Editorial Lautaro.
4. Addine F., F. (2009). *Didáctica: teoría y práctica*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
5. Addine F., F. (2012). *El registro de la sistematización profesional: herramienta para la toma de decisiones*. La Habana: Centro de Estudios Educacionales de la UCPEJV.
6. Addine F., F. (2013). *Diálogo de generaciones en el VIII Congreso de la FEU*. [Cd-Rom].
7. Alarcón, R. y Álvarez, C. (1995). *Revolución y Educación Superior en Cuba*. La Habana: Ministerio de Educación Superior.
8. Alarcón, R. y Sánchez, R. (2000). *Actualización del Enfoque Integral para la Labor Educativa y Político Ideológica en la Universidad*. La Habana: Editorial Félix Varela.
9. Aldana, A. (2009). Formación humanística del estudiante universitario. *Studiositas*, 4(3), 9-20.
10. Alfonso, M. y Fernández, I. (2010). El humanismo y la cultura en la carrera de Medicina. *Odiseo, Revista electrónica de Pedagogía*, 8(15). Recuperado de http://www.odiseo.com.mx010/8-15/
11. Allport, G. W. (1971). *La personalidad. Su configuración y desarrollo*. La Habana: Edición Revolucionaria, Instituto Cubano del Libro.
12. Alonso, L. A., Leyva, P. A. & Mendoza, L. L. (2019). La metodología como resultado científico: alternativa para su diseño en el área de ciencias pedagógicas. *Opuntia Brava*, 11(Especial 2), 231-247. Recuperado de https://200.14.53.83/index.php/opuntiabrava/article/view/915/1032

13. Álvarez A., N. (2005). *El enfoque humanista como condición para la formación de valores con los estudiantes de la educación superior*. Camagüey: CECEDUC.
14. Álvarez de Zayas, C. M. (1999). *Didáctica. La escuela en la vida*. La Habana: Educación Superior.
15. Álvarez Z., C. M. (2001). *El diseño curricular*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
16. Álvarez, N., Cardoso, R. y Moreno, M. (2000). *La educación en valores del estudiante universitario a través del proceso docente-educativo*. La Habana: Universidad de La Habana.
17. Amaro C., M. C. (2008). La bioética desde una óptica marxista. *Educ. Med. Super*, 22(3). Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttex&pid=S0864-21412008000300010&ing=es
18. Anvar Tojimatovich, A. y Saidakbar Saydaliyevich, U. (). Formation of science as a value and classification of values. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 172-178. Recuperado de https://zienjournals.com
19. Añorga M., J, Garrido G., RJ, Borges O., L. (2019). El humanismo cristiano legado por Varela a la Pedagogía. *Rev Panorama. Cuba y Salud*, 14(2), 61-72. Recuperado de http://www.revpanorama.sld.cu/index.php/rpan/article/view/
20. Añorga M., J. (2012). *La Educación Avanzada y el mejoramiento profesional y humano*. (Tesis de doctorado). Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona", La Habana, Cuba.
21. Añorga M., J. (2016). *Intercambio científico Cátedra de Educación Avanzada*. La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.
22. Añorga M., J. (2020). Lo increíble de los comportamientos humanos, la pedagogía, las ciencias de la educación y la Educación Avanzada. *Rev Panorama. Cuba y Salud*, 15(2), 53-59. Recuperado de http://www.revpanorama.sld.cu/index.php/rpan/article/view/
23. Arana E., M. (2006). Los valores en la formación profesional. *Tabula Rasa*, 4(16). Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n4/n4a16pdf

24. Aranda C., B. (2005). *Metodología para la sistematización del contenido sociocultural familiar en el proceso de educación cívica del 2. ciclo de la Educación Primaria*. (Tesis de doctorado). UCPFPG, Santiago de Cuba, Cuba.
25. Asín Cala, M. (2018). Juan Bautista Sagarra Blez: escritor de textos escolares. *Maestro y Sociedad*, (Núm. Esp. 3), 52-65. Recuperado de https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/3606
26. Asín Cala, M. (2019). *Ideas educativas del maestro santiaguero Juan Bautista Sagarra Blez*. Moldova: Editorial Academica Española.
27. Barber G., E. y Barber, M. Q. (2000). *La Fisiología y el problema de la correlación entre lo biológico y lo social*. La Habana: Facultad de Ciencias Médicas Enrique Cabrera, ECIMED.
28. Batista M., A., Rojas H., N. M., Gonzales, A. y Hernández G., L. (2015). Educación para la salud desde un curriculum efectivo como experiencia de formación integral de estudiantes universitarios: experience of comprehensive formation of university students. *Educ Med Super*, 29(3). Recuperado de http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_ arttex&pid=S0864-21412015000300001&lng=es
29. Baxter, E. (2007). *Educar en valores. Tarea y reto de la sociedad*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
30. Bell C., J. (2018). *Formación científico clínica del residente de Medicina interna en la atención holística del síndrome metabólico.* (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.
31. Bermúdez M., R. y Pérez, M. L. (2004). *Aprendizaje Formativo y Crecimiento Personal*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
32. Bermúdez M., R. y Rodríguez R., M. (1996). T*eoría y metodología del Aprendizaje*. La Habana: Pueblo y Educación.
33. Berríos, J. (2008). La formación integral en la carrera médica. *Rev Peru Med Exp Salud Publica,* 25(3), 319-321. Recuperado de http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v25n3/a12v25n3.pdf

34. Borges O., L., Añorga M., J. A. y Barbón P., O. G. (2015). La Educación Avanzada ante las exigencias de los procesos de profesionalización pedagógica en la Educación Médica. *Educación Médica Superior*, 29(2). Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?Script=scfiarttext&pid=S0864-412015000200006=&ing=es&tlng=es
35. Borges, L. C. (2014). *Modelo de Evaluación de Impacto del posgrado académico en los docentes de la Facultad de Ciencias Médicas "General Calixto García"*. (Tesis de doctorado). Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona", La Habana, Cuba.
36. Brizuela T., G. B. (2012). *Estrategia educativa integradora para el desarrollo de los valores humanismo y responsabilidad en estudiantes de Medicina del policlínico universitario.* (Tesis de doctorado). Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País García, Santiago de Cuba, Cuba.
37. Calzadilla N., A., *et al*. (2017). Erosion of empathy during medical training by gender. A cross-sectional study. *Arch Argent Pediatr.,* 115(6), 556-561. Recuperado de http://dx.doi.org/10.5546/aap.2017.eng.556
38. Calzado H., L. (2012). *El desarrollo de la autovaloración docente desde el enfoque creativo vivencial en los estudiantes de la carrera Pedagogía-Psicología*. (Tesis de doctorado). UCP "Frank País García", Santiago de Cuba, Cuba.
39. Camejo R., L. P., Fernández D., D. F., y Valdés S., I. (2019). El diálogo intercultural y la formación de médicos en la Escuela Latinoamericana de Medicina. *Rev Panorama. Cuba y Salud*, 15(1), 47-54. Recuperado de http://www.revpanorama.sld.cu/index.php/rpan/article/view/
40. Carrese, J. A., *et al*. (2015). The essential role of medical ethics education in achieving professionalism: The Romanell Report. *Academic medicine: journal of the Association of American Medical Colleges*, 90(6), 744-752.
41. Castro R., F. (2000). *Discurso pronunciado en el tercer Congreso de la Organización de Pioneros José*

Martí. La Habana: Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado.

42. Cedeño Díaz, Z. L. (2020). *Dinámica interactiva del autodesarrollo personal profesional en la formación socio-humanista del estudiante de Medicina*. (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.
43. Cedeño Díaz, Z. L., Deroncele A., A. y Fuentes G., H. C. (2020). Formación socio-humanista del estudiante de Medicina: aportaciones teórico-prácticas. *Revista Mikarimin,* VI(2). Recuperado de http://45.238.216.13/ojs/index.php/mikarimin
44. Cedeño Díaz, Z. L., Fuentes G., H. C., Deroncele A., A. y Domecq G., Y. (2019). Talleres de autodesarrollo personal profesional para la formación humanista del estudiante de Medicina. *Revista Maestro y Sociedad*, 16(4), 706-718. Recuperado de https://revistas.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/5001
45. Cedeño Díaz, Z. L., Quertz M., O., Mancebo C., M. S. y Fuentes G., H. C. (2019). Metodología para la formación socio-humanista del estudiante de Medicina, Aplicación práctica. *Revista Maestro y Sociedad,* 16(4), 643-653. Recuperado de https://revistas.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/4991
46. Centro de desarrollo académico en salud. (2017). *Epistemología de las Ciencias Médicas*. (s.p.e.).
47. Chacón A., N. L. (2006). *Dimensión ética de la educación cubana*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
48. Chávez, I. (2006). *La formación humanista cultural en la educación médica superior. Experiencia en la Universidad Médica*. Recuperado de http//biblioteca.idict.villaclara.cu/UserFiles/feria 2006/Trabajo 2053.doc
49. Clavijo, D. (2018). Competencias del docente universitario en el siglo XXI. *Revista Espacios*, 39(20).
50. Columbié R., J. L. y Columbié O., F. J. (2014). *Proyección axiológica de la Universidad Médica de Santiago de Cuba en su medio siglo de fundada*. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192014001100020&lng=es
51. Columbié R., J. L. y Columbié O., F. J. (2016). El valor responsabilidad como unidad de análisis del proceso

formativo integral en estudiantes de Ciencias Médicas. *Rev. MEDISAN*, 20(2).

52. Cook, R. J. y Lawless, J. F. (2022). Life history analysis with multistate models: A review and some current issues. *The Canadian Journal of Statics*, 50(4), 1270-1298. Recuperado de https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cjs.11711
53. Crespo, E. I. (2012). *Profesionalismo médico. Sección de Eméritos*. Recuperado de http://www.experienciamedicahp.com.ar/edicionespecial/pdf/3.p
54. Cruess, S. R., Cruess, R. L. & Steinert, Y. (2019). Supporting the development of a professional identity: General principles. *Medical Teacher*, 41(6), 641-649. Recuperado de https://doi.org/10.1080/0142159X.2018.1536260
55. Del Tránsito S., E., Otondo B., M. y Álvarez C., D. (2020). *Niveles de motivación en el estudiantado de enfermería y estrategias de enseñanza. Rev. Educación Médica Superior*, 34(2).
56. Delgado D., C. J. (2005). Cambios revolucionarios y cuestionamientos éticos en las ciencias de la vida: los enigmas de la vida diseñada. En: *Bioética y medio ambiente*. (pp. 23-29). La Habana: Editorial Félix Varela.
57. Delgado, G. (2009). *Historia de la enseñanza superior de la Medicina en Cuba*. La Habana: Editorial Ciencias Médicas.
58. Delory Momberger, C. (2021). *Historias de Vida y formación*. file:///C:/Users/Ediciones/Downloads/345177-Texto%20del%20art%20culo-215206-1-10-20210203.pdf
59. Deroncele A., A. (2015). *Estrategia educativa para la Formación profesional integral del Psicólogo en el contexto organizacional*. (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.
60. Díaz N., V. P., *et al.* (2017). Reconsidering the "Decline" of Dental Student Empathy in Latin America. *Acta Médica Port*., 30(10), 775-782. Recuperado de https://dx.doi.org/10.20344/amp.8681
61. Díaz Q., J. A. (2013). *El perfeccionamiento del proceso evaluativo del diagnóstico médico con enfoque*

desarrollador. (Tesis de doctorado). Universidad de Ciencias Pedagógicas Capitán Silverio Blanco, Sancti Spíritus, Cuba. Recuperado de http://tesis.repo.sld.cu/687/

62. Domínguez G., L. (2009). Perspectivas del enfoque histórico-cultural para la psicología del desarrollo. VIII Taller Internacional de Psicología latinoamericana y caribeña. Revista *Santiago*, (número especial). Recuperado de http://santiago.uo.edu.cu
63. Dorta, G. y González. B. (2003). *La motivación según la teoría de Porter y Lawler.* (Trabajo de grado). Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela.
64. Duconger C., R. D. (2019). *Estrategia de superación para el mejoramiento de los conductores de los procesos universitarios de la Escuela Latinoamericana de Medicina.* (Tesis de doctorado). Universidad de Ciencias Médicas, La Habana, Cuba.
65. Erikson, E. (1989). *Identidad: juventud y crisis.* Madrid: Taurus Humanidades.
66. Escalona V., I. C. (2008). *Dinámica de orientación de la comunicación educativa en el juego de roles.* (Tesis de doctorado). Universidad de Ciencias Pedagógicas "Frank País García", Santiago de Cuba, Cuba.
67. Espinoza Freire, E. E., Granda Ayabaca, D. M., & Ramírez López, J. A. (2020). Competencias profesionales de los docentes de educación básica. Machala. *Revista Didasc@lia: Didáctica y Educación*, 11(3).
68. Expósito Unday, D. y González Valero, J. A. (2017). Sistematización de experiencias como métodos de investigación. *Gaceta Médica Espirituana*, 19(2). https://www.medigraphic.com/pdfs/espirituana/gme-2017/gme172c.pdf
69. Fabelo Corzo, J. R. (2003). *Los valores y los desafíos actuales*. La Habana: Editorial José Martí.
70. Fabelo, J. R. (1989). *Práctica Conocimiento y Valoración*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
71. Fernández S., J. (1999). *Educación Médica Superior. Realidades y perspectivas a las puertas del nuevo siglo*. [Cd-Rom].

72. Fernández S., J. (2008). El Diálogo Ético en la ofensiva por la excelencia. *Rev. Cub. Salud Pública*, 32(4). Recuperado de http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol32_4_06/spu05406.htm.
73. Ferrarotti, F. (2007). Las Historias de Vida como método. *Convergencia* 14(44). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352007000200002
74. Ferreira, G., Ferrández, T., Lolas, F., Almeida, R., Brunet, J. y Bosch, J. (2016). Ethics competences in the undergraduate medical education curriculum: The Spanish experience. *Croatian medical journal*, 57(5), 493-503.
75. Ferrero, A. y Andrade, E. (2007). Propuestas vigentes para la formación ético-deontológica. *Rev. Fundamentos en Humanidades*, VIII(015), 163-178.
76. Freire, P. (1996). *Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la práctica educativa*. Sao Paulo: Editora Paz y Tierra.
77. Fuentes G., H. C. (2011). *La formación en educación superior, desde lo holístico, complejo y dialéctico de las ciencias*. Santiago de Cuba: Universidad de Oriente.
78. Fuentes G., H. C y Zaldívar R, Y (2019). *Documentos del Diplomado Posdoctoral*. Santiago de Cuba: Hospital General Juan Bruno Zayas.
79. Fuentes G., H. y Álvarez V., I. (2005). *Lo sistémico y lo holístico configuracional: dos teorías de un mismo paradigma.* Santiago de Cuba: Universidad de Oriente.
80. Fuentes G., H. y Álvarez V., I. (2006). *La Teoría Holístico Configuracional: una alternativa epistemológica en la construcción del conocimiento científico.* Santiago de Cuba: Universidad de Oriente.
81. Fuentes G., H. y Álvarez V., I. (2008). *La Formación de los Profesionales en la Contemporaneidad. Una Concepción científica holística configuracional en la Educación Superior.* Santiago de Cuba: Universidad de Oriente.

82. Fuentes G., H. y Álvarez V., I. (2009). *Pedagogía y didáctica de la educación superior.* Santiago de Cuba: Universidad de Oriente.
83. Fuentes G., H. y Pérez, L. (2012). *La Formación en la Educación Superior.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
84. Fuentes G., H., Montoya R., J. y Fuentes S., L. (2010). *La condición humana desde la visión socio-antropológico-cultural del ser humano*. Santiago de Cuba: Universidad de Oriente.
85. Fuentes S., L. (2006). *Dinámica de la Formación Semipresencial en las Sedes Universitarias Municipales.* (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.
86. Gámez-Rodríguez, E., Paz-Domínguez, I., & Ramos-Romero, G. (2014). Estudios en torno al proceso histórico-pedagógico y a la sistematización de las concepciones pedagógicas de la enseñanza técnica en Santiago de Cuba. *Maestro y Sociedad*, 11(1), 107-115. Recuperado de https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/1680
87. García A., L. (2011). *La interacción es elemento definitorio del hacer educativo.* Recuperado de http://www.learningreview.com/articulos-y-entrevistas-elearning/3231-la-interaccion-eselemento-definitorio-del-hacer-educativo.
88. García C., J. (2014). *El humanismo como condición básica del hombre del nuevo milenio.* La Habana: Boletín del Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud.
89. García, G. (2002). *Compendio de Pedagogía*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
90. Giacamonte, O. A. (2009). P*rofesionalismo médico, su relación con la educación médica del siglo XXI. Educación médica permanente.* Recuperado de http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/8517/Documento_completo.pdf?s equence=1
91. Goderich Lalán, J. M., Ojeda López, L. A., Pardo Olivares, E., Jaén Oropeza, A., Molina Fernández, E. y

Goderich López, D. (2003). Hernias suprapúbicas. Un reto para el cirujano. *Rev. Cuba, Cir*., 42(3). https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-360495?src=similardocs

92. Góngora, J. J. (2005). *La autogestión del aprendizaje en ambientes educativos centrados en el alumno.* Recuperado de http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/boletin_9/pag3.htm
93. González A., N., Briggs J., M. B., Cardellá R., Ll. y Ortiz R., F. (2020). Recursos educativos abiertos en la carrera de Medicina. Biología molecular. *Rev Panorama. Cuba y Salud,* 15(1), 35-41. Recuperado de http://www.revpanorama.sld.cu/index.php/rpan/article/view/.
94. González Garza, F. (2006). *La ética implícita en el actuar humano*. (s.p.e.).
95. González M., R. (2011). *Humanismo y gestión de salud en el siglo XXI: ¿Avanzamos o retrocedemos?* La Habana: Editorial Ciencias Médicas. Recuperado de http://www.bvs.sld.cu/libros/humanismo/humanismo
96. González R., F. (2002). *Formación de ideales morales en los adolescentes en algunas cuestiones del desarrollo moral de la personalidad*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
97. González R., F. (2004). Lo cultural y lo espiritual en la formación médica. Apreciación de estudiantes de 5to año de Medicina. *Rev de Med Gral Integr,* 20(3). Recuperado de http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol20_3_04/mgi02304.htm.
98. González R., F. (2005). *Psicología de la personalidad*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
99. González, A. M., Ledesma, M. B. y Molozaj, M., A. (2022). *Referentes de Psicopedagogía: Historias de Vida de Haydée Echeverría y sus aportes al campo psicopedagógico*. https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2024
100. Gross, R. y Deroncele, A. (2012). La enseñanza del método en la Psicología. Una experiencia desde la Universidad de Oriente. Revista *Santiago*, (Número especial), 308-320. Recuperado de https://santiago.uo.edu.cu/index.php/stgo/article/view/1499

101. Gross, R., Deroncele, A. y Montoya, J. (2018). Construcción de la competencia interventiva del psicólogo. Revista *Opuntia Brava*, 10(3), 10-18. Recuperado de http://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiabrava/article/view/534

102. Gross, R., Montoya, J. y Deroncele, A. (2017). El proceso de formación científico-profesional del psicólogo. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, IV(3). Recuperado de https://dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/_files/200003497-d5da1d6d60/17-5-28%20El%20proceso%20de%20formación%20científico-profesional%20del.pdf

103. Gutiérrez A., N. (2019). Repercusiones emocionales de la violencia escolar: Influencia en la inteligencia emocional. *Acción Psicológica*, 16(1), 143-56. Recuperado de http://search.ebscohost.com/login.aspxdirect=true&db=a9h&AN=128049189&lang=es&site=ehost

104. Gutiérrez R., P. (2006). La humanización de la Medicina. *Educ. méd.*, 9(supl.1). Recuperado de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-18132006000600014&lng=es

105. Hernández R., I. M. (2015). *Concepción pedagógica del proceso de formación humanista para los estudiantes de la carrera de Medicina.* (Tesis de doctorado). Universidad de Pinar del Rio, Pinar del Río, Cuba.

106. Hobfoll, H. (2002). Social and Psychological Resources and Adaptation. *Review of General Psychology*, 6(4), 307-324.

107. Hodelín Tablada, R. (2007). La enseñanza de la bioética en el pregrado. Reflexiones sobre un problema inconcluso. *Rev Haban Cienc Méd.*, 6(Supl. 5). Recuperado de http://scielo.sld.cu/pdf/rhcm/v6s5/rhcm08507.pdf

108. Hodelín Tablada, R. (2011). Bioética anglosajona en su 40 aniversario: el traspaso hacia América Latina y su llegada a Cuba. *MEDISAN,* 15(11), 1674.

109. Hodelín Tablada, R. y Fuentes Pelier, D. (2004). Formación de profesionales universitarios: un desafío bioético. *MEDISAN*, 8(1), 62-69. Recuperado de http://www.bvs.sld.cu/revistas/san/vol8_n1_04/san12104.htm

110. Hodelín Tablada, R. y Fuentes Pelier, D. (2011). Apuntes en la discusión sobre el consentimiento informado. *MEDISAN*, 15(3), 290-3. Recuperado de http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol_15_3_11/san03311.htm

111. Horruitiner S., P. (2007). *El proceso de formación. Sus características.* Recuperado de http://cvi.mes.edu.cu/peduniv/base-de-datos/2007-vol.-xii-no.-4/el-proceso-deformacion.-sus-caracteristicas

112. Ibarbia C., M. y Planas M., E. (2019). Formación de valores profesionales en estudiantes de segundo año de Tecnología de terapia física y rehabilitación. *Rev Panorama. Cuba y Salud*, 14(1), 41-47. Recuperado de http://www.revpanorama.sld.cu/index.php/rpan/article/view/

113. Ilizástigui D., F. (1985). *Salud, Medicina y educación médica*. La Habana: ECIMED.

114. Ilizástigui D., F. (2010). *La formación de los estudiantes de las carreras y de las residencias de los profesionales de la salud*. La Habana: Sociedad Cubana de Educadores en Ciencias de la Salud (SOCECS). Recuperado de http://files.sld.cu/sccs/files/2010/10/educacion-medica-pre-y-posgrado.pdf

115. Ilizástigui D., F. y Douglas P., R. (1993a). *Educación en el trabajo como principio rector de la Educación Médica Cubana*. La Habana: ECIMED.

116. Ilizástigui D., F. y Douglas P., R. (1993b). Formación del médico general básico en Cuba. *Educ Med Salud,* 25(2), 189-205.

117. Infante, A., Mata, I. y López A., D. (2000). Reforma de los sistemas de salud en América Latina y el Caribe: situación y tendencias. *Rev Panam Salud Pública*, 8(1-2), 13-20. Recuperado de http://www.scielo.org/pdf/rpsp/v8n1-2/3000.pdf

118. Izaguirre R., R. C. (2007). *La competencia cosmovisiva socio médica como constructo didáctico para*

la formación del médico general Integral básico. (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.

119. Kalet, A., *et al*. (2018). Professional Identity Formation in medical school: One measure reflects changes during pre-clerkship training. *MedEdPublish*, 7-41. Recuperado de https://doi.org/10.15694/mep.2018.0000041.1

120. Kit Wong, M., et al. (2022). A systematic scoping review of undergradauate medical ethics education programs from 1990 to 2020. *Medical Teacher*, 44(2), 167-186. Recuperado de https://doi.org/10.1080/0142159X.2021.1970729

121. Ladino, S., Paola, P. y Morales, M. (2017). T*endencias y retos de la formación social humanística en educación superior de la última década*. Bogotá: Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.

122. Lahera C., R. (2009). *Estrategia para la formación de la competencia investigativa en el ciclo básico de la carrera*. (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.

123. Landín Miranda, M. R. y Sánchez Trejo, S. I. (2019). El método biográfico-narrativo. Una herramienta para la investigación educativa. *Educación*, 28(54). http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1019-94032019000100011&script=sci_arttext

124. Latibjonovna, B. G. (2021). Ethics of the Relationship between the Medical Professional and the Patient System. *International Journal of Development and Public Policy*, *1*(4), 115-120. Recuperado de https://openaccessjournals.eu/index.php/ijdpp/article/view/237

125. León Méndez, J. A. (1995). *Contribución del Sr. Salvador Massip a la enseñanza de la Geografía*. Recuperado de http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal5/Ensenanzadelageografia/Metodologiaparalaensenanza/02.pdf

126. León Méndez, J. A. (2016). *La enseñanza al servicio de la patria*. Recuperado de https://www.granma.cu/cuba/2016-06-24/la-ensenanza-al-servicio-de-la-patria-24-06-2016-17-06-17

127. Macías Q., A. M., Bustamante A., L. M. y Peñalver R., C. (2019). Comportamientos humanos de los instructores educativos. Atención a la diversidad cultural. Escuela Latinoamericana de Medicina. *Rev Panorama. Cuba y Salud,* 14(1), 10-12. Recuperado de http://www.revpanorama.sld.cu/index.php/rpan/article/view/

128. Makhmudova Aziza Nugmanovna, & Kamariddinzoda Aminabonu Kamariddinovna. (2021). Modern biotechnical problems of medicine and their solutions. *Archive of Conferences*, *13*(1), 169-173. Recuperado de https://www.conferencepublication.com/index.php/aoc/article/view/602

129. Mamajonova Gulnoza, K. (2019). Bioetics-A component of culture: development tendencies and basic features. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 8(9), 112-115. Recuperado de https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ajmr&volume=8&issue=9&article=013

130. Marañón Cardonne, T. (2018). *Dinámica de la formación científico investigativa del investigador clínico en ejercicio profesional.* (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.

131. Marañón Cardonne, T., García Céspedes, M. E. Fuentes González, H. C., Oropesa Roblejo, P. y Zaldívar Rosales, Y. (2021). The systematization of clinical trial protocols in scientific-research training development. *Revista Cubana de Tecnología de la Salud*, 12(1). Recuperado de https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/contenidol.cgi?IDPUBLICACION=9911

132. Mariño C., J. T. (2010). *Cómo desarrollar la personalidad de los alumnos desde una escuela creativa vivencial.* Puebla: Editorial El Errante.

133. Martí P., J. J. (1991). *Obras escogidas*. (Tomo 4). La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

134. Maslow, A. (1985). ¿Qué nos enseña la psicología existencial? En Torre M., C. y Calviño V. F., M.

comp. *Historia de la Psicología. Lecturas escogidas*. (pp. 47-60). La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

135. Maslow, A. (2010). *El hombre autorrealizado*. Barcelona: Paidós.

136. Medina Z., P. y Deroncele A., A. (2020). La práctica investigativa dialógico-reflexiva para orientar la problematización como operador epistémico de la construcción científico-textual. *Revista Inclusiones*, 7(2), 160-174.

137. Mendoza P., L. (2009). Resumen de Tesis para optar por el grado científico en Ciencias Filosóficas. En Rodríguez B., D. J. (2009). *La identidad como tema en la obra martiana. Una lectura desde la filosofía.* (pp. 51-57). Santiago de Cuba: Universidad de Oriente.

138. Mendoza, L. (2003). *Axiología y cultura en José Martí*. [Tesis de Maestría]. Instituto Superior Pedagógico" Enrique José Varona", La Habana, Cuba.

139. Mera Rodríguez, A. (2019). La sistematización de experiencias como métodos de investigación para la producción del conocimiento. *Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales*, 4(1). https://doi.org/10.33936/rehuso.v4i1.2143

140. Mined. (2013). *Documento Base para la implementación del Programa Director para la Educación en el Sistema de Valores de la Revolución Cubana*. La Habana: Ministerio de Educación.

141. Minsap. (2010). *Programa director de la Medicina General Integral para el médico General Básico*. La Habana: Ministerio de Salud Pública.

142. Molina P., N. y González M., A. (2008). *La formación humanista cultural en la educación médica superior. Experiencia en la Universidad Médica.* Recuperado de http//biblioteca.idict.villaclara.cu/UserFiles/feria2006/Trabajo 2053.do.pdf

143. Montoya, R. J. (2010). *Aproximación al concepto de cultura desde la Antropología de la Educación.* (Conferencia). Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.

144. Morales S., I. (2002). *El trabajo educativo y la formación de valores en la Universidad Médica*. [Cd-Rom].

145. Morgano, M. (1999). *Búsquedas teóricas y Epistemológicas desde la práctica de la sistematización. Taller permanente de sistematización*. Perú: (s.e.).

146. Mulen Favier, A. (2016). *Enma Elvira Guerra Cardona: estudio de su obra educativa en Guantánamo.* (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.

147. Nazario Dolz, A. M., Luna Vázquez, L., González Peña, E. (2017). Dr. C. José Miguel Gonzalo Goderich Lalán: un paradigma de la cirugía general. *MEDISAN*, 21(9). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192017000900016

148. Nicol, E. (1986). *Humanismo y Ética*. [Cd-Rom].

149. Nogueira Sotolongo, M., Rivera Michelena, N. y Blanco Horta, F. (2005). Competencias docentes del Médico de Familia en el desempeño de la tutoría en la carrera de Medicina. *Educ Med Sup*; (19).

150. Noriega Villalón, L. (2014). *Presencia hispánica en la educación de Santiago de Cuba durante la República Neocolonial (1902-1958).* (Tesis de doctorado). UCP "Frank País García", Santiago de Cuba, Cuba.

151. Ojalvo M., V. (2018). *La educación de valores en el contexto universitario*. La Habana: Editorial Félix Varela.

152. Oliva, O. (2021). *La huella infinita de Francisco Ibarra Martínez*: *El maestro, el historiador, el precursor*. Roque Libros (1ra ed.).

153. Olmos, L. (2004). *La crisis de la universidad humanista*. México: CETIS.

154. ONU. (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. Organización de Naciones Unidas. Recuperado de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

155. Oropesa R., P. (2018). *Dinámica científico-tecnológica-asistencial del proceso de superación profesional en terapia ocupacional del rehabilitador en salud.* (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.

156. Orpí Galí, C., Senú González, I., & Céspedes Quiala, A. (2018). Aproximación a la vida y proyección pedagógica de María de los Ángeles Mercaderes Ferrer entre 1938 y 1958. *Maestro y Sociedad*, (Número Especial), 3-17. Recuperado de https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/3790

157. Ortiz S., Y. (2016). *Modelo de formación pedagógica del profesional médico desde la labor asistencial*. (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.

158. Parra F, R, M. (2013) Estudio de la vida y obra del Dr. José Reinaldo Roca Goderich para su sistematización. (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.

159. Pascual G., J. (2017). *Estrategia curricular de Medicina física y rehabilitación para la carrera de Medicina.* (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.

160. Payá Sanchez, M., Buxarrais Estrada, M. R., Martínez Martín, M. y Palos Rodríguez, J. (2010). *Educación ética y valores*. Recuperado de https://docplayer.es/17595383-Educacion-etica-y-en-valores.html

161. Paz D., I., Venet M., R., Ramos R., G., Márquez R., A. y Orozco H., O. (2011). *Formando al educador del siglo XXI. Reflexiones, experiencia y propuestas pedagógicas.* [Cd-Rom].

162. PCC. (1996). *VI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.* La Habana: Comité Central del PCC.

163. PCC. (2016). *Tesis y Resoluciones del Partido Comunista de Cuba. VII Congreso.* La Habana: Comité Central del PCC.

164. Peñalver, C. (2017). P*rograma educativo para el mejoramiento Permanente de los comportamientos humanos en los trabajadores de servicio del "Hospital Universitario General Calixto García.*

(Tesis de doctorado). Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona", La Habana, Cuba.

165. Pérez M., U. L. (2001). *La Fisiología en el contexto del encargo social a la Universidad Médica.* Santiago de Cuba: Universidad de Oriente.

166. Pernas G., M., Garí C., M., Arencibia F., L. G., Rivera M., N. y Nogueira S., M. (2012). Consideraciones sobre las ciencias básicas biomédicas y el aprendizaje de la clínica en el perfeccionamiento curricular de la carrera de Medicina en Cuba. *Educ Med Super.,* 26(2). Recuperado de http://www.ems.sld.cu/index.php/ems/article/view/33

167. Pernas, M. *et al*. (s.f.). *El plan de estudio para la formación del médico general básico en Cuba: Experiencias de su aplicación*. http://bvs.sld.cu/revistas/ems/vol19_3_03/ems04303.htm.

168. Pernas, M. y Arrencibia, L. (2001). Perfeccionamiento del proceso docente en Medicina y su posible impacto en la orientación profesional. *Rev. Cubana Educación Médica Superior*, 15(3).

169. Piña F., R. (2016). *Formación permanente de la cultura científico investigativa en los tecnólogos de la salud.* (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.

170. Pozuelos, F. J., Rodríguez, F. P. y Travé, G. (2012). El enfoque interdisciplinar en la enseñanza universitaria y aprendizaje basado en la investigación. Un estudio de caso en el marco de la formación. *Revista de Educación*, 357. Recuperado de www.uhu.es/francisco.pozuelos/biblioteca/re_interdisc 357_073.pdf

171. Puente S., V. (2018). *Dinámica clínico-asistencial-humanista en la atención a los pacientes con VIH/sida para residentes de Medicina interna.* (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.

172. Quertz M., O. (2013). *Dinámica de la formación profesional bio-antropo-social en las Ciencias Biomédicas.* (Tesis de doctorado). Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País García, Santiago de Cuba, Cuba.

173. Quintana, O. (2003). Los objetivos de la Medicina. R*evista de Calidad Asistencial,* 18(2), 132-135. Recuperado de http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-calidad-asistencial-256/los-objetivosMedicina-13044265-temas-bioetica 2003

174. Ramos R, G. (2003). *Las concepciones pedagógicas en Santiago de Cuba durante la República Neocolonial*. (s.p.e.).

175. Ramos R., G. (2003). *El proceso histórico-pedagógico. Su estudio y sistematización*. Santiago de Cuba: (s.e.).

176. Ramos R., G. (2008). *La sistematización como método para la validación de los resultados científicos de las investigaciones educativas.* Santiago de Cuba: Universidad de Ciencias Pedagógicas "Frank País García".

177. Ramos S., G. y González P., E. (2000). *La formación humanística como componente de la formación integral.* Recuperado de http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/libros/index/assoc/HASH5bf2.dir/doc

178. Ramos Serpa, G. & López Falcón, A. (2020). Formación ética del profesional y ética profesional del docente. *Estudios Pedagógicos*, 45(3), 185-199.

179. Reyes M., R. (2012). *Estrategia didáctica para la formación de la competencia gerontología geriátrica en el médico general.* (Tesis de doctorado). Universidad de Ciencias Pedagógicas "Frank País García", Santiago de Cuba, Cuba.

180. Roca G., J. R. (2007). *Instauración de la docencia médica en Santiago de Cuba*. Santiago de Cuba: Editorial Chaguito, Instituto Superior de Ciencias Médicas.

181. Roca G., J. R. (2011). *Instauración de la docencia médica en Santiago de Cuba*. Santiago de Cuba: UCM.

182. Rodríguez C., M. A. (2011). La sistematización como resultado científico de la investigación

educativa. ¿Sistematizar la sistematización? En: *Investigación Interdisciplinaria en las Ciencias Pedagógicas*. (pp. 74-95). La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

183. Rodríguez S., H. (2006). La relación médico-paciente. *Rev, Cubana Salud Pública*, 32(4). Recuperado de http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol32_4_06/spu07406.htm.

184. Rodríguez-Rebustillo, M. (2014). ¿Por qué el enfoque humanista es la única opción posible para las ciencias sociales? *Revista Alternativas Cubanas en Psicología*, 2(6), 16-21. Recuperado de https://www.acupsi.org/numero/16/vol-2-nm-6-2014.html

185. Rogers, C. (2004). *Los grupos de encuentro.* Argentina: Amorrortu.

186. Rojas O., F. (2003).La enseñanza de la salud pública a estudiantes de Medicina en Cuba. *Educ Med Super,* 17(2). Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S086421412003000200001&script=sci_arttext&tlng=pt

187. Romero P., C. L. y Acosta M., H. (2000). *La formación de valores en la universidad: exigencias teórico-metodológicas.* La Habana: Editorial Félix Varela.

188. Salas H., R. (2018). *La formación humanista en estudiantes de preuniversitario.* (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.

189. Salas M., A. y Salas P., R. S. (2015). La Bioética en la educación médica superior cubana actual. *Educ Med Super,* 26 (3). Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412012000300009&lng=es

190. Salas P., R. S. y Salas M., A. (2012). *La educación médica cubana. Su estado actual.* Recuperado de http://www.redu.net/redu/index.php/REDU/article/view/477/

191. Sánchez-Elvira., A. (2007). La autorregulación consciente: un camino de crecimiento. En Rodríguez Z., M. (Ed.). *Psicología y Conciencia.* (pp. 349-376). Barcelona: Kairos.

192. Sánchez-Elvira., A. (2015). *Recursos personales. La Psicología Positiva en las organizaciones.* Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/284545377

193. Sánchez-Toledo M. E. (1998). *La obra pedagógica de Alfredo Miguel Aguayo*. (Tesis de doctorado). Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona"; La Habana, Cuba.

194. Sarraf-Yazdi, S., *et al.* (2021). A Scoping Review of Professional Identity Formation in Undergraduate Medical Education. *J GEN INTERN MED* 36, 3511-3521. Recuperado de https://doi.org/10.1007/s11606-021-07024-9

195. Sartre, J. P. (1960). *Critique de la Raison dialéctique*. Paris: (s.e.).

196. Senú González, I. (2011). *Lidia Turner Martí defensa de un paradigma de la pedagogía cubana y latinoamericana desde la ternura, investigadora de profunda vocación martiana*. IV Taller Científico de Motivación Profesional Pedagógica desde un enfoque creativo vivencial. [CD-ROOM].

197. Senú González, I. (2015). *Estrategia pedagógica para promover el conocimiento de la vida y obra pedagógica de la maestra Lidia Esther Turner Martí en la asignatura Historia de la Pedagogía"*. (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.

198. Socarras Á., MM, Rodríguez, S., y Albite A. (2019). El desarrollo de las habilidades emocionales mediantepracticas inclusivas en la Escuela Latinoamericana de Medicina. *Rev Panorama. Cuba y Salud,* 14(1), 106-108. Recuperado de http://www.icle/view/

199. Soto Arango, D. E., Naranjo Patiño, D. E. y Cuño Bonito, J. (2018). Historias de Vida de educadores. Aproximación historiográfica y metodológica. *Revista Inclusiones*, 5(Número Especial), 122-54. https://revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/916

200. Suárez R., C. O. y Del Toro, M. (2011). *Universidad: cultura, educación y desarrollo*. Santiago de Cuba: (s.e.).

201. Suárez R., C., Moncada S., C. y Del Toro S., M. (1999). *Didáctica del aprendizaje en la formación delprofesional.* Santiago de Cuba: Universidad de Oriente.

202. Tejera C., J. F. (2010). *Estrategia didáctica para la formación de habilidades comunicativas en los estudiantes de tercer año del ciclo clínico de la carrera de Medicina.* (Tesis de doctorado). Universidad de Cienfuegos "Carlos Rafael Rodríguez", Cienfuegos, Cuba.

203. Téllez V., T. (2012). *Estrategia educativa para la formación laboral en Salud Pública del estudiante de la Licenciatura en Psicología.* (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.

204. Turnnerman B., C. (1998). *La educación superior en el umbral del siglo XXI.* Venezuela: Ediciones CRESALC/Unesco.

205. Unesco. (1999a). *Declaración sobre la ciencia, la educación y la cultura, en la XXX Conferencia General sobre la ciencia.* París: Unesco.

206. Unesco. (1999b). *Conferencia Mundial sobre la ciencia para el siglo XXI*. Budapest: Unesco.

207. Unesco. (2009a). *Conferencia Mundial sobre Educación Superior. Las Nuevas Dinámicas de la Educación Superior y de la Investigación para el Cambio Social y el Desarrollo*. París: Unesco.

208. Unesco. (2009b). *IV Foro Mundial de Ciencias*. Montevideo: Unesco.

209. Vaillant, D. y Marcelo, C. (2001). *Las tareas del formador*. Málaga: Aljibe.

210. Valle L., A. (2012). *La investigación pedagógica otra mirada.* La Habana: Instituto Central de CienciasPedagógicas.

211. Vallejo P., G. R. (2012). *Estrategia pedagógica para la corrección de actitudes interferentes hacia el aprendizaje en el estudiante de Medicina.* (Tesis de doctorado). UCP "Frank País G.", Santiago de Cuba, Cuba.

212. Vargas, G. (2018). La filosofía de la praxis. Dos concepciones: Antonio Gramsci y Adolfo Sánchez Vázquez. *Revista Dialectus*, 5(13). Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/330207085_LA_FILOSOFIA_DE_LA_PRAXIS_DOS_CONCEPCIONES_ANTONIO_GRAMSCI_Y_ADOLFO_SANCHEZ_VAZQUEZ/link/5c340acd29bf12be3b67ba4/downlod

213. Vega M., M. E., Morales B., D. y Graverán B., A. (2020). Conocimientos de los efectos nocivos de las TIC de los estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina. *Rev Panorama. Cuba y Salud,* 15(1), 6-10. Recuperado de http://www.revpanorama.sld.cu/index.php/rpan/article/view/

214. Vega, M. P. (2003). *El Proyecto Educativo Integral y la educación en valores.* (s.p.e.).

215. Vélaz de Medrano, C. & Vaillant, D. E. (2021). Aprendizaje y desarrollo profesional docente. *Revista Conrado*, 17(80), 194-200.

216. Veliz J., C., Pérez D., N., Núñez L., E. y Hernández, Á. (2015). El proceso extensionista de la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Rio. *Rev Ciencias Médicas*, 19(4), 678-690. Recuperado de http://www.revcmpinar.sld.cu/index.php/publicaciones/article/view/2240

217. Vicente, E., Feria, G. E., Díaz, M. T., Leyva, B., Expósito, A. y Leyva, C. A. (2018). Dilemas éticos en la práctica del saber médico. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, VI(1). Recuperado de https://dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/_files/200003996-128c5138cf/18.09.55%20Dilemas%20%C3%A9ticos%20en%20la%20pr%C3%A1ctica%20del%20saber%20m%C3%A9dico.pdf16

218. Vidal L., E. H. (2011). *Dinámica de la formación profesional antropopsiquiátrica en la especialización de psiquiatría.* (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente. Santiago de Cuba, Cuba.

219. Vidal L., M., y Pérez S., A. (2016). Formación en Valores. Conceptos éticos y tecnológicos, métodos y estrategias. *Educación Médica Superior*, 30(4). Recuperado de

http://www.ems.sld.cu/index.php/ems/article/view/881

220. Vidal, M. y Pernas, M. (2007). Diseño curricular. *Educ Med Super,* 21(2). Recuperado de http://bvs.sld.cu/revistas/ems/vol21_2_07/ems12207.htm

221. Vigotsky, L. S. (1989). *Obras Completas.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

222. Vigotsky, L. S. (1998). *Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores.* La Habana: EditorialCientífico Técnica.

223. Villar, T. (2010). *Desarrollo de la inteligencia emocional, una oportunidad de crecimiento personal*. (Tesis de maestría). México: Universidad Vasco de Quiroga.

224. Vitier, C. (1996). *La formación de valores en las nuevas generaciones: una campaña de espiritualidad y conciencia*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

225. Vizcaíno, T. y Montoya, J. (2016). Consideraciones generales acerca de la formación humanista universitaria en ciencias de la salud: un planteamiento teórico. *MEDISAN*, 20(3), 395.

226. Zaldívar Rosales, Y., Cedeño Diaz, Z. L., Marañón Cardonne, T. y Vinent Mendi, M. B. (2022). La formación ético-profesional como componente integral del proceso formativo del estudiante de Medicina. *Maestro y Sociedad*, 19(3), 1228-1235. Recuperado de http://maestroysociedad.uo.edu.cu

227. Zaldívar Rosales, Y., Fuentes González, H. C. y García Céspedes, M. E. (2021). Contradicciones sociales en la formación de valores desde la relación médico-paciente-familia en profesionales de las Ciencias Médicas. *MEDISAN*, 25(1), 238-250. Recuperado de https://www.redalyc.org/journal/3684/368466087020/

228. Zaldívar Rosales, Y., Fuentes González, H. C. y García Céspedes, M. E. (2020). La vida profesional de figuras relevantes de las Ciencias Médicas como incentivo en la formación de los estudiantes de Medicina. *MEDISAN*, 24(4). Recuperado de http://www.medisan.sld.cu/index.php/san/article/view/2776

229. Zangara, A. y Sanz, C. V. (2017). *Interacción e interactividad en el trabajo colaborativo mediado portecnología informática.* (Tesis de doctorado). Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina.

Anexos

ANEXO no. 1

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA, ENCUBIERTA Y DISCRETA PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN EL TRABAJO PARA EL DESEMPEÑO ÉTICO-PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE DE MEDICINA

Objetivo: Evaluar el desempeño ético-profesional del estudiante de Medicina en las diferentes actividades de educación el trabajo como principio rector de la educación médica cubana.

Estudiante:_____

Año:_____

Esta guía se le realizó a los estudiantes de Medicina, de forma directa, encubierta y discreta, a través de supervisiones generales a los servicios donde encontraban realizando las diferentes actividades de educación en el trabajo como: pases de visitas, discusiones diagnósticas, conferencias y seminarios.se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

1. Valoración al estudiante durante el ejercicio profesional, en lo referente a la actitud, la aptitud, los comportamientos éticos, la proyección personal mediante la relación médico-paciente- familia.

   Bueno ( ) Malo ( )

2. Juicios y criterios emitidos por pacientes y familiares durante la relación médico-paciente-familia de los estudiantes en su ejercicio profesional.

   Buenos ( ) Malos ( )

3. Habilidades de comunicación afectiva del estudiante de Medicina con los pacientes y con sus compañeros y profesores.

   Bueno ( ) Malo ( )

4. Aplicación correcta del método clínico-epidemiológico con enfoque socio-humanista que permitió diagnosticar el estado de salud-enfermedad.

Bueno ( ) Malo ( )

5. Modo de actuación del estudiante de Medicina en los escenarios profesionales donde interactúa con el paciente y sus familiares (Adquisición progresiva de habilidades).

   Bueno ( ) Malo ( )

6. Seguridad de los pacientes y sus familiares hacia los estudiantes de Medicina en la asistencia médica.

   Bueno ( ) Malo ( )

7. Proyección del estudiante de Medicina en los escenarios profesionales y en los espacios de interacción hospitalaria.

   Bueno ( ) Malo ( )

8. Vocación profesional, revelada en el compromiso, la consagración y el humanismo del estudiante de Medicina en las actividades que se le designan en la educación en el trabajo.

   a. Bueno ( ) Malo ( )

9. Valoración de los pacientes y sus familiares sobre los comportamientos éticos del estudiante de Medicinasegún su encargo social.

   Bueno ( ) Malo ( )

10. Confección de la historia clínica individual que incluye la historia psicosocial, a partir del interrogatorio médico y el examen físico completo e integral.

    Bueno ( ) Malo ( )

Regla de decisión: Se realizó la suma de la cantidad de ítems con respuestas buenas, los que se considerarán como puntuaciones:

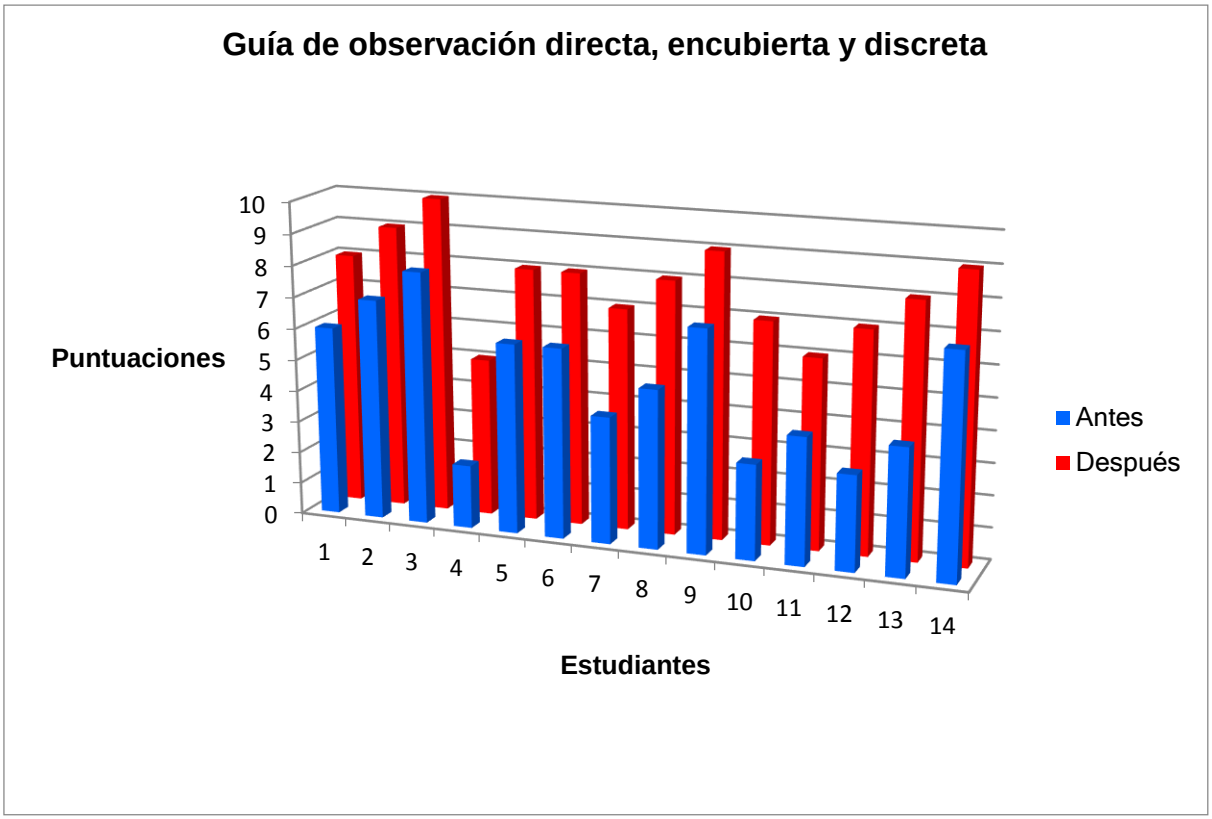
- De 7-10 ítems (7-10 puntos): adecuado desempeño ético profesional del estudiante.
- Menos de 7 ítems (menos de 7 puntos): inadecuado desempeño ético profesional del estudiante.

Resultados de la guía de observación directa, encubierta y discreta participante en las actividades de educación en el trabajo para el desempeño ético-profesional del estudiante de Medicina.

Guía de observación directa, encubierta y discreta				
Estudiante	**Antes**		**Después**	
	Puntuación	**Evaluación**	**Puntuación**	**Evaluación**
1	6	Inadecuado	8	Adecuado
2	7	Adecuado	9	Adecuado
3	8	Adecuado	10	Adecuado
4	2	Inadecuado	5	Inadecuado
5	6	Inadecuado	8	Adecuado
6	6	Inadecuado	8	Adecuado
7	4	Inadecuado	7	Adecuado
8	5	Inadecuado	8	Adecuado
9	7	Adecuado	9	Adecuado
10	3	Inadecuado	7	Adecuado
11	4	Inadecuado	6	Inadecuado
12	3	Inadecuado	7	Adecuado
13	4	Inadecuado	8	Adecuado
14	7	Adecuado	9	Adecuado

-
-

Guía de observación directa, encubierta y discreta		Después				Total	
		No satisfactorio		Satisfactorio			
		No.	%	No.	%	No.	%
Antes	Satisfactorio	0	0	4	28,6	4	28,6
	No satisfactorio	2	14,3	8	57,1	10	71,4
Total		2	14,3	12	85,7	14	100


Guía de observación directa, encubierta y discreta
Puntuaciones
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Estudiantes
Antes
Después

ANEXO No. 2

HOSPITAL GENERAL DR. JUAN BRUNO ZAYAS ALFONSO

ENCUESTAS A PACIENTES Y FAMILIARES

Objetivo: Obtener información primaria de los aspectos en la formación ético-profesional del estudiante de Medicina en los escenarios profesionales, donde interactúa con el paciente y sus familiares.

Servicio en el que lo asisten: _____

INTRODUCCIÓN

Estimado/a pacientes y sus familiares, con el propósito del mejoramiento de los comportamientos éticos del estudiante de Medicina en los escenarios profesionales, nos hemos propuesto conocer sus criterios y juicios sobre el modo de actuación de estos y para la cual le solicitamos expresar en esta encuesta sus criterios. Su identificación es anónima y sus respuestas se entregarán solo a los responsables de la investigación. Sus criterios contribuirán al mejoramiento de los servicios y a la formación ético-profesional del estudiante de Medicina en los escenarios profesionales Se considera dos alternativas positivo y negativo.

No	ASPECTOS	Positivo	Negativo
1	¿Cómo percibe los comportamientos éticos del estudiante de Medicina en su actuar profesional?		
2	¿Cómo distingue las habilidades comunicativas-afectivas del estudiante de Medicina?		
3	¿Cómo aprecia el modo de actuación del estudiante de Medicina?		
4	¿Cómo considera las acciones que totalizan lo ético-profesional del estudiante de Medicina?		
5	Si tuviera que caracterizar el modo de actuación del		

	estudiante de Medicina ¿cómo lo consideraría?		
6	¿Cómo distingue la realización de las tareas del estudiante de Medicina designadas por sus profesores?		
7	¿Creé que es necesario la trasformación de lo ético-profesional del estudiante de Medicina en el proceso formativo?		
8	¿Cómo aprecia estos valores éticos en los estudiantes de Medicina, compromiso, humanismo y consagración		
	Exprese cualquier consideración o criterio que crea pertinente, o que puedan mejorar el desempeño investigativo para desarrollar la formación ético-profesional del estudiante de Medicina.		

Muchas gracias por su colaboración.

Regla de decisión: Se realizó la suma de los aspectos marcados como positivos:

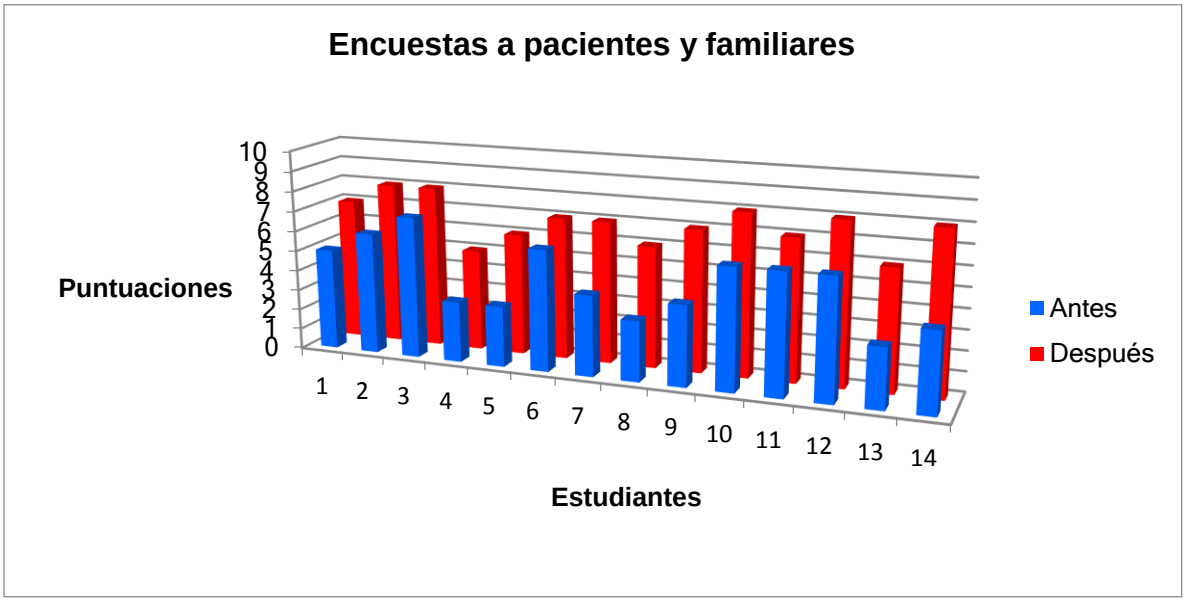
- De 6-8 aspectos positivos: adecuada formación ético-profesional del estudiante de Medicina en los escenarios profesionales, donde interactúa con el paciente y sus familiares.
- Menos de 6 aspectos positivos: inadecuada formación ético-profesional del estudiante de Medicina en los escenarios profesionales, donde interactúa con el paciente y sus familiares.

Resultado del Anexo No 2

Encuestas a pacientes y familiares				
Estudiante	**Antes**		**Después**	
	Puntuación	**Evaluación**	**Puntuación**	**Evaluación**
1	5	Inadecuado	7	Adecuado
2	6	Adecuado	8	Adecuado
3	7	Adecuado	8	Adecuado
4	3	Inadecuado	5	Inadecuado
5	3	Inadecuado	6	Adecuado
6	6	Adecuado	7	Adecuado
7	4	Inadecuado	7	Adecuado

8	3	Inadecuado	6	Adecuado
9	4	Inadecuado	7	Adecuado
10	6	Adecuado	8	Adecuado
11	6	Adecuado	7	Adecuado
12	6	Adecuado	8	Adecuado
13	3	Inadecuado	6	Adecuado
14	4	Inadecuado	8	Adecuado

Encuesta a pacientes y familiares		Después				Total	
		No satisfactorio		Satisfactorio			
		No.	%	No.	%	No.	%
Antes	Satisfactorio	0	0	6	42,9	6	42,9
	No satisfactorio	1	7,1	7	50,0	8	57,1
Total		1	7,1	13	92,9	14	100



ANEXO No. 3

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS

HOSPITAL GENERAL DR. JUAN BRUNO ZAYAS ALFONSO

Estimado colega con la intención de observar de manera sistemática los comportamientos éticos de los estudiantes de Medicina en los escenarios profesionales le solicitamos su colaboración en este estudio.

Este cuestionario, contiene una serie de aserciones relacionadas con los comportamientos éticos, así como su modo de actuación. Su tarea consiste en indicar el grado en que usted observa en los escenarios profesionales durante las actividades designadas al estudiante de Medicina en la educación en el trabajo. Para contestar, elija en la hoja de respuestas la opción que represente su grado de acuerdo con el contenido de la afirmación, según la siguiente escala Bueno y Malo:

No	**OBSERVACIONES SISTEMÁTICAS EN LOS ESCENARIOS PROFESIONALES**	**RESPUESTAS**	
		BUENO	MALO
1	Comportamientos éticos.		
2	Utiliza adecuadamente el método clínico-epidemiológico.		
3	Desarrolla trabajo en equipo.		
4	Identifica, plantea y resuelve problemas en los escenarios profesionales.		
5	Aplica los conocimientos en la educación en el trabajo.		
6	Piensa de forma crítica y autocrítica.		
7	Interactúa adecuadamente con los pacientes y sus familiares.		
8	Se manifiesta adecuadamente las relaciones interpersonales médico-paciente-familia.		
9	Estudia de forma autónoma.		
10	Desarrollan habilidades y capacidades intelectuales, físicas, éticas y estéticas.		
11	Actúa en nuevas situaciones salud-enfermedad, diagnóstico interventivo de las enfermedades en los pacientes.		

12	Trabaja de manera independiente e interviene en casos emergentes.		
13	Promueve un desarrollo en equipo, trabajo interdisciplinar hacia el logro de metas comunes.		
14	Habilidades de comunicación afectiva con los pacientes y familiares.		
15	Apreciación de los pacientes y sus familiares sobre los comportamientos éticos del estudiante de Medicina según su encargo social.		
16	Desarrolla valores éticos en los escenarios profesionales.		
17	Los profesores conducen comportamientos éticos en los estudiantes de Medicina durante las actividades designadas en la educación en el trabajo.		

Gracias por su colaboración

Regla de decisión: Se realizó la suma de la cantidad de ítems con respuestas buenas, los que se considerarán como puntuaciones:

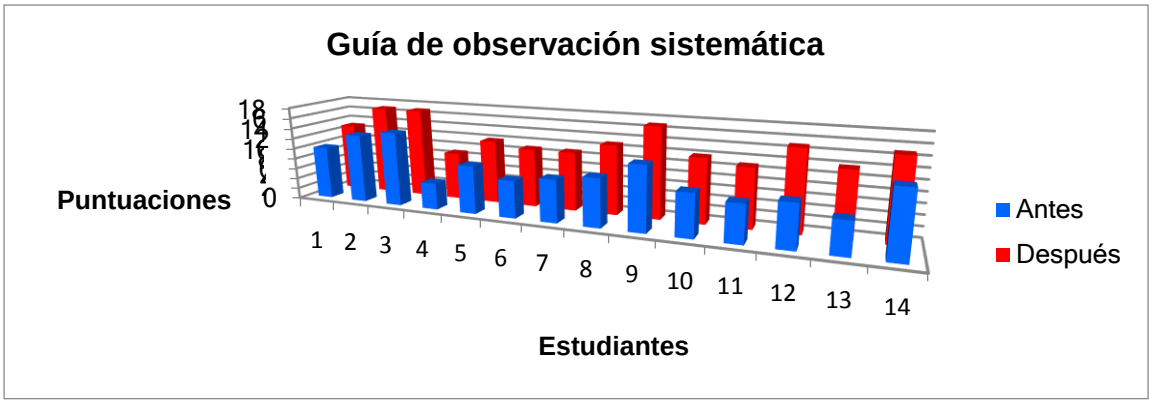
- De 11-17 ítems (11-17puntos): adecuados comportamientos éticos y modo de actuación en los escenarios profesionales durante las actividades de educación en el trabajo designados al estudiante de Medicina.
- Menos de 11 ítems (menos de 11 puntos): inadecuados comportamientos éticos y modo de actuación en los escenarios profesionales durante las actividades de educación en el trabajo designadas al estudiante de Medicina.

Resultados del Anexo No 3

• **Guía de observación sistemática**				
Estudiante	**Antes**		**Después**	
	Puntuación	**Evaluación**	**Puntuación**	**Evaluación**
1	10	Inadecuado	13	Adecuado
2	13	Adecuado	17	Adecuado
3	14	Adecuado	17	Adecuado
4	5	Inadecuado	9	Inadecuado
5	9	Inadecuado	12	Adecuado

6	7	Inadecuado	11	Adecuado
7	8	Inadecuado	11	Adecuado
8	9	Inadecuado	13	Adecuado
9	12	Adecuado	17	Adecuado
10	8	Inadecuado	12	Adecuado
11	7	Inadecuado	11	Adecuado
12	8	Inadecuado	15	Adecuado
13	6	Inadecuado	12	Adecuado
14	12	Adecuado	15	Adecuado

Guía de observación sistemática		Después				Total	
		No satisfactorio		Satisfactorio			
		No.	%	No.	%	No.	%
Antes	Satisfactorio	0	0	4	28,6	4	28,6
	No satisfactorio	1	7,1	9	64,3	10	71,4
Total		1	7,1	13	92,9	14	100



ANEXO no. 4

HOSPITAL GENERAL DR. JUAN BRUNO ZAYAS ALFONSO

ESCALA AUTO-CALIFICATIVA PARA ESTUDIANTES DE MEDICINA

Objetivo: Obtener información de los criterios del estudiante sobre su comportamiento ético y modo de actuación en los escenarios profesionales donde interactúa con los pacientes y sus familiares.

Año que cursa: _____

Facultad: _____

INTRODUCCIÓN

Estimado/a estudiante nos hemos propuesto conocer sus juicios sobre el nivel en el que usted se reconoce en esta escala. Su identificación es anónima y sus respuestas se entregarán solo a los responsables de la investigación.

Este instrumento determina el grado o nivel en que el estudiante se autoevalúa en cuanto a su comportamiento ético y en los escenarios profesionales donde interactúa con el paciente y sus familiares.

Para realizar la autoevaluación se utilizaron los siguientes niveles: bueno, regular y malo, teniendo en cuenta los criterios que se describen a continuación:

- Nivel bueno (valor de 2 puntos): cuando el estudiante reconoce que integra sus comportamientos éticos, modo de actuación y elementos que caracterizan los valores éticos en los escenarios profesionales.
- Nivel regular (valor de 1 punto): cuando el estudiante reconoce que presenta algunas dificultades en sus comportamientos éticos, en su modo de actuación y/o refleja pocos elementos que caracterizan sus valores éticos.
- Nivel malo (valor de 0 puntos): cuando el estudiante lo reconoce o los comportamientos éticos, modo de actuación son inadecuados y no dispone de elementos que muestren valores éticos.

ESCALA AUTO-CALIFICATIVA

No.	Marque con una (X) en qué nivel usted se considera que cumple con los siguientes indicadores	Nivel bueno	Nivel regular	Nivel malo	Puntuación total
1	Compromiso y responsabilidad en las tareas designadas durante la educación en el trabajo.				
2	Atención brindada a los pacientes y sus familiares.				
3	Humanismo médico como valor característico de esta profesión.				
4	Modo de actuación de usted y sus compañeros de año, es comprometido				
5	Consagración ante su profesión				
6	Ética en el actuar profesional				
7	Entrega e intervención oportuna en la atención integral a pacientes.				
8	Valores de humanismo y consagración.				
9	Conducción debida en los escenarios profesionales.				
10	Aptitud para el desempeño de la profesión.				

Muchas gracias por su cooperación.

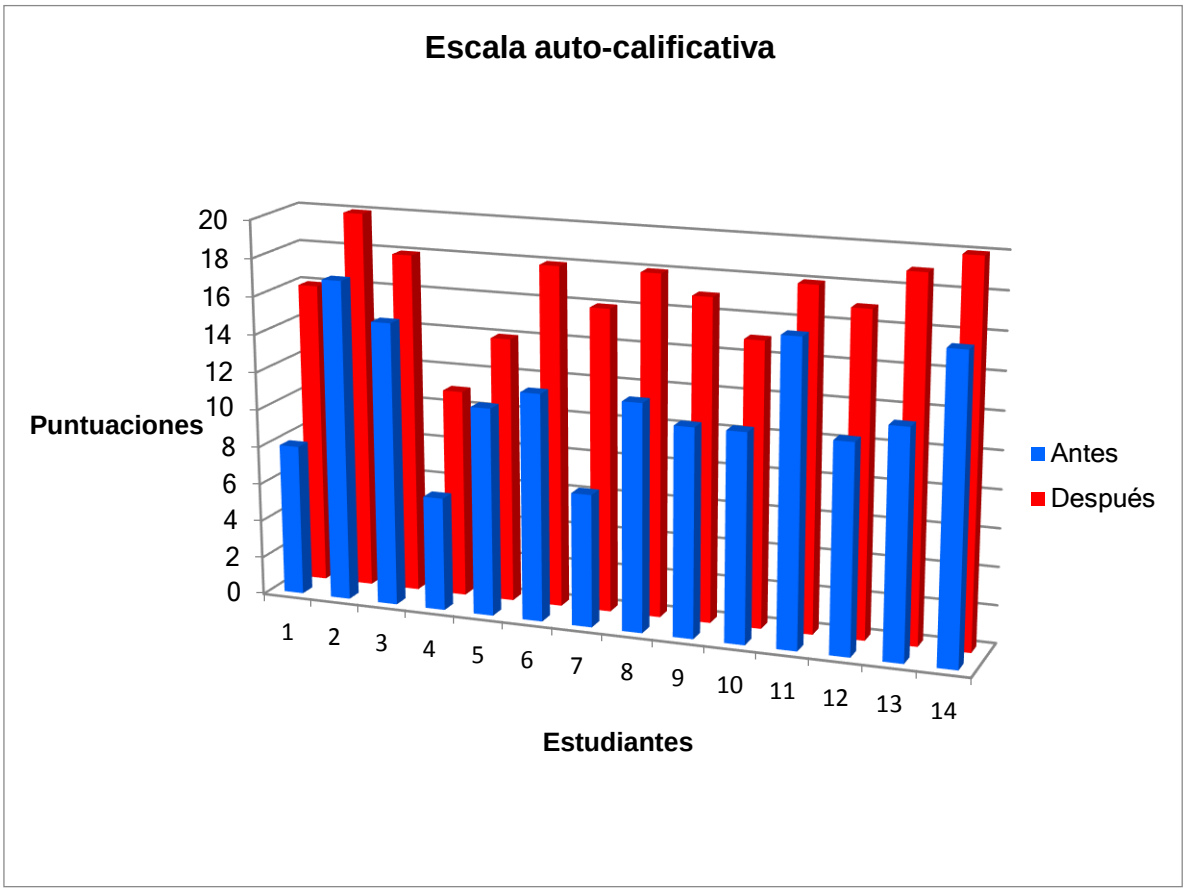
Regla de decisión: Se realiza la suma de todas las puntuaciones obtenidas en cada ítem:

- De 16-20 puntos: comportamientos éticos y modo de actuación en los escenarios profesionales adecuados.
- De 11-15 puntos: comportamientos éticos y modo de actuación en los escenarios profesionales poco adecuados
- 0-10 puntos: comportamientos éticos y modo de actuación en los escenarios profesionales inadecuados.

Resultados del Anexo No 4

Escala auto-calificativa				
Estudiante	**Antes**		**Después**	
	Puntuación	**Evaluación**	**Puntuación**	**Evaluación**
1	8	Inadecuado	16	Adecuado
2	17	Adecuado	20	Adecuado
3	15	Poco adecuado	18	Adecuado
4	6	Inadecuado	11	Poco adecuado
5	11	Poco adecuado	14	Poco adecuado
6	12	Poco adecuado	18	Adecuado
7	7	Inadecuado	16	Adecuado
8	12	Poco adecuado	18	Adecuado
9	11	Poco adecuado	17	Adecuado
10	11	Poco adecuado	15	Poco adecuado
11	16	Adecuado	18	Adecuado
12	11	Poco adecuado	17	Adecuado
13	12	Poco adecuado	19	Adecuado
14	16	Adecuado	20	Adecuado

Escala auto-calificativa		Después				Total	
		No satisfactorio		Satisfactorio			
		No.	%	No.	%	No.	%
Antes	Satisfactorio	0	0	3	21,4	3	21,4
	No satisfactorio	3	21,4	8	57,1	11	78,6
Total		3	21,4	11	78,6	14	100


Escala auto-calificativa
Puntuaciones
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Estudiantes
Antes
Después

ANEXO no. 5

HOSPITAL GENERAL DR. JUAN BRUNO ZAYAS ALFONSO

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE MEDICINA

Objetivo: Obtener información primaria de los aspectos en la formación ético-profesional del estudiante de Medicina en los escenarios profesionales, donde interactúa con el paciente y sus familiares.

Año que cursa:

Facultad: _____

INTRODUCCIÓN

Estimado/a estudiantes nos hemos propuesto conocer sus criterios y juicios sobre la formación ético-profesional en su proceso formativo. De igual manera, el reconocimiento de sus figuras trascendentes y su ejemplo desde la labor educativa. Socialmente se ha creado una disyuntiva en el modo de actuación del estudiante de Medicina, persiste una demanda intransigente de la sociedad, que se expresa en reclamos sociales en torno a los comportamientos éticos de los estudiantes.

Su identificación es anónima y sus respuestas se entregarán solo a los responsables de la investigación. Sus criterios contribuirán al perfeccionamiento en el proceso formativo. Se considera dos alternativas, bueno o malo, al final de la hoja puede dar sus consideraciones y se enumeran dos indicadores, es de sumo interés para la triangulación de esta investigación.

	ENCUESTA A ESTUDIANTES DE MEDICINA	Bueno (a)	Malo (a)
1	¿Cómo usted percibe su formación ético-profesional y la de sus colegas?		
2	¿Cómo usted considera que emplea habitualmente los valores éticos de compromiso, humanismo y consagración?		
3	¿Cómo es el papel desempeñado por sus profesores en su formación ético-profesional?		

4	¿Cómo aprecia el modo de actuación en usted y sus compañeros de año?		
5	¿Cómo valoras el ejemplo de tus profesores como figuras trascendentales en su proceso formativo?		
6	¿Cómo valoras las tareas orientadas desde el contenido ético-profesional en su proceso formativo?		
7	¿Cómo se usted considera usted en el cumplimiento de los valores emergidos de figuras trascendentales?		
8	¿Cómo percibe usted que es la formación de valores éticos-profesionales?		
	¿Exprese cualquier consideración o criterio que crea pertinente, o que puedan mejorar el desempeño investigativo para desarrollar la formación ético-profesional del estudiante de Medicina?		
Indicador 1	Mencione los valores que desearía que sus profesores contribuyan a desarrollar a través de su proceso formativo		
Indicador 2	Enumere cuatro cualidades que se corresponda con los valores señalados		

Muchas gracias por su colaboración.

Regla de decisión: Se realiza la suma de los ítems con respuestas de bueno (a):

- 7 u 8 ítems: adecuada formación ético-profesional del estudiante de Medicina en los escenarios profesionales, donde interactúan con el paciente y sus familiares.
- 5 o 6 ítems: poco adecuada formación ético-profesional del estudiante de Medicina en los escenarios profesionales, donde interactúan con el paciente y sus familiares.
- Menos de 5 ítems: inadecuada formación ético-profesional del estudiante de Medicina en los escenarios profesionales, donde interactúan con el paciente y sus familiares.

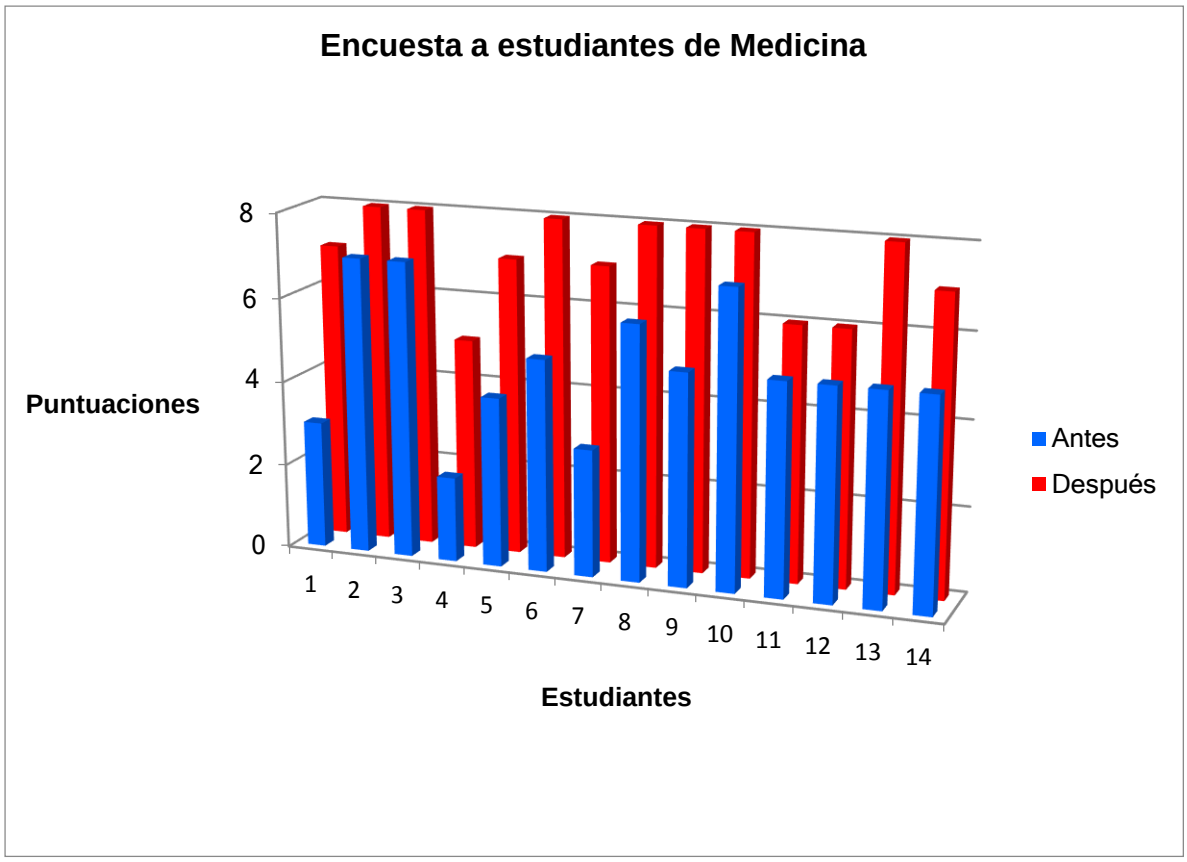
Resultados del Anexo No 5

Encuesta a estudiantes de Medicina		
Estudiante	**Antes**	**Después**

	Puntuación	**Evaluación**	**Puntuación**	**Evaluación**
1	3	Inadecuado	7	Adecuado
2	7	Adecuado	8	Adecuado
3	7	Adecuado	8	Adecuado
4	2	Inadecuado	5	Poco adecuado
5	4	Inadecuado	7	Adecuado
6	5	Poco adecuado	8	Adecuado
7	3	Inadecuado	7	Adecuado
8	6	Poco adecuado	8	Adecuado
9	5	Poco adecuado	8	Adecuado
10	7	Adecuado	8	Adecuado
11	5	Poco adecuado	6	Poco adecuado
12	5	Poco adecuado	6	Poco adecuado
13	5	Poco adecuado	8	Adecuado
14	5	Poco adecuado	7	Adecuado

-

Encuesta a estudiantes de Medicina		Después				Total	
		No satisfactorio		Satisfactorio			
		No.	%	No.	%	No.	%
Antes	Satisfactorio	0	0	3	21,4	3	21,4
	No satisfactorio	3	21,4	8	57,1	11	78,6
Total		3	21,4	11	78,6	14	100


Encuesta a estudiantes de Medicina
Puntuaciones
8
6
4
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Estudiantes
Antes
Después

ANEXO no. 6

HOSPITAL GENERAL DR. JUAN BRUNO ZAYAS ALFONSO

ENCUESTA A ESPECIALISTAS-DOCENTES Y PROFESORES

Objetivo: Obtener información primaria de los aspectos en la formación ético-profesional del estudiante de Medicina en los escenarios profesionales, donde interactúa con el paciente y sus familiares.

Título académico:

Año de experiencia:

Servicio en el que trabaja: _____

INTRODUCCIÓN

Estimado/a profesional con el propósito del mejoramiento de la formación ético-profesional del estudiante de Medicina en los escenarios profesionales, donde interactúa con el paciente y sus familiares, nos hemos propuesto conocer sus criterios y juicios sobre el proceso formativo y su conducción en las actividades en la educación en el trabajo. Se ha creado una disyuntiva en cómo debe actuar el estudiante de Medicina según su encargo social, lo que en muchas ocasiones deja un contiguo de opiniones negativas, para la cual le solicitamos responder esta encuesta según sus criterios. Su identificación es anónima y sus respuestas se entregarán solo a los responsables de la investigación.

Sus criterios contribuirán al mejoramiento de los servicios y a la formación ético-profesional del estudiante de Medicina en los escenarios profesionales, donde interactúa con el paciente y sus familiares. Se consideran dos alternativas positivo y negativo.

No	ASPECTOS	Positivo	Negativo
1	¿Cómo percibe la formación ético-profesional del estudiante de Medicina?		

2	¿Cómo se conducen lo ético-profesional en el proceso formativo del estudiante de Medicina?		
3	¿Cómo aprecia, el modo de actuación del estudiante de Medicina en los escenarios profesionales, donde interactúa con el paciente y sus familiares?		
4	¿Cómo valora los comportamientos éticos del estudiante de Medicina donde interactúa con el paciente y sus familiares?		
5	Si usted tuviese que valorar el tratamiento de la formación ético-profesional del estudiante de Medicina desde los contenidos éticos ¿Cómo lo valorarías?		
6	¿Cómo evalúa las acciones en el proceso formativo para potenciar desde los ejemplos de figuras trascendentes la formación ético-profesional del estudiante de Medicina?		
7	¿Creé que es necesario la trasformación de lo ético-profesional del estudiante de Medicina en el proceso formativo?		
8	Valore usted ¿Se intencionan vías y métodos desde la estrategia educativa el desarrollo de lo ético-profesional?		
	Exprese cualquier consideración o criterio que crea pertinente, o que puedan mejorar el desempeño investigativo para desarrollar la formación ético-profesional del estudiante de Medicina.		

Muchas gracias por su colaboración.

Regla de decisión: Se realiza la suma de los ítems con respuestas de bueno(a):

- De 6-8 ítems: adecuada formación ético-profesional.
- Menos de 6 ítems: inadecuada formación ético-profesional.

ANEXO No. 7

ENTREVISTA PARA SER APLICADA A AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE INSTITUCIONES DE SALUD Y UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Objetivo: Obtener información primaria sobre el proceso de formación ético-profesional del estudiante de Medicina.

Título académico: _____

Lugar donde labora_____

Cargo que ostenta _____

INTRODUCCIÓN

Estimado Directivo, considera Usted, que la pérdida de valores éticos del estudiante de Medicina ha perdido importancia en el proceso de su formación profesional, comprometida con el mejoramiento de la calidad de los servicios y dentro de estas en la atención integral a pacientes y sus familiares.

Realizamos esta investigación, para la cual solicitamos sus criterios en las temáticas que a continuación se relacionan. Considere que los temas que se plantean sólo constituyen pautas para la entrevista y que la mayor riqueza estará en sus aportes, con los cuales decididamente contribuirá al propósito antes expresado.

TEMAS

1. ¿Cuáles son los valores éticos que, a su juicio, deben de desarrollarse en el proceso formativo del estudiante de Medicina?
2. ¿Qué elementos Usted cree que deben formar parte del proceso de formación ético-profesional del estudiante de Medicina?
3. Consideraciones y sugerencias para potenciar, fortalecer y desarrollar la formación ético-profesional del estudiante de Medicina.

Quedamos agradecidos por sus contribuciones.

ANEXO No. 8

TALLERES DE SOCIALIZACIÓN

Primer momento por el que transitó el taller de socialización con los especialistas-docentes y profesores se realizaron las siguientes acciones:

Compañero (a):

Para realizar una investigación encaminada a la elaboración de un modelo de la dinámica ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida, le enviamos un resumen acerca del proyecto que se ha elaborado.

Necesitamos que nos exponga sus criterios en cuanto a los siguientes aspectos del modelo propuesto.

- Exposición de los fundamentos modelo de formación ético-profesional del estudiante de Medicina desde los ejemplos de Historias de Vida, y de la metodología para la formación ético-profesional del estudiante de Medicina.
- Dimensiones y configuraciones que conforman el modelo que se propone.
- Posibilidades de aplicación práctica del modelo propuesto.
- Adecuación del modelo y las acciones de la metodología de Sistematización Generalizadora desde Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina, a la preparación general del personal que lo ejecutará.
- Etapas y acciones a desarrollar en la metodología.
- Grado de sistematización de las acciones de la metodología.
- Valor formativo de las acciones.
- Criterios a seguir para la evaluación del estudiante (niveles propuestos).
- Interrelación entre las etapas de la metodología y el modelo.
- Posibilidades que brinda la metodología para la formación ético-profesional del estudiante de Medicina.

- Posibilidades de aplicación en otros contextos.

La escala en que usted debe evaluar cada uno de los aspectos anteriormente señalados es la siguiente:

Muy adecuado, Bastante adecuado, Adecuado, Poco adecuado, No adecuado.

En el caso de que usted considere que el aspecto no se evalúe como Muy adecuado o como Bastante adecuado, le rogamos que envíe sus criterios para proceder a reelaborar esos aspectos en el modelo que se confecciona.

En un segundo momento del taller de socialización con los especialistas-docentes y profesores.

Estimado colega:

Le agradecemos su interés por nuestra investigación y sus sugerencias, como resultado del primer contacto con ustedes, los aspectos referidos a:

- Dimensiones y configuraciones que conforman el modelo que se propone.
- Adecuación del modelo y las acciones de la metodología a la preparación general del personal que lo ejecutará.

Se procedió a:

- Intercambiar entre los especialistas-docentes, profesores y la autora, a través de la exposición de criterios valorativos, preguntas y respuestas, acerca de las principales fortalezas y debilidades de los aportes, así como acertadas sugerencias para su perfeccionamiento.
- Realizar la relatoría del debate de conocimientos y propuestas prácticas por razón de intervenciones de los participantes desde un diálogo productivo.

En el documento de relatoría confeccionado, se evidencian las siguientes ideas:

- Los Expertos consideraron oportuna la elaboración de la metodología que se propone, para perfeccionar la estrategia educativa con que se cuenta en la Universidad Médica, en función de la atención al desarrollo de los comportamientos éticos del estudiante de Medicina en los escenarios profesionales, donde interactúa con el

paciente y sus familiares.

- En la realización de los talleres, se observó la necesidad de los tutores y profesores de concientizar su función educativa en el acompañamiento a los estudiantes; en cuanto a la autoformación humanista, mostraron interés al cambio, fueron conservadores, sobre todo en la realización de los encuentros, interviniendo según sus criterios, la carencia de espacio y de tiempo.

- **ANEXO No. 9**

- **Evidencias de los talleres de socialización con los especialistas-docentes**





ANEXO No. 10

Expresión de los logros esturados en niveles para la formación ético-profesional del estudiante de Medicina

1. Nivel de sensibilización del compromiso social-responsable.

INDICADORES	PATRONES DE LOGROS	ESCALA EVALUATIVA		
		Bueno	Regular	Malo
1.1 Potencialidades para el desarrollo de atención integral a pacientes	✓ Desarrollo del interrogatorio y examen físico al paciente para el diagnóstico de enfermedades. ✓ Competencia en el desempeño profesional, aptitud y compromiso con el paciente.			
1.2 Nivel de consolidación de los valores compromiso, consagración y humanismo	✓ Empleo acertado del método clínico-epidemiológico para un abordaje interventivo de las enfermedades. ✓ Relaciones empáticas entre los pacientes y sus familiares.			

2. Nivel de Orientación de la actividad clínico-trasformadora.

INDICADORES	PATRONES DE LOGROS	ESCALA EVALUATIVA		
		Bueno	Regular	Malo
2.1 Logro de una práctica clínico interventiva	✓ Calidad en la orientación educativo-preventiva a pacientes y sus familiares. ✓ Empleo correcto de la terapéutica curativo-preventivo a los pacientes con el fin de reducir dolor y molestias.			
2.2 Potencialidades de los valores emergidos de las Historias de Vida de figuras trascendentes de la Medicina como incentivo en el proceso formativo	✓ Potencialidades creativas para la incorporación de comportamientos éticos y modo de actuación responsabilidad hacia el paciente y sus familiares en la atención integral. ✓ Nivel de autonomía demostrado en la atención integral a pacientes desde lo interventivo.			

3. Nivel de trascendencia del humanismo médico.

INDICADORES	PATRONES DE LOGROS	ESCALA EVALUATIVA		
		Bueno	Regular	Malo
3.1 Nivel de la praxis ético-profesional	✓ Evaluación de la pertinencia e impacto de las acciones interventiva realizadas para mejorar la			

	calidad en la atención integral a pacientes. ✓ Nivel de autonomía, compromiso, consagración y responsabilidad con los pacientes y sus familiares. ✓ búsqueda creativa de soluciones a los problemas en los escenarios profesionales, donde interactúa con los pacientes y sus familiares.			
3.2 Logro de la excelencia clínico-trasformadora en la atención integral a pacientes	✓ Comportamiento sistematizado, que se refiere a la existencia y esencia del humanismo médico, de esa sensibilidad humana y espiritualidad en la atención integral a pacientes. ✓ Calidad en la relación médico-paciente-familia a partir del empleo de una comunicación positiva y empática desde el respeto a la dignidad e integridad humana. ✓ Búsqueda de soluciones con unan visión interventiva para el manejo de enfermedades complejas.			

Según la escala evaluativa, los ítems de cada indicador correspondiente a los niveles de evaluación tendrán un valor entre 0 y 2 puntos, como se expone a continuación:

- Si la respuesta del ítem es buena: se otorga un valor de 2 puntos.
- Si la respuesta es regular: el ítem tiene un valor de 1 punto.
- Si la respuesta es mal: se califica como 0 puntos.

Los niveles 1 y 2 que tienen dos indicadores, y a su vez cada indicador tiene dos ítems, los indicadores tendrán valores entre 0 y 4 puntos.

El nivel 3 que está conformado por dos indicadores de tres ítems cada uno, entonces cada indicador tendrá un valor entre 0 y 6 puntos.

Al finalizar se realiza la suma total de todas las puntuaciones de cada ítem, obteniéndose valores entre 0 y 28 puntos.

Regla de decisión:

- De 24-28 puntos: formación ético-profesional del estudiante de Medicina adecuada.
- De 20-23 puntos: formación ético-profesional del estudiante de Medicina poco adecuada.
- Menos de 20 puntos: formación ético-profesional del estudiante de Medicina inadecuada.

TABLA 1: Análisis de los niveles de evaluación de la formación ético-profesional del estudiante de Medicina en la educación en el trabajo donde interactúan con el paciente y sus familiares antes de la aplicación de la metodología.

Nivel 1. Sensibilización del compromiso social-responsable.						
Indicador	Escala evaluativa					
	Bueno		Regular		Malo	
	No.	%	No.	%	No.	%
1.1 a	7	50,0	6	42,9	1	7,1
1.1 b	6	42,9	7	50,0	1	7,1
1.2 a	5	35,7	7	50,0	2	14,3
1.2 b	7	50,0	6	42,9	1	7,1
Nivel 2. Orientación de la actividad clínico-trasformadora.						
Indicador	Escala evaluativa					
	Bueno		Regular		Malo	
	No.	%	No.	%	No.	%
2.1 a	8	57,1	6	42,9	0	0,0
2.1 b	8	57,1	4	28,6	2	14,3
2.2 a	9	64,3	5	35,7	0	0
2.2 b	9	64,3	3	21,4	2	14,3
Nivel 3. Trascendencia del humanismo médico.						
Indicador	Escala evaluativa					
	Bueno		Regular		Malo	
	No.	%	No.	%	No.	%
3.1 a	6	42,9	7	50,0	1	7,1

3.1 b	10	71,4	4	28,6	0	0,0
3.1 c	6	42,9	8	57,1	0	0,0
3.2 a	6	42,9	7	50,0	1	7,1
3.2 b	8	57,1	6	42,9	0	0
3.2 c	8	57,1	6	42,9	0	0

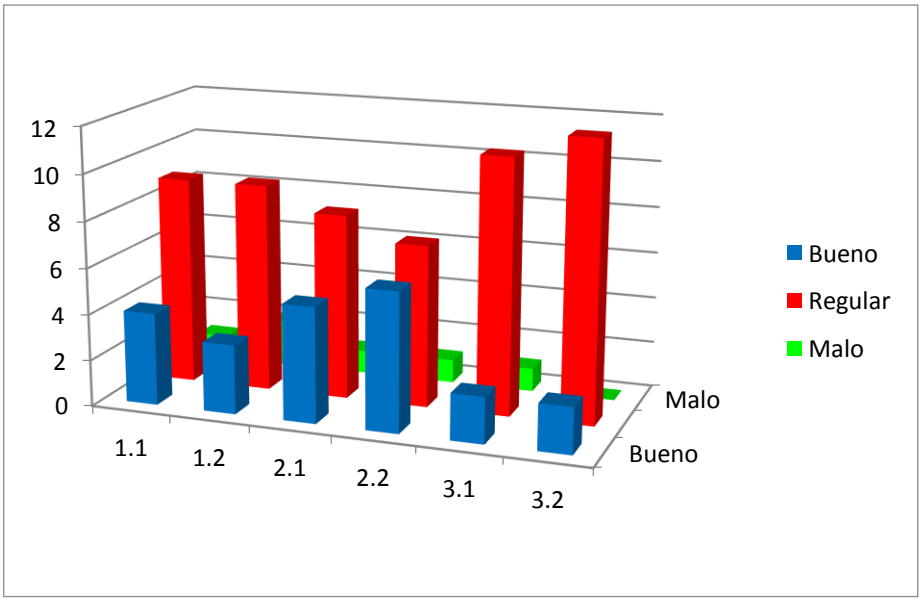
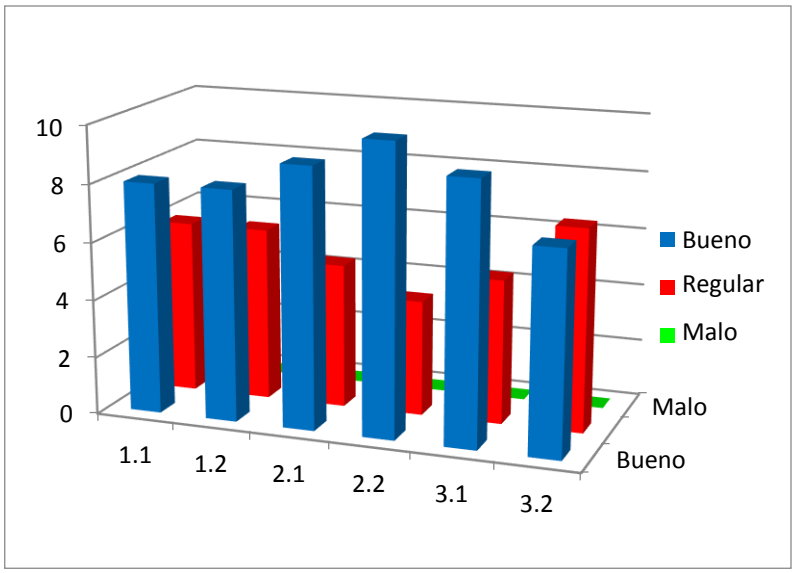


TABLA 2: Análisis de los niveles de evaluación de la formación ético-profesional del estudiante de Medicina en la educación en el trabajo donde interactúan con el paciente y sus familiares después dela aplicación de la metodología.

Nivel 1. Sensibilización del compromiso social-responsable.						
Indicador	Escala evaluativa					
	Bueno		Regular		Malo	
	No.	%	No.	%	No.	%
1.1 a	11	78,6	2	14,3	1	7,1
1.1 b	11	78,6	3	21,4	0	0

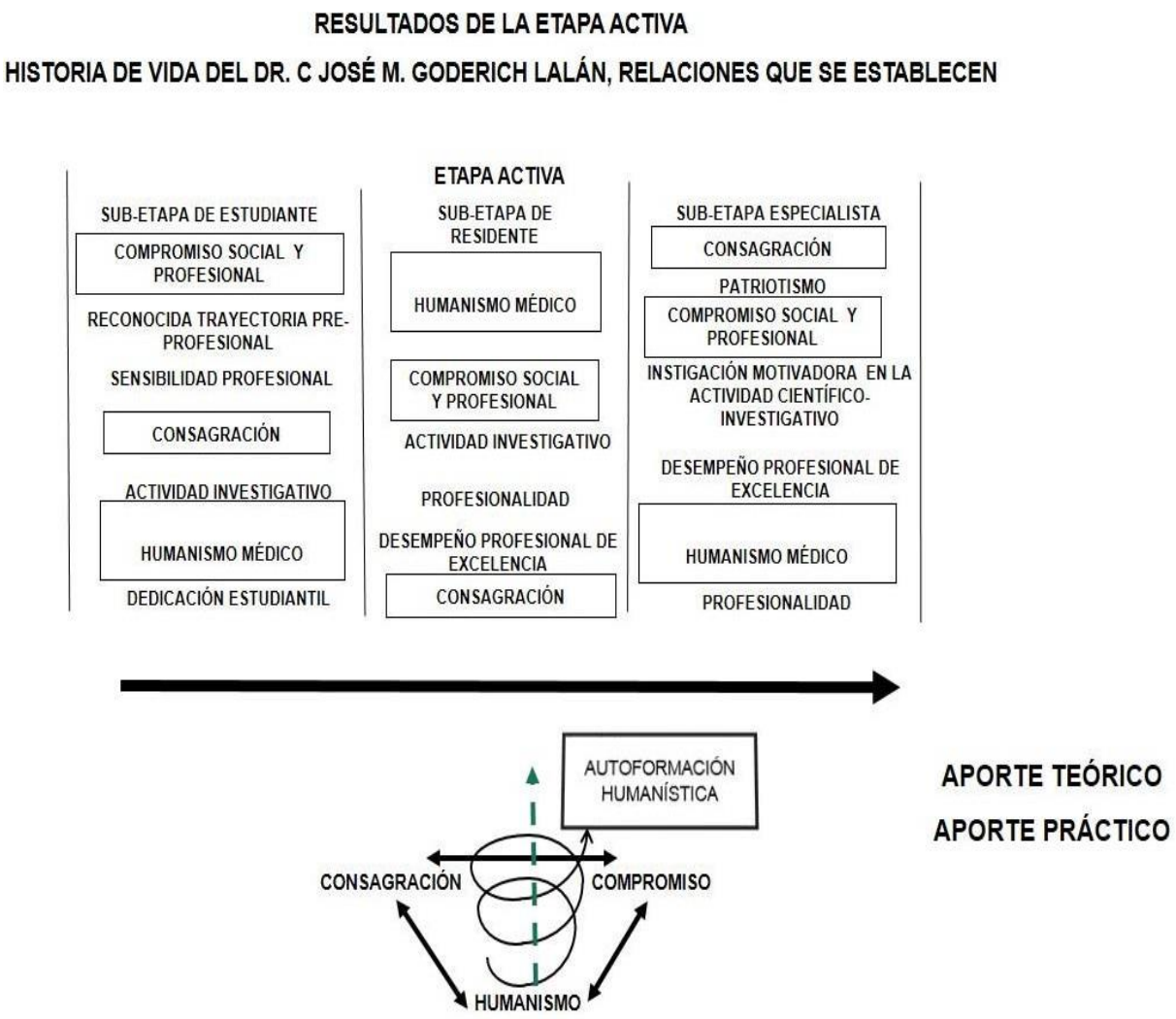
1.2 a	10	71,4	3	21,4	1	7,1
1.2 b	11	78,6	2	14,3	1	7,1
Nivel 2. Orientación de la actividad clínico-trasformadora.						
Indicador	Escala evaluativa					
	Bueno		Regular		Malo	
	No.	%	No.	%	No.	%
2.1 a	13	92,9	1	7,1	0	0
2.1 b	10	71,4	3	21,4	1	7,1
2.2 a	12	85,7	2	14,3	0	0
2.2 b	11	78,6	3	21,4	0	0
Nivel 3. Trascendencia del humanismo médico.						
Indicador	Escala evaluativa					
	Bueno		Regular		Malo	
	No.	%	No.	%	No.	%
3.1 a	12	85,7	2	14,3	0	0,0
3.1 b	12	85,7	1	7,1	1	7,1
3.1 c	13	92,9	1	7,1	0	0
3.2 a	11	78,6	3	21,4	0	0
3.2 b	13	92,9	1	7,1	0	0
3.2 c	11	78,6	3	21,4	0	0



Estudiante	Puntuación Total		Clasificación	
	Antes	Después	Antes	Después
1	16	25	Inadecuado	Adecuado
2	25	28	Adecuado	Adecuado
3	24	26	Adecuado	Adecuado
4	17	21	Inadecuado	Poco adecuado
5	20	23	Poco adecuado	Adecuado
6	22	26	Poco adecuado	Adecuado
7	16	26	Inadecuado	Adecuado
8	20	25	Poco adecuado	Adecuado
9	22	28	Poco adecuado	Adecuado
10	22	24	Poco adecuado	Adecuado
11	22	24	Poco adecuado	Adecuado
12	21	24	Poco adecuado	Adecuado
13	20	25	Poco adecuado	Adecuado
14	22	27	Poco adecuado	Adecuado

ANEXO No. 11

Representación de las relaciones que se establecen en la Historia de Vida profesional del Dr. C José M. Goderich Lalán.





I ETAPA DE ESTUDIANTE DE MEDICINA 1961-1967







II ETAPA/ PROFESIONAL 1967-1992







II ETAPA/ PROFESIONAL 1967-1992





III ETAPA/ ESPECIALISTA CONSAGRADO-RELEVANTE 1992-2017 (ÓBITO)









III ETAPA/ ESPECIALISTA CONSAGRADO-RELEVANTE 1992-2017 (ÓBITO)





III ETAPA/ ESPECIALISTA CONSAGRADO-RELEVANTE 1992-2017 (ÓBITO)

ANEXO No. 12

Selección y aplicación de una prueba estadística apropiada para evaluar la metodología

Para evaluar la metodología, se empleó el test de McNemar, que es prueba no paramétrica de comparación de proporciones para muestras pareadas o relacionadas. Esta prueba se utiliza cuando la variable dependiente o de respuesta es nominal dicotómica, lo que coincide con las características de la presente investigación. Este test permitió evaluar los resultados de la metodología aplicada y comparar si se producen cambios significativos entre las dos muestras (antes y después de la intervención o metodología.

Para probar la significación de cualquier cambio observado, se elaboró una tabla donde se muestran los valores observados en las variables analizadas antes y después de aplicada la metodología (Tabla 1).

Tabla 1 Tabla de frecuencias para probar la significación de los cambios.

		DESPUÉS	
		-	+
ANTES	+	A	B
	-	C	D

Se consideró como categoría (+) o satisfactorio, si se cumplen los siguientes criterios:

- El análisis de los niveles de evaluación de la formación ético-profesional del estudiante de Medicina es adecuado.
- Si en las heteroevaluaciones resultan adecuados la encuesta a pacientes y familiares y al menos una de las dos guías de observación que recogen los criterios de los profesores (guía de observación directa, encubierta y discreta y/o la guía de observación sistemática.
- Si al menos una de las dos autoevaluaciones es adecuada (la escala autocalificativa o la encuesta a estudiantes de Medicina).

No satisfactoria: Si no se cumplen los tres criterios anteriores.

Para el trabajo en SPSS se empleó el valor 0 para la categoría no satisfactorio y 1 para satisfactorio.

La celda A: se encuentran los estudiantes de Medicina que antes de aplicar la metodología obtuvieron resultados satisfactorios y después de la misma no satisfactorios.

La celda B: se encuentran los estudiantes que tanto antes como después de la metodología obtuvieron resultados satisfactorios.

La celda C: aparecen los estudiantes que antes y después de aplicada la metodología obtuvieron resultados no satisfactorios.

La celda A: se encuentran los estudiantes que antes de aplicar la metodología obtuvieron resultados no satisfactorios y después de la misma los resultados fueron satisfactorios, lo cual sería el principal objetivo de la investigación.

Las celdas A y D resultaron ser las celdas activas, ya que son las que muestran cambios en los resultados.

Cada participante se clasificó en las celdas correspondientes (A, B, C, D), según los resultados de cada momento de la metodología (antes y después), como se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Estudiantes según resultado antes y después de aplicada la metodología.

Estudiante	Respuesta antes	Respuesta después	Celda de ubicación
1	No satisfactoria (0)	Satisfactoria (1)	D
2	No satisfactoria (0)	Satisfactoria (1)	D
3	No satisfactoria (0)	Satisfactoria (1)	D
4	No satisfactoria (0)	Satisfactoria (1)	D
5	No satisfactoria (0)	Satisfactoria (1)	D
6	No satisfactoria (0)	Satisfactoria (1)	D
7	No satisfactoria (0)	Satisfactoria (1)	D
8	No satisfactoria (0)	Satisfactoria (1)	D
9	Satisfactoria (1)	Satisfactoria (1)	B
10	No satisfactoria (0)	Satisfactoria (1)	D
11	No satisfactoria (0)	Satisfactoria (1)	D
12	No satisfactoria (0)	No satisfactoria (0)	C
13	No satisfactoria (0)	Satisfactoria (1)	D
14	No satisfactoria (0)	Satisfactoria (1)	D

ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS INSTRUMENTOS (ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA)

Estudiante	Heteroevaluación			Autoevaluación			
	Guía observación directa, encubierta y discreta	**Encuestas a pacientes y familiares**	**Guía observación sistemática**	**Escala auto-califcativa**	**Encuesta a estudiantes**	**Evaluación integral**	**Eval**
1	Inadecuado	Inadecuado	Inadecuado	Inadecuado	Inadecuado	**No satisfactoria**	**16**
2	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	**Satisfactoria**	**25**
3	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Poco adecuado	Adecuado	**Satisfactoria**	**24**
4	Inadecuado	Inadecuado	Inadecuado	Inadecuado	Inadecuado	**No satisfactoria**	**17**
5	Inadecuado	Inadecuado	Inadecuado	Poco adecuado	Inadecuado	**No satisfactoria**	**20**
6	Inadecuado	Adecuado	Inadecuado	Poco adecuado	Poco adecuado	**No satisfactoria**	**22**
7	Inadecuado	Inadecuado	Inadecuado	Inadecuado	Inadecuado	**No satisfactoria**	**16**
8	Inadecuado	Inadecuado	Inadecuado	Poco adecuado	Poco adecuado	**No satisfactoria**	**20**
9	Adecuado	Inadecuado	Adecuado	Poco adecuado	Poco adecuado	**No satisfactoria**	**22**
10	Inadecuado	Adecuado	Inadecuado	Poco adecuado	Adecuado	**No satisfactoria**	**22**
11	Inadecuado	Adecuado	Inadecuado	Adecuado	Poco adecuado	**No satisfactoria**	**22**
12	Inadecuado	Adecuado	Inadecuado	Poco adecuado	Poco adecuado	**No satisfactoria**	**21**
13	Inadecuado	Inadecuado	Inadecuado	Poco adecuado	Poco adecuado	**No satisfactoria**	**20**
14	Adecuado	Inadecuado	Adecuado	Adecuado	Poco adecuado	**No satisfactoria**	**22**

ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS INSTRUMENTOS (DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA)

Estudiante	Heteroevaluación			Autoevaluación			
	Guía observ directa, encubierta y discreta	Encuestas a pacientes y familiares	Guía observación sistemática	Escala autocalif	Encuesta a estudiantes	**Evaluación integral**	**Eval**
1	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	**Satisfactoria**	**25**
2	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	**Satisfactoria**	**28**
3	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	**Satisfactoria**	**26**
4	Inadecuado	Inadecuado	Inadecuado	Poco adecuado	Poco adecuado	**No satisfactoria**	**21**
5	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Poco adecuado	Adecuado	**Satisfactoria**	**23**
6	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	**Satisfactoria**	**26**
7	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	**Satisfactoria**	**26**
8	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	**Satisfactoria**	**25**
9	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	**Satisfactoria**	**28**
10	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Poco adecuado	Adecuado	**Satisfactoria**	**24**
11	Inadecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Poco adecuado	**Satisfactoria**	**24**
12	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Poco adecuado	**Satisfactoria**	**24**
13	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	**Satisfactoria**	**25**
14	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	**Satisfactoria**	**27**

Estudiante	**Puntuación Total**		**Clasificación**	
	Antes	**Después**	**Antes**	**Después**
1	**16**	**25**	**Inadecuado**	**Adecuado**

2	**25**	**28**	**Adecuado**	**Adecuado**
3	**24**	**26**	**Adecuado**	**Adecuado**
4	**17**	**21**	**Inadecuado**	**Poco adecuado**
5	**20**	**24**	**Poco adecuado**	**Adecuado**
6	**22**	**26**	**Poco adecuado**	**Adecuado**
7	**16**	**26**	**Inadecuado**	**Adecuado**
8	**20**	**25**	**Poco adecuado**	**Adecuado**
9	**22**	**28**	**Poco adecuado**	**Adecuado**
10	**22**	**24**	**Poco adecuado**	**Adecuado**
11	**22**	**24**	**Poco adecuado**	**Adecuado**
12	**21**	**24**	**Poco adecuado**	**Adecuado**
13	**20**	**25**	**Poco adecuado**	**Adecuado**
14	**22**	**27**	**Poco adecuado**	**Adecuado**

Tabla 3. Resultado de la metodología aplicada a los estudiantes de Medicina.

Evaluación integral de los estudiantes de Medicina		Después				Total	
		No satisfactorio		Satisfactorio			
		No.	%	No.	%	No.	%
Antes	Satisfactorio	0	0	2	14,3	2	14,3
	No satisfactorio	1	7,1	11	78,6	12	85,7
Total		1	7,1	13	92,9	14	100

p=0,001

Como se muestra en la tabla 3, en 11 estudiantes de Medicina que representa el mayor porcentaje (78,6 %), se logró modificar con la metodología, la evaluación integral de los mismos en cuanto a sus comportamientos éticos en los escenarios profesionales donde interactúan con el paciente y sus familiares. Hubo dos estudiantes para un 14,3 %

que, en ambos momentos, es decir, tanto antes como después de la intervención, se evaluaron de satisfactorios y solo un estudiante en ambos momentos se encontró en la categoría no satisfactoria ya que después aplicar la metodología solo obtuvo una respuesta adecuada en uno de los tres instrumentos aplicados.

ANEXO No. 13

Talleres de formación ético-profesional con estudiantes de Medicina (Evidencia)







Anexo No. 14

Avales que evidencian la Sistematización y Generalización de la metodología para la formación ético-profesional del estudiante de Medicina, aportes. (Evidencia)

Aval al resultado: Aportes de las investigaciones pedagógicas a la Educación Médica Cubana

Autores: MS.c Yaité Zaldivar Rosales
Dr. Cs. Homero Calixto Fuentes González
Dra. C. María Eugenia García Céspedes

Del Dr. Omar Bizet Altés.

Director del Hospital General "Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso.

El resultado "Formación ético-profesional del estudiante de medicina desde historias de vida de figuras trascendentes,"desarrollado en nuestro Hospital General "Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso" da cuenta del papel importante que esto adquiere en el proceso formativo del estudiante de medicina, de ahí su significado en el proceso formativo profesional, como el camino para promover el ideal de sociedad que se aspira alcanzar y el desarrollo integral en el proceso del médico.

Los autores han desarrollado un trabajo de sistematización, que se evaluó y sistematizó para aportarnos un instrumento de evaluación conducente a tesis de doctorado en Ciencias de varias modalidades, que deviene en una herramienta para el trabajo en el ámbito de la educación en Salud y el rescate de la historia de la medicina y de sus figuras trascendentes

Cabe significar que los aportes de los estudios realizados y el instrumento puedes ser aplicado a otras instituciones de Salud, así como generalizable a otras instituciones de nivel superior.

Santiago de Cuba 17 de noviembre de 2022

Dr. Omar Bizet Altés.

Director General



Aval al resultado: Aportes de las investigaciones pedagógicas a la Educación Médica Cubana

Autores: Lic. Yaité Zaldivar Rosales
Dr. Cs. Homero Calixto Fuentes González
Dra. C. María Eugenia García Céspedes

Del Dr. Joaquín Álvarez Denis

Presidente del Comité de Ética Médica de la Dirección provincial de Salud

Presidente del Comité de Ética Médica del Hospital General "Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso"

Sirva el presente aval para reconocer la significación de "Formación ético-profesional del estudiante de medicina desde Historias de vida de figuras trascendentes," al aportar un instrumento que permita el rescate de la Historia de la Medicina y de sus figuras trascendentes, investigación conducente a tesis de doctorado en Ciencias de varias modalidades en las transformaciones en las universidades médicas, lo que contribuye al perfeccionamiento de formación de profesionales de la salud, en lo asistencial, docente e investigativo.

El citado resultado es producto de un riguroso trabajo investigativo que se desarrolla en el Hospital General "Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso" en el proceso de formación de investigadores y de Doctores en diferentes áreas del conocimiento (Dr. C.), lo que se evidencia en la calidad de la asistencia, la docencia y la investigación.

Santiago de Cuba 17 de noviembre de 2022

Dr. Joaquín Álvarez Denis

Dr. Joaquín Alvarez Denis
93034

UNIDAD PRESUPUESTADA
HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO DE CUBA
RESOLUCION No. 92 / 2020

POR CUANTO: La Resolución No. 192 de fecha 18 de octubre del 2007 dictada por el ex director de la entidad aprobó y puso en vigor el Reglamento Funcional Interno del centro asistencial estableciendo en su artículo 56 que el director como máxima autoridad del hospital tiene entre las atribuciones y funciones la de delegar en los dirigentes y funcionarios el cumplimiento de determinadas funciones.

POR CUANTO: Resulta necesario el fortalecemiento de la Gestión Nacional de archivos y el rescate de la memoria histórica, para agrupar las instituciones que preservan el patrimonio documental y la protección del patrimonio histórico.

POR CUANTO: Mediante el Decreto-Ley No 265 de 8 de abril del 2009, se aprovaron las disposiciones generales para la protección del Patrimonio Documental en el territorio nacional, generada por personas jurídicas, designar a la persona que fungirá como presidenta y vicepresidente de la Catedra de Historia de la Medicina y sus figuras trascendentes, del centro asistencial, procediendo como oportunamente se dirá.

POR CUANTO: Por el Acuerdo No. 1024-VI de fecha 24 de enero de 1991 emitido por el extinto Comité Ejecutivo de la Asamblea Provincial del Poder Popular Provincial en Santiago de Cuba, se creó el Hospital General de Santiago de Cuba, con personalidad jurídica propia.

POR CUANTO: Mediante Resolución No. 21 de fecha 12 de febrero del 2010, emitida por el Director Provincial de Salud Pública de Santiago de Cuba, fue designado el que resuelve en el cargo de Director General del Hospital General de Santiago de Cuba, con los deberes, funciones y facultades inherentes al cargo.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas

RESUELVO

PRIMERO: **Designar** a la Lic. Yaité Zaldívar Rosales como presidenta de la Catedra de Historia de la Medicina y su figuras trascendentes, así como al Dr. Joaquin Álvarez Denis como vicepresidente de dicha catedra del centro asistencial.

SEGUNDO: Las designadas estará en la obligación de informar al que resuelve del resultado de su gestión en el sentido expuesto en el apartado precedente.

NOTIFÍQUESE a la interesada a los efectos legales pertinentes.

COMUNÍQUESE a Jefa del Departamento de Docencia e Investigación del centro asistencial y a cuantas personas naturales y/o jurídicas sean procedentes

ARCHÍVESE el original en el consecutivo de resoluciones de la Entidad.

DADA: En el Hospital General de Santiago de Cuba a los 15 días del mes de JULIO del año 2020 "Año 62 de la Revolución".

Dr. Omar Bizet Altes
Director General

Hospital Dral. Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso
Dirección
Santiago de Cuba

Lic. María de las Nieves Sánchez López, Especialista en Derecho, inscripto al No. 11019 del MINJUS.
CERTIFICO: Que la presente es copia fiel del original que obra en el archivo jurídico de la dirección a mi cargo.
Dada en el Hospital Clínico Quirúrgico" General de Brigada Juan Bruno Sayas Alfonso" a los 15 días del mes Julio del 2020
"Año 62 de la Revolución"